

ENCICLOPÉDIA DE SEMIOLOGIA PEDIÁTRICA AVANÇADA

Sinais Patognômicos, Altamente Sugestivos e Achados Clínicos Discriminativos

Projeto Profissional Master de Alta Resolução — 18 Eixos Temáticos Especializados | 719 Correlações Clínicas

AVISO CLÍNICO E RECOMENDAÇÕES METODOLÓGICAS DE USO:

- Desempenho e Acuidade de Sinais Isolados:** Sinais semiológicos clássicos (Kernig, Brudzinski, Murphy, Psoas, Obturador) possuem sensibilidade heterogênea. A ausência de um sinal não descarta o diagnóstico, sobretudo em neonatos, lactentes jovens e imunossuprimidos.
- Sinal de Nikolsky:** Não define etiologia isoladamente. Distinguir a Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica (clivagem subcorneal intraepidérmica sem acometimento de mucosa) da Síndrome de Stevens-Johnson / NET (necrose dermoepidérmica de espessura total com mucosite grave hemorrágica).
- Língua em Framboesa:** Achado compartilhado entre Escarlatina, Doença de Kawasaki, Síndrome do Choque Tóxico e desidratação; correlacionar com o conjunto sintromático.
- Triagem de Maus-Tratos / Violência Física:** Nenhuma lesão isolada é 100% patognômica; a avaliação exige correlação com marcos do desenvolvimento psicomotor, mecanismo relatado e incongruência cronológica.
- Prioridade na Sala de Emergência:** Sinais de choque, insuficiência respiratória grave, coma, anafilaxia e abdome agudo cirúrgico impõem estabilização fisiológica imediata antes de qualquer confirmação diagnóstica definitiva.

1. INFECTOLOGIA, EXANTEMAS E ZOONOSES PEDIÁTRICAS (113 achados clínicos)

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Manchas de Koplik: Micropápulas branco-azuladas com halo eritematoso em mucosa jugal oposta aos molares inferiores, associadas a febre alta e tríade catarral (tosse, coriza, conjuntivite com fotofobia).	Sarampo (achado patognômico da fase prodrômica pré-exantemática).
Exantema morbiliforme com progressão craniocaudal estrita , com confluência em face e tronco superior, associado a febre alta que atinge o ápice junto ao exantema e descamação furfurácea tardia.	Sarampo .
Pseudomembrana amigdaliana/faríngea cinzento-esbranquiçada aderente que sangra profusamente à raspagem, com edema cervical difuso volumoso ('pescoço taurino') e toxemia grave.	Difteria (<i>Corynebacterium diphtheriae</i>).
Eritema facial em 'bochecha esbofetada' com palidez perioral (sinal de Filatow), evoluindo após 1-4 dias para exantema máculo-papular rendilhado/reticulado recidivante ao calor e sol.	Eritema infeccioso (Parvovírus B19).
Febre alta contínua de 3 a 5 dias com defervescência abrupta em crise , imediatamente sucedida pelo surgimento de exantema máculo-papular róseo não pruriginoso centrífugo.	Exantema súbito / Roséola infantil (Herpes-vírus humano tipo 6 e 7).
Polimorfismo lesional simultâneo (máculas, pápulas, vesículas em 'gota de orvalho sobre pétala de rosa', pústulas e crostas) com distribuição centrípeta e acometimento de couro cabeludo.	Varicela (Vírus Varicela-Zóster).
Exantema micropapular áspero em lixa , acentuação em dobras flexurais com linhas purpúricas transversais (Sinal de Pastia), palidez perioral (Sinal de Filatow) e Língua em framboesa .	Escarlatina (<i>Streptococcus pyogenes</i> / EGA).
Vesículas elípticas de eixo longo paralelo às linhas de clivagem da pele em palmas, plantas e nádegas, associadas a úlceras dolorosas em palato e pilares amigdalianos.	Doença Mão-Pé-Boca (Coxsackievírus A16, Enterovírus A71).
Vesículas e úlceras puntiformes exclusivas na porção posterior da orofaringe (palato mole, úvula e pilares tonsilares anteriores), poupando gengiva e lábios, com febre alta e odinofagia súbita.	Herpangina (Enterovírus / Coxsackievírus A).
Gengivite marginal difusa eritematosa e hemorrágica com vesículas confluentes e úlceras dolorosas em lábios, língua, palato duro e região perioral, com sialorreia e febre alta.	Gengivostomatite herpética primária (HSV-1).
Sinal de Forchheimer (enatema petequial puntiforme em palato mole) associado a linfadenopatia suboccipital, retroauricular e cervical posterior dolorosa e exantema róseo tênue.	Rubéola .
Tosse paroxística em acessos (estacato) culminando em guincho inspiratório estridente e vômito pós-tosse, com petéquias faciais e hemorragia subconjuntival, sem febre.	Coqueluche (<i>Bordetella pertussis</i>); diferencial: síndrome coqueluchoide.
Tosse seca em estacato em lactente afebril de 1 a 3 meses com taquipneia persistente, estertores crepitantes bilaterais e história prévia de conjuntivite com secreção seropurulenta.	Pneumonia afebril do lactente (<i>Chlamydia trachomatis</i>).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Estridor inspiratório, tosse metálica ladrante ('tosse de cachorro') e rouquidão de predomínio noturno precedidos por coriza leve e febre baixa.	Laringotraqueíte viral aguda / Crupe (Parainfluenza tipo 1 e 2).
Estridor inspiratório e expiratório (bifásico) com toxemia grave , febre alta persistente e secreção traqueal mucopurulenta espessa após quadro inicial de crupe viral refratário a adrenalina.	Traqueíte bacteriana (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i>).
Sialorreia volumosa, disfagia intensa, estridor inspiratório, voz abafada ('em batata quente') e postura em tripé com cabeça estendida e boca aberta (evitar abaixador de língua).	Epiglote aguda (<i>Haemophilus influenzae</i> b, estreptococos).
Trismo involuntário doloroso, riso sardônico (contratura espástica facial), abdome em tábua e opistótono desencadeados por estímulos mínimos (luz, som), com sensório preservado.	Tétano acidental ou neonatal (<i>Clostridium tetani</i>).
Vesículas agrupadas sobre base eritematosa estritamente na ponta ou asa lateral do nariz (Sinal de Hutchinson) associadas a dor neuropática e olho vermelho ipsilateral.	Herpes-zóster oftálmico (comprometimento do ramo nasociliar da divisão oftálmica de V1).
Eritema migratório : Pápula eritematosa única que se expande centrifugamente até atingir > 5 cm com bordas vermelhas e centro claro em anel ('olho de boi') após picada de carrapato <i>Ixodes</i> .	Doença de Lyme (<i>Borrelia burgdorferi</i>).
Febre alta prolongada (≥ 5 dias) + ≥ 4 critérios clássicos : conjuntivite bulbar bilateral não purulenta, queilite com fissuras e língua em framboesa, exantema polimorfo, edema/eritema acral e linfonodo cervical unilateral > 1,5 cm.	Doença de Kawasaki (risco de vasculite coronariana e ectasias).
Eritema macular difuso escarlatiniforme com hipotensão refratária , hiperemia conjuntival/mucosa, febre alta e descamação lamelar palmo-plantar tardia após 1 a 2 semanas.	Síndrome do Choque Tóxico (estafilocócica - toxina TSST-1 / estreptocócica).
Placas brancas aderentes à mucosa oral semelhantes a nata de leite coalhado que se soltam à raspagem deixando leito avermelhado e levemente sangrante.	Candidíase oral pseudomembranosa ('sapinho') (<i>Candida albicans</i>).
Odinofagia unilateral severa, trismo, sialorreia, voz abafada e desvio contralateral evidente da úvula com abaulamento do pilar amigdaliano anterior e palato mole.	Abscesso periamigdaliano / peritonsilar .
Torcicolo agudo febril, disfagia, odinofagia, hiperextensão do pescoço e abaulamento da parede posterior da faringe à inspeção orofaríngea em pré-escolar.	Abscesso retrofaringeo .
Exantema petequial e purpúrico fulminante de rápida progressão centrípeta com livedo reticular, extremidades frias e choque séptico hiperdinâmico/hipodinâmico em lactente toxêmico.	Meningococcemia / Sepse meningocócica (<i>Neisseria meningitidis</i>).
Erupção papular e pápulo-vesicular monomórfica não pruriginosa eritemato-acastanhada com distribuição simétrica em bochechas, nádegas e superfícies extensoras de extremidades em lactente afebril.	Síndrome de Gianotti-Crosti / Acrodermatite papular da infância (pós-EBV, HBV, Coxsackie).
Lesão papular eritematosa ou nódulo ulcerado primário acompanhado de linfadenite regional subaguda exuberante dolorosa que supura em 10-20%, após arranhadura ou mordedura de gato.	Doença da Arranhadura do Gato (<i>Bartonella henselae</i>).
Exantema máculo-papular eritematoso difuso pruriginoso confluyente que surge 7 a 10 dias após o início de amoxicilina ou ampicilina em adolescente com faringite e linfadenopatia.	Mononucleose infecciosa (Vírus Epstein-Barr - erupção induzida por aminopenicilina).
Febre alta prolongada, esplenomegalia maciça indolor, hepatomegalia moderada, palidez cutânea grave, pancitopenia e emagrecimento progressivo em área endêmica.	Leishmaniose visceral / Calazar (<i>Leishmania infantum chagasi</i>).
Febre alta remitente, dor abdominal intensa, bradicardia relativa em relação à febre (Sinal de Faget) , esplenomegalia e roséolas tíficas em tronco.	Febre tifoide (<i>Salmonella enterica</i> sorovar Typhi).
Petéquias palatinas e sublinguais, sufusão conjuntival sem secreção, mialgia intensa em panturrilhas, febre e icterícia rubínica com insuficiência renal oligúrica .	Leptospirose grave / Síndrome de Weil (<i>Leptospira interrogans</i>).
Exantema macular centrípeta que se inicia nos punhos e tornozelos no 3º a 5º dia de febre e evolui para petéquias e púrpuras em palmas e plantas com edema de mãos e pés pós-picada de carrapato-estrela.	Febre Maculosa Brasileira (<i>Rickettsia rickettsii</i>).
Sinal de Romaña : Edema palpebral unilateral bipalpebral violáceo e elástico com dacriocistite e adenopatia pré-auricular dolorosa ipsilateral após coçadura em região ocular.	Fase aguda da Doença de Chagas (<i>Trypanosoma cruzi</i>).
Úlcera cutânea única com bordas elevadas em moldura ('em cratera de vulcão') e fundo granuloso indolor em área exposta com adenomegalia satélite regional.	Leishmaniose tegumentar americana .

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Eritema anular marginado de Leiner: Lesões eritematosas circinadas evanescentes de bordas nítidas e centro pálido em tronco e raiz de membros, poupando face, associadas a poliartrite migratória e cardite.	Febre Reumática aguda (critério maior de Jones pós-faringite estreptocócica).
Coréia de Sydenham: Movimentos involuntários desordenados, rápidos e arrítmicos de extremidades, fraqueza muscular com sinal da pega de leiteira e labilidade emocional.	Febre Reumática aguda (manifestação tardia pós-estreptocócica).
Nódulos de Aschoff subcutâneos: Nódulos firmes, indolores, medindo de 0,5 a 2 cm sobre superfícies extensoras de ossos e tendões (cotovelos, punhos, joelhos, occipital) associados a cardite reumática severa.	Febre Reumática aguda.
Pápulas peroladas cupuliformes umbilicadas centralmente com eliminação de material grumoso esbranquiçado à compressão, distribuídas em tronco, axilas e região anogenital.	Molusco contagioso (Poxvírus).
Prurido anal noturno insidioso exacerbado associado a irritabilidade, escoriações perianais e visualização direta de pequenos vermes cilíndricos brancos móveis nas dobras perianais.	Enterobiose / Oxiúriase (<i>Enterobius vermicularis</i>).
Urticária serpigínea migratória com velocidade de progressão rápida de até vários centímetros por hora ('larva currens') na região glútea, perianal e coxas.	Estrongiloidíase cutânea (<i>Strongyloides stercoralis</i>).
Febre faringoconjuntival: Faringite exsudativa aguda, conjuntivite folicular não purulenta e febre alta de início súbito em pré-escolar, associada a adenopatia pré-auricular.	Infecção por Adenovírus (sorotipos 3 e 7).
Ceratoconjuntivite epidêmica: Quemose conjuntival intensa, hemorragia subconjuntival e infiltrados corneanos numulares subepiteliais com fotofobia e sensação de corpo estranho.	Adenovírus (sorotipos 8, 19 e 37).
Bronquiolite obliterante pós-infecçiosa (Síndrome do Pulmão Hipertransparente de Swyer-James): Taquipneia crônica, sibilância fixa persistente e atenuação em mosaico na TC de tórax pós-pneumonia necrotizante.	Sequela de infecção pulmonar por Adenovírus (tipos 3, 7 ou 21).
Impetigo crostoso clássico: Pápulas e vesículas que se rompem rapidamente originando crostas amareladas espessas aderentes em melicera (crostas melicéricas) em face ao redor da boca e nariz.	Impetigo não bolhoso (<i>Streptococcus pyogenes</i> e <i>Staphylococcus aureus</i>).
Impetigo bolhoso: Vesículas e bolhas flácidas de conteúdo claro a purulento que se rompem deixando colarete descamativo periférico sem crosta melicérica espessa.	Impetigo bolhoso estafilocócico (toxina esfoliativa de <i>Staphylococcus aureus</i> fago grupo II).
Ectima gangrenoso: Mácula eritematosa ou purpúrica de rápida progressão para bolha hemorrágica que se ulcera originando escara necrótica negra central com halo inflamatório em neutropênico.	Bacteremia por <i>Pseudomonas aeruginosa</i>.
Síndrome de Lemierre: Tromboflebite séptica supurativa da veia jugular interna associada a êmbolos sépticos pulmonares cavitados após faringoamigdalite aguda severa.	Infecção invasiva por <i>Fusobacterium necrophorum</i>.
Linfadenite tuberculosa cervical (Escrófula): Aumento ganglionar cervical unilateral subagudo, indolor, de consistência firme que fistuliza para a pele eliminando material caseoso esbranquiçado.	Tuberculose ganglionar (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>).
Complexo primário de Ghon: Nódulo parenquimatoso pulmonar periférico calcificado associado a linfonodomegalia hilar ipsilateral calcificada na radiografia de tórax.	Tuberculose primária curada/calcificada.
Meningite tuberculosa: Comprometimento subagudo insidioso de múltiplos pares cranianos (especialmente III, VI e VII) com Líquor com pleocitose linfomononuclear, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia.	Neurotuberculose com exsudato gelatinoso em base de crânio.
Tuberculose miliar: Micronódulos radiológicos pulmonares bilaterais difusos regulares de 1 a 3 mm ('em grãos de milho alvo/painço') associados a tubérculos de coróide à fundoscopia.	Tuberculose miliar disseminada.
Mal de Pott: Espondilite tuberculosa subaguda com destruição e colapso de corpos vertebrais torácicos anteriores resultando em cifose angular pontiaguda (giba dorsal).	Tuberculose óssea vertebral.
Síndrome de Löffler: Infiltrados pulmonares intersticiais transitórios migratórios fugazes associados a tosse seca espasmódica, sibilância e eosinofilia periférica acentuada (> 20-30%).	Ciclo pulmonar de parasitas intestinais (<i>Ascaris lumbricoides</i> , <i>Necator americanus</i> , <i>Strongyloides stercoralis</i>).
Suboclusão intestinal por Ascaris: Dor abdominal em cólica, distensão, vômitos e massa palpável móvel em abdome inferior com imagem radiográfica de miolo de pão ou novelo de lã.	Obstrução intestinal mecânica por novelo de <i>Ascaris lumbricoides</i>.
Larva migrans visceral: Febre persistente, hepatoesplenomegalia acentuada, sibilância recorrente, pneumonia intersticial e eosinofilia maciça crônica (> 30-50%) em criança com geofagia.	Toxocaríase (<i>Toxocara canis</i> ou <i>T. cati</i>).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Diarreia crônica fétida com esteatorreia, flatulência sulfurosa em ovo podre, distensão epigástrica e dor pós-prandial em pré-escolar frequentador de creche.	Giardiase (<i>Giardia lamblia</i>).
Fezes disentéricas em escarro amebiano com sangue vivo e muco abundante, tenesmo retal e dor em cólica com ausência de febre alta tóxica.	Amebíase intestinal (<i>Entamoeba histolytica</i>).
Abscesso hepático com drenagem de líquido marrom-escuro achocolatado inodoro em pasta de anchova associado a febre e dor em hipocôndrio direito.	Abscesso hepático amebiano.
Aumento parotídeo doloroso unilateral ou bilateral com elevação do lóbulo da orelha e hiperemia do orifício do ducto de Stensen sem secreção purulenta à ordenha.	Parotidite epidêmica / Caxumba (Vírus da Caxumba).
Orquite uriliana: Dor testicular intensa aguda unilateral, edema escrotal volumoso e febre alta que se instalam 4 a 8 dias após parotidite em adolescente pós-púbere.	Orquite pós-caxumba (risco de atrofia testicular).
Faringoamigdalite com placas esbranquiçadas confluentes, linfadenomegalia cervical posterior e epitroclear, esplenomegalia e linfocitose atípica > 10% no hemograma.	Mononucleose infecciosa (Vírus Epstein-Barr).
Edema palpebral bilateral sem secreção conjuntival purulenta associado a febre, faringite e linfadenopatia cervical no curso precoce da mononucleose (Sinal de Hoagland).	Mononucleose infecciosa primária por EBV.
Febre alta prolongada (> 7 dias), tosse seca, cefaleia intensa, dor abdominal e exantema macular fugaz róseo em tronco associado a dissociação pulso-temperatura.	Febre tifoide / Febre entérica.
Lactente menor de 3 meses com tosse com paroxismos que evolui com cianose e apneia súbita prolongada sem o guincho inspiratório clássico.	Coqueluche grave do lactente jovem (leucocitose com reação leucemoide > 50.000 e linfocitose absoluta).
Lesão papular eritematosa pós-vacina BCG com evolução cronológica típica: mácula (1 ^a -2 ^a sem), pústula (3 ^a -4 ^a sem), úlcera rasa (4 ^a -6 ^a sem) e cicatriz esbranquiçada umbilicada definitiva (> 8-12 sem).	Evolução vacinal fisiológica normal da BCG.
Linfadenopatia axilar ou supraclavicular homolateral à aplicação da vacina BCG com diâmetro > 3 cm, consistência flutuante ou fistulização com saída de secreção.	Linfadenite supurada por BCG / BCGite.
Febre alta nas primeiras 48-72h pós-vacina pentavalente / DTP celular associada a choro inconsolável e persistente por ≥ 3 horas contínuas.	Episódio hipotônico-hiporresponsivo (EHH) ou Choro persistente pós-vacina de células inteiras.
Instalação súbita de hipotonia muscular profunda, palidez cutânea cadavérica e diminuição acentuada da resposta a estímulos externos nas primeiras 48h pós-DTP.	Episódio Hipotônico-Hiporresponsivo (EHH) (indicação de esquema subsequente com DTP acelular).
Vesículas herpéticas agrupadas na pele e córnea em RN de 5 a 11 dias sem comprometimento visceral ou de SNC.	Herpes Simples Neonatal localizado (Pele, Olho e Boca - SEM) (HSV-2 ou HSV-1).
Convulsões focais de difícil controle, letargia profunda e pleocitose com predomínio linfomononuclear e hemácias no líquido entre a 2 ^a e 3 ^a semana de vida sem lesões cutâneas em 30-40% dos casos.	Herpes Simples Neonatal com Encefalite isolada de SNC (tratamento imediato: Aciclovir IV em dose alta).
Deterioração clínica súbita na 2 ^a semana de vida mimetizando choque séptico com coagulopatia intravascular disseminada, insuficiência hepática fulminante e miocardite.	Herpes Simples Neonatal Disseminado.
Hidropisia fetal grave intraútero não imune com ascite, derrame pleural, cardiomegalia e anemia fetal extrema após infecção materna por Parvovírus B19 no 2 ^o trimestre.	Hidropisia fetal por Parvovírus B19 (tropismo e lise de progenitores eritroides fetais).
Síndrome seps-like no recém-nascido durante meses quentes de verão com meningoencefalite, miocardite fulminante, hepatite e coagulopatia grave.	Infecção neonatal sistêmica por Enterovírus (Echovírus ou Coxsackie B).
Febre alta aguda, mialgia retro-orbitária lancinante, artralgia intensa (quebra-ossos), prova do laço positiva com exantema máculo-papular em ilhas de pele sã em mar vermelho.	Dengue clássica.
Sinais de alarme da Dengue: Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural/hipotímia, hepatomegalia > 2 cm dolorosa, sangramento de mucosas e aumento progressivo do hematócrito.	Dengue com sinais de alarme (risco iminente de extravasamento plasmático e choque da dengue).
Dor articular incapacitante e simétrica em pequenas articulações das mãos, punhos e tornozelos acompanhada de febre alta abrupta e hiperpigmentação macular em face.	Febre de Chikungunya (fase aguda e subaguda).
Espasmos faríngeos lancinantes e terror desencadeados pela visão, menção ou tentativa de ingestão de água (hidrofobia) ou corrente de ar em face (aerofobia) após mordedura por morcego.	Raiva humana encefalítica (hidrofóbica) (invariavelmente letal após início dos sintomas).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Tétano cefálico de Rose: Trismo e disfagia acompanhados de paralisia periférica do nervo facial (VII par) e paralisias oculomotoras ipsilaterais após ferimento infectado em cabeça/face.	Tétano cefálico (forma rara e grave de tétano localizado).
Pápula ou nódulo amarelado arredondado com ponto escuro central milimétrico e prurido/dor lancinante em pés ou dedos após andar descalço em currais ou solo arenoso.	Tungíase / Bicho-de-pé (infestação por fêmea gravídica de <i>Tunga penetrans</i>).
Nódulo subcutâneo eritematoso furunculóide doloroso com orifício central punctiforme que drena secreção serossanguinolenta e sensação de movimento sob a pele.	Míase furunculóide / Berne (larva da mosca <i>Dermatobia hominis</i>).
Escabiose crostosa (sarna norueguesa): Placas hiperqueratóticas espessas cinzento-amareladas crostosas não pruriginosas ou pouco pruriginosas cobrindo mãos, pés e tronco com milhões de ácaros em imunodeprimido.	Escabiose crostosa / norueguesa (altamente contagiosa).
Febre prolongada, hepatoesplenomegalia dolorosa, leucopenia e eosinofilia em lactente com histórico de ingestão de leite de vaca cru ou contato com rebanho bovino/caprino.	Brucelose infantil (<i>Brucella abortus</i> ou <i>B. melitensis</i>).
Úlcera cutânea endurecida no local da mordedura por rato que cicatriza e reabre com febre remitente, linfangite regional, artralgia e exantema purpúrico (Sodoku).	Febre por Mordedura de Rato (<i>Spirillum minus</i> ou <i>Streptobacillus moniliformis</i>).
Febre alta de início abrupto, cefaleia retro-orbitária lancinante, mialgia difusa ('febre quebra-ossos') e prova do laço positiva com mais de 10 petéquias em quadrado de 2,5 cm em criança.	Dengue clássica / Dengue sem sinais de alarme.
Dor abdominal intensa e contínua à palpação, vômitos persistentes incoercíveis, hipotensão postural e aumento progressivo do hematócrito no período de defervescência térmica.	Dengue com sinais de alarme (início da fase crítica de extravasamento capilar).
Hipotensão arterial profunda, pulso filiforme imperceptível, pressão de pulso convergente (PAS - PAD $\leq$ 20 mmHg) e enchimento capilar > 3s em paciente com dengue.	Choque da Dengue / Síndrome do Choque da Dengue (emergência para expansão cristalóide a 20 mL/kg rápida).
Poliartalgia simétrica intensa e incapacitante acometendo mãos, punhos e tornozelos com edema periarticular acentuado associada a exantema máculo-papular e febre alta.	Febre de Chikungunya aguda.
Hiperpigmentação cutânea macular acastanhada confluyente em bochechas e dorso nasal ('em máscara de guaxinim') após quadro febril exantemático neonatal.	Chikungunya neonatal / Síndrome de hiperpigmentação pós-Chikungunya.
Exantema máculo-papular pruriginoso descendente fino acompanhado de conjuntivite não purulenta, febre baixa ou ausente e artralgia discreta.	Infecção pelo Vírus Zika.
Febre aguda, cefaleia, mialgia com rápida evolução em 3 a 5 dias para icterícia rubínica com hiperbilirrubinemia mista, oligúria e vômitos negros (hematêmese) com Sinal de Faget.	Febre Amarela silvestre grave.
Febre súbita com calafrios solenes, cefaleia intensa e sudorese profusa em crises paroxísticas a cada 48 horas (febre terçã) associada a anemia hemolítica e esplenomegalia.	Malária por <i>Plasmodium vivax</i>.
Febre remitente irregular contínua com delírio, sonolência profunda, convulsões generalizadas e coma rápido em criança com anemia grave e icterícia em área endêmica amazônica.	Malária cerebral por <i>Plasmodium falciparum</i> (emergência com sequestro de eritrócitos parasitados na microvasculatura encefálica).
Mialgia excruciante espontânea e à palpação na panturrilha (sinal do aperto da panturrilha positivo), sufusão conjuntival sem exsudato, febre e icterícia em tom de ferrugem.	Leptospirose anictérica ou forma ictérica grave (Síndrome de Weil).
Insuficiência respiratória aguda fulminante com tosse, hemoptise maciça e infiltrado alveolar bilateral em vidro fosco ('pulmão leptospirótico') pós-enchentes.	Hemorragia Pulmonar Aguda por Leptospirose.
Massa nodular inflamatória dolorosa no couro cabeludo com supuração folicular exuberante através de múltiplos orifícios cribriformes com saída de pus ('favo de mel') e alopecia.	Kérion Celsi / Tínea do couro cabeludo inflamatória (reação imune a dermatófitos zoofílicos como <i>Microsporum canis</i> ou <i>Trichophyton mentagrophytes</i>).
Placas escamosas acinzentadas únicas ou múltiplas bem delimitadas no couro cabeludo com cabelos fraturados a poucos milímetros da raiz ('tonsura') com fluorescência verde à luz de Wood.	Tinea capitis tonsurante (<i>Microsporum</i>).
Febre prolongada de origem indeterminada, esplenomegalia gigante ultrapassando a crista ilíaca, hepatomegalia e pancitopenia grave com hipergamaglobulinemia policlonal.	Leishmaniose Visceral infantil / Calazar.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Lesão papular eritematosa na face ou mucosa que evolui para úlcera indolor com bordas elevadas e infiltradas em moldura e fundo com granulação grosseira avermelhada.	Leishmaniose Tegumentar Americana / Úlcera de Bauru.
Complexo oftalmoganglionar de Romaña: Edema bpalpebral unilateral violáceo elástico indolor com dacriocistite e infartamento ganglionar pré-auricular satélite doloroso pós-coçadura.	Sinal de Romaña / Fase aguda da Doença de Chagas.
Chagoma de inoculação: Nódulo eritematoso endurecido subcutâneo ligeiramente doloroso com adenopatia regional em pele de área exposta pós-picada de triatomíneo.	Fase aguda da Doença de Chagas tegumentar.
Febre alta aguda, tosse seca, estertores crepitantes bilaterais e infiltrados reticulares difusos associados a eritema multiforme menor pós-infecção respiratória em escolar.	Pneumonia atípica por <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (aglutininas a frio positivas).
Acesso violento de tosse com paroxismos que culmina em apneia prolongada, cianose intensa perioral e bradicardia severa sem guincho audível em lactente menor de 3 meses.	Coqueluche grave do lactente jovem (reação leucemoide com hiperleucocitose > 50.000/mm³ e risco de hipertensão pulmonar maligna).
Exantema escarlatiniforme difuso em lixa acompanhado de descamação lamelar palmo-plantar precoce, dor articular e adenopatia cervical com swab de orofaringe negativo para EGA.	Síndrome do Choque Tóxico por Estafilococo / Doença de Kawasaki incompleta.
Tríade da Síndrome de Aicardi: Agenesia de corpo caloso, lacunas coriorretinianas esbranquiçadas arredondadas multifocais em 'queijo suíço' à fundoscopia e espasmos infantis em meninas.	Síndrome de Aicardi (distúrbio ligado ao cromossomo X dominante com letalidade embrionária no sexo masculino).
Ataxia-Telangiectasia com marcador sérico: Ataxia cerebelar de início aos 1-2 anos com telangiectasias oculares e elevação acentuada persistente de alfa-fetoproteína (AFP) sérica (> 10x o normal) associada a imunodeficiência com IgA e IgE indetectáveis.	Ataxia-Telangiectasia (marcador diagnóstico confirmatório de fácil dosagem).
Síndrome de Alpers-Huttenlocher: Epilepsia mioclônica refratária de início na infância com estado de mal epiléptico refratário, regressão cognitiva e insuficiência hepática fulminante desencadeada pelo uso de ácido valproico.	Doença mitocondrial de Alpers (mutação no gene da polimerase gama mitocondrial - POLG; contraindicação absoluta a valproato).
Doença de Unverricht-Lundborg (Epilepsia Mioclônica Progressiva tipo 1): Abalos mioclônicos motores incapacitantes desencadeados por estímulos visuais, sonoros ou movimento intencional, crises convulsivas e ataxia em adolescente previamente normal.	Epilepsia Mioclônica Progressiva tipo 1 (mutação no gene da cistatina B - CSTB).
Síndrome de Marinesco-Sjögren: Ataxia cerebelar congênita, catarata congênita precoce bilateral, retardo mental grave e miopatia com fraqueza muscular e amiotrofia.	Síndrome de Marinesco-Sjögren (mutação no gene SIL1).
Síndrome de Cockayne: Nanismo caquético precoce, fácies senil proeminente ('aspecto de velhinho em miniatura'), microcefalia, retinopatia pigmentar em 'sal e pimenta', fotossensibilidade extrema sem predisposição a câncer e calcificações dos gânglios da base.	Síndrome de Cockayne (defeito no reparo de DNA por excisão de nucleotídeos acoplado à transcrição - TC-NER).
Síndrome de Bloom: Baixa estatura proporcional grave, eritema telangiectásico facial fotossensível em asa de borboleta com hipo e hiperpigmentação salpicada, imunodeficiência e quebras cromossômicas com aumento de trocas entre cromátides-irmãs.	Síndrome de Bloom (mutação na helicase RecQ BLM).
Xeroderma Pigmentoso clássico: Desenvolvimento de centenas de efélides e lentigos solares em pele fotoexposta antes dos 2 anos de vida, queimaduras solares bolhosas severas aos mínimos minutos de exposição e desenvolvimento precoce de carcinomas basocelulares, espinocelulares e melanomas na primeira infância.	Xeroderma Pigmentoso (defeito completo no reparo de DNA por excisão de nucleotídeos - NER).
Síndrome de Rothmund-Thomson (Poiquiloderma Congênita): Poiquilodermia cutânea de início na infância (eritema reticulado, atrofia epidérmica, telangiectasias e pigmentação mosqueada em bochechas e extremidades), catarata juvenil bilateral e displasias esqueléticas do raio radial.	Síndrome de Rothmund-Thomson (mutação na helicase RECQL4).
Síndrome de Griscelli tipo 2: Cabelos prateados ou acinzentados metálicos com grumos gigantes irregulares de melanina na haste capilar, albinismo parcial, imunodeficiência grave com episódios frequentes e fatais de Síndrome de Ativação Macrofágica / HLH.	Síndrome de Griscelli tipo 2 (mutação no gene RAB27A).

2. NEONATOLOGIA, PERINATOLOGIA E TRANSTORNOS DO RECÉM-NASCIDO (44 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Sinal da dupla bolha gástrica e duodenal ao RX simples de abdome em RN com vômitos biliosos logo após o nascimento e ausência de gás no intestino distal.	Atresia duodenal congênita (fortemente associada à Síndrome de Down).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Sinal da tripla bolha à radiografia abdominal de recém-nascido com vômitos biliosos e distensão abdominal alta precoce.	Atresia jejunal congênita.
Efusão de líquido pleural leitoso opalescente de conteúdo triglicéridico elevado (> 110 mg/dL) com predomínio de linfócitos em recém-nascido com desconforto respiratório.	Quilotórax congênito.
Ausência bilateral de musculatura da parede abdominal anterior (abdome em ameixa seca), criptorquidia bilateral e megaureteres com dilatação vesical.	Síndrome de Prune-Belly / Tríade de Eagle-Barrett.
Massa renal sólida volumosa ao nascimento com hipertensão, hematúria e hipercalcemia , de aspecto fibroso benigno ao exame anatomopatológico.	Nefroma mesoblástico congênito.
Onfalocele congênita: Defeito da parede abdominal mediana na base do cordão umbilical com herniação de vísceras cobertas por membrana peritoneal e amnio intactas.	Onfalocele (elevada frequência de cardiopatias congênicas e síndromes cromossômicas).
Gastrosquise congênita: Defeito paraumbilical na parede abdominal (quase invariavelmente à direita do cordão) com evisceração de alças intestinais espessadas sem membrana de cobertura.	Gastrosquise (alças em contato direto com líquido amniótico).
Exstrophy de bexiga: Bexiga aberta na parede abdominal inferior com mucosa avermelhada evertida úmida drenando urina, associada a diástase dos ossos púbicos e epispádia.	Extrofia de bexiga.
Icterícia neonatal por hiperbilirrubinemia indireta extrema (> 25-30 mg/dL) persistente sem hemólise que não responde a fenobarbital por ausência total da enzima UGT1A1.	Síndrome de Crigler-Najjar tipo I (risco altíssimo de kernicterus precoce).
Icterícia neonatal grave por bilirrubina indireta que apresenta redução acentuada de mais de 70-80% nos níveis após administração terapêutica de fenobarbital.	Síndrome de Crigler-Najjar tipo II (Doença de Arias).
Icterícia leve crônica flutuante assintomática por bilirrubina indireta (1,5 a 3,0 mg/dL) desencadeada por jejum, estresse, privação de sono ou infecções com função hepática normal.	Síndrome de Gilbert.
Icterícia neonatal com colestase intra-hepática, hipoplasia dos ductos biliares interlobulares, fâcies triangular com fronte ampla, olhos profundos, sopro de estenose pulmonar periférica e vértebras em borboleta.	Síndrome de Alagille (mutação no gene JAG1).
Tumefação testicular neonatal unilateral dura, arroxeadada, indolor à palpação presente ao nascimento sem reflexo cremastérico decorrente de torção fetal no útero.	Torção testicular pré-natal extravaginal.
Reflexo de sucção débil com língua protusa trêmula, hipotermia, bradicardia, letargia profunda e hipotonia extrema em recém-nascido filho de mãe diabética.	Hipoglicemia neonatal sintomática.
Reflexo de Perez: À estimulação tátil suave ascendente sobre os processos espinhosos da coluna vertebral da região sacral até o pescoço em suspensão ventral, o neonato flexiona os quatro membros, eleva a cabeça e a pelve, e comumente urina ou chora.	Reflexo espinhal fisiológico do recém-nascido (presente do nascimento até o 3º-4º mês de vida).
Reflexo de Babkin (Palmo-mentoniano neonatal): À compressão tátil bilateral das palmas das mãos do recém-nascido deitado em decúbito dorsal, ele abre a boca, flete o pescoço para a frente e fecha os olhos.	Reflexo cortical-trigeminal primitivo normal (presente nas primeiras 6 a 8 semanas de vida).
Reflexo de Fuga à Asfixia (Rooting reflex postural): Quando colocado em decúbito ventral estrito com o nariz e a boca obstruídos contra o colchão, o neonato vira ativamente a cabeça lateralmente e eleva o tronco para desobstruir as vias aéreas.	Reflexo protetor de tronco encefálico essencial à sobrevivência (ausência é sinal grave de depressão neurológica ou asfixia perinatal).
Cútis marmórea fisiológica transitória: Padrão rendilhado vascular arroxeadado ou azulado simétrico e difuso na pele do recém-nascido e lactente jovem desencadeado pela exposição ao frio ambiental.	Labilidade vasomotora fisiológica benigna transitória por imaturidade capilar (desaparece com o reaquecimento).
Cútis marmórea telangiectásica congênita: Padrão vascular reticulado violáceo persistente, fixo, assimétrico, que não desaparece com o aquecimento, associado a atrofia cutânea e ulcerações locais.	Malformação vascular congênita rara de capilares e vênulas dérmicas.
Miliária cristalina (Sudâmina): Múltiplas vesículas minúsculas (1-2 mm) claras, transparentes, superficiais, com aspecto de 'gotículas de orvalho', sem eritema perilesional, decorrentes da retenção de suor.	Obstrução mecânica superficial do ducto da glândula sudorípara écrina na camada córnea.
Miliária rubra ('Brotoeja'): Pápulas eritematosas pruriginosas inflamatórias pequenas em áreas de atrito e dobras cutâneas (pescoço, axilas, virilha) associadas a calor excessivo e agasalhamento exagerado.	Obstrução do ducto écrino intraepidérmico com inflamação dérmica periductal.
Acne neonatal: Pápulas inflamatórias eritematosas e pústulas no dorso nasal e bochechas sem comedões verdadeiros, surgindo entre a 2ª e 3ª semana de vida.	Pustulose céfálica neonatal benigna (resposta inflamatória transitória à colonização por <i>Malassezia sympodialis</i>).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Nevo sebáceo de Jadassohn: Placa alopécica amarelada, rósea ou alaranjada discretamente elevada, lisa ou ceratótica no couro cabeludo presente desde o nascimento.	Hamartoma congênito pilosebáceo (risco de desenvolvimento de siringocistadenoma papilífero ou carcinoma basocelular pós-puberdade).
Mancha vascular de vinho do porto persistente em território trigeminal V1: Mancha eritemato-purpúrica unilateral que não cruza a linha média e cresce proporcionalmente com a criança.	Síndrome de Sturge-Weber (risco de glaucoma e angioma leptomeningeo).
Hérnia umbilical congênita: Protrusão da cicatriz umbilical recoberta por pele e subcutâneo íntegros, facilmente redutível ao toque, que se projeta ao esforço ou choro.	Falha no fechamento do anel aponeurótico umbilical (resolução espontânea na imensa maioria até 3 a 5 anos de idade).
Tumefação testicular neonatal unilateral endurecida, arroxeadada e indolor à palpação presente ao nascimento sem reflexo cremastérico decorrente de torção intraútero.	Torção testicular pré-natal extravaginal.
Secreção mamária leitosa bilateral em recém-nascido a termo associada a hipertrofia mamária neonatal transitória ('leite de bruxa'):	Efeito estrogênico e prolactínico materno-placentário fisiológico transitório (conduta expectante; proibido espremer pelo risco de mastite).
Sangramento vaginal mucossanguinolento escasso em recém-nascida feminina entre o 3º e 7º dia de vida:	Menstruação neonatal fisiológica por privação abrupta dos estrogênios maternos pós-parto.
Urina com depósito alaranjado ou avermelhado ('pó de tijolo') na fralda de recém-nascido saudável nos primeiros dias:	Precipitação de cristais fisiológicos de urato de amônio (benigno; reflexo de desidratação leve transitória).
Hipoglicemia neonatal sintomática em recém-nascido macrossômico filho de mãe com diabetes gestacional descompensado:	Hiperinsulinismo neonatal transitório secundário à hiperplasia das ilhotas pancreáticas fetais.
Hemorragia peri-intraventricular da matriz germinativa (graus I a IV de Papile): Lactente prematuro extremo com queda abrupta de hematócrito, fontanela tensa, bradicardia e convulsões sutis.	Hemorragia da matriz germinativa por flutuação do fluxo sanguíneo cerebral.
Leucomalácia periventricular: Áreas císticas radiolúcidas na substância branca periventricular adjacente aos ventrículos laterais na ultrassonografia transfontanelar em prematuro.	Insulto isquêmico da substância branca periventricular (principal substrato anatômico da diplegia espástica da paralisia cerebral).
Pneumotórax espontâneo neonatal com taquipneia súbita, assimetria torácica, enfisema subcutâneo e hipertransparência à transluminação torácica.	Pneumotórax por barotrauma ou ruptura de bolha subpleural.
Enterocolite necrosante estágio IIb de Bell com pneumoperitônio: Sinal de Rigler (visualização de ambos os lados da parede gástrica/intestinal) e Sinal da bola de futebol americano ao RX.	Perfuração de víscera oca por necrose isquêmica intestinal em prematuro (indicação cirúrgica imediata).
Teste do Coraçãozinho (Oximetria de Pulso Neonatal) positivo: Saturação de SpO ₂ < 95% em membro superior direito (MSD) ou membros inferiores (MMII) OU diferença ≥ 3% entre MSD e MMII, confirmada após 1 hora.	Triagem positiva para Cardiopatia Congênita Crítica Canal-Dependente (indicação imediata de Ecocardiograma com Doppler antes da alta hospitalar).
Teste do Olhinho (Teste do Reflexo Vermelho de Bruckner) alterado: Ausência do reflexo vermelho-alaranjado brilhante simétrico bilateral à oftalmoscopia direta a 50 cm, reflexo assimétrico, reflexo esbranquiçado (leucocoria) ou manchas escuras.	Retinoblastoma, Catarata Congênita, Glaucoma Congênito ou Doença de Coats (encaminhamento oftalmológico de urgência).
Teste da Orelhinha com falha em Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE) com PEATE/BERA normal:	Líquido amniótico ou cerúmen em conduto auditivo externo (reteste em 15-30 dias).
Teste da Orelhinha com EOAE presente e PEATE/BERA ausente ou desorganizado em RN de UTI neonatal:	Espectro da Neuropatia Auditiva / Dissincronia Auditiva (acometimento do nervo auditivo ou células ciliadas internas por hiperbilirrubinemia ou hipóxia neonatal).
Teste da Linguinha com pontuação alterada pelo Protocolo de Martinelli: Frênulo lingual curto com inserção anteriorizada na ponta da língua ou assoalho da boca, língua com ponta em formato de coração à elevação e dificuldade na pega e acoplamento mamário com dor e fissura mamilar materna.	Anquiloglossia congênita com impacto na amamentação (indicação de frenotomia lingual neonatal).
Triagem neonatal biológica (Teste do Pezinho) com tripsina imunorreativa (IRT) elevada em duas amostras consecutivas colhidas nos primeiros 30 dias:	Triagem positiva para Fibrose Cística (indicação mandatória de confirmação pelo Teste do Suor / dosagem quantitativa de cloreto pelo método de Gibson-Cooke).
Triagem neonatal com elevação de 17-alfa-hidroxiprogesterona (17-OHP) no sangue de papel filtro:	Triagem positiva para Hiperplasia Adrenal Congênita por deficiência de 21-hidroxilase (urgência para avaliação de eletrólitos e vigilância de crise perdedora de sal).
Triagem neonatal com ausência de círculos de excisão do receptor de células T (TREC) no sangue de calcanhar:	Imunodeficiência Combinada Grave (SCID) ou Linfopenia T congênita profunda (contraindicação absoluta imediata a vacinas de vírus vivos como BCG e Rotavírus).
Triagem neonatal com ausência de círculos de excisão do elemento recombinante de deleção kappa (KREC):	Agamaglobulinemia congênita / Ausência de Linfócitos B circulantes (Doença de Bruton).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Triagem neonatal genética positiva para deleção homozigótica do éxon 7 do gene SMN1:	Atrofia Muscular Espinhal (AME) pré-sintomática (janela de oportunidade ouro para terapia gênica com Onasemnogene abeparvovec antes de perda de motoneurônios).

3. INFECÇÕES CONGÊNITAS E PERINATAIS (TORCHZ+) (38 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Tríade de Sabin: Coriorretinite macular necrosante bilateral, hidrocefalia não comunicante obstrutiva (estenose de aqueduto de Sylvius) e calcificações intracranianas nodulares difusas.	Toxoplasmose congênita.
Tríade de Gregg: Cardiopatia congênita (Persistência do Canal Arterial ou Estenose de Ramos da Artéria Pulmonar), catarata congênita nuclear densa e surdez neurossensorial coclear.	Síndrome da Rubéola congênita.
Microcefalia ao nascimento com calcificações periventriculares estriadas finas, perda auditiva neurossensorial progressiva e exantema purpúrico ('aspecto em bolo de mirtilo' / <i>blueberry muffin</i>).	Citomegalovírus (CMV) congênito.
Pênfigo palmoplantar bolhoso com secreção serossanguinolenta rica em espiroquetas, coriza sifilítica mucossanguinolenta e pseudoparalisia antálgica dos membros de Parrot.	Sífilis congênita precoce.
Tríade de Hutchinson: Dentes de Hutchinson (incisivos medianos superiores em forma de chave de fenda/entalhados), ceratite intersticial ocular bilateral e surdez labiríntica do VIII par.	Sífilis congênita tardia.
Molares em amora de Moon (hipoplasia cuspídea com múltiplas cúspides rudimentares), fronte olímpica, nariz em sela e tibia em sabre com espessamento periósteo anterior.	Sífilis congênita tardia.
Lesões cutâneas cicatriciais ziguezagueantes deprimidas com padrão metamérico associadas a hipoplasia esquelética unilateral de membro, síndrome de Horner e microftalmia pós-varicela gestacional.	Síndrome da Varicela congênita.
Microcefalia congênita grave com desproporção craniofacial acentuada, pele redundante com rugas em couro cabeludo occipital e artrogripose múltipla congênita.	Síndrome congênita do Zika vírus.
Salivação espumosa abundante contínua, engasgos com cianose e tosse à primeira tentativa de mamada e parada abrupta elástica de sonda orogástrica a 10-12 cm da rima bucal.	Atresia de esôfago (geralmente com fístula traqueoesofágica distal tipo III / C).
Obstrução nasal neonatal bilateral com episódios de cianose em repouso com boca fechada que cedem de imediato ao choro, com falha na progressão de sonda fina nº 6 Fr.	Atresia de coanas bilateral.
Abdome escavado ao nascimento associado a hemitórax esquerdo abaulado e hipertimpânico com ruídos hidroaéreos audíveis e desvio de bulhas cardíacas para o hemitórax direito.	Hérnia diafragmática congênita póstero-lateral (de Bochdalek).
Diferença na saturação de pulso pré-ductal (membro superior direito) $\geq$ 5% superior à pós-ductal (membros inferiores) ou gradiente pressórico de PaO ₂ > 20 mmHg.	Hipertensão Pulmonar Persistente do Recém-Nascido (HPPN) ou Coarctação crítica de aorta / Interrupção do arco aórtico.
Icterícia colestática progressiva com bilirrubina direta > 1,0 mg/dL, acolia fecal persistente e colúria que se instalam a partir da 2ª à 4ª semana de vida.	Atresia de vias biliares extra-hepáticas (urgência: Cirurgia de Kasai antes de 60 dias de vida).
Ambiguidade genital em conceito geneticamente feminino (46,XX) com virilização de genitália externa, associada a vômitos, desidratação grave, hiponatremia e hipercalemia na 2ª semana.	Hiperplasia Adrenal Congênita clássica perdedora de sal (deficiência de 21-hidroxilase).
Reflexo de Moro assimétrico com adução e rotação interna do ombro, pronação do antebraço e flexão palmar ('postura de gorjeta de garçom') com preensão palmar mantida pós-parto difícil.	Paralisia do plexo braquial superior de Erb-Duchenne (raízes C5-C6).
Preensão palmar ausente com punho caído, paralisia dos músculos intrínsecos da mão ('mão em garra') associada a ptose, miose e enoftalmia ipsilaterais.	Paralisia do plexo braquial inferior de Klumpke (raízes C8-T1 associada à lesão simpática de T1).
Choro, espasmo e crepitação óssea à palpação de clavícula com ausência de reflexo de Moro ipsilateral após parto com distócia de ombro ou feto macrossômico.	Fratura de clavícula neonatal.
Cefaloematoma: Coleção fluante subperiosteal estritamente delimitada pelas suturas ósseas cranianas (não cruza suturas), com aumento de risco de icterícia neonatal tardia.	Trauma mecânico de parto craniano (diferencial: bossa serossanguínea, que cruza suturas).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Hemorragia subgaleal: Coleção sanguínea volumosa, difusa e flutuante no espaço epicraniano que cruza suturas e margens orbitárias, com expansão progressiva e choque hipovolêmico.	Trauma obstétrico com sangramento subgaleal (emergência com risco de choque hemorrágico).
Sinal de Arlequim: Demarcação cutânea eritematosa na metade inferior do corpo com palidez da metade superior dividida exatamente pela linha média sagital em decúbito lateral.	Instabilidade vasomotora periférica reflexa benigna transitória do recém-nascido.
Eritema tóxico neonatal: Máculas e pápulas eritematosas encimadas por pústula central esbranquiçada contendo eosinófilos ao esfregaço, que poupam palmas e plantas, nos primeiros dias de vida.	Erupção cutânea benigna transitória neonatal.
Melanose pustulosa neonatal transitória: Pústulas estéreis superficiais frágeis presentes ao nascimento repletas de neutrófilos, que se rompem deixando máculas hiperpigmentadas com colar de escamas.	Dermatose pustulosa benigna transitória do recém-nascido.
Milium sebáceo: Múltiplas pápulas diminutas branco-amareladas de 1-2 mm localizadas no dorso nasal, bochechas e queixo decorrentes da retenção de ceratina e material sebáceo.	Cistos de retenção sebácea benignos neonatais.
Pérolas de Epstein e Nódulos de Bohn: Pequenos cistos esbranquiçados firmes localizados na rafe palatina mediana (Epstein) ou ao longo das bordas gengivais alveolares (Bohn).	Cistos epiteliais benignos de inclusão oral do recém-nascido.
Mancha mongólica / Melanocitose dérmica congênita: Mácula azul-acinzentada ou ardósia de bordas mal delimitadas em região lombossacra e nádegas decorrente de melanócitos na derme.	Pigmentação dérmica fisiológica congênita benigna.
Mancha salmão / Mancha telangiectásica ('bico da cegonha' ou 'beijo do anjo'): Mácula eritematosa vascular plana rósea na nuca, glabella e pálpebras que empalidece à digitopressão.	Malformação capilar cutânea superficial benigna transitória.
Coto umbilical com secreção aquosa/urina contínua clara saindo pelo umbigo com piora ao aumento da pressão intra-abdominal e irritação periumbilical.	Persistência do canal do úraco / Fístula úraco-vesical.
Coto umbilical com eliminação de fezes ou muco entérico e tecido mucoso vermelho vivo cilíndrico prolapsado pela cicatriz umbilical.	Persistência do ducto onfalomesentérico / Fístula vitelina.
Granuloma umbilical: Massa nodular pedunculada úmida, avermelhada, friável, com secreção serosa leve na base do umbigo após a queda do cordão, sem sinais flogísticos periumbilicais.	Tecido de granulação reacional pós-desprendimento do coto (tratamento com nitrato de prata).
Eritema, edema periumbilical endurecido com secreção purulenta fétida e dor à palpação abdominal em neonato, com risco iminente de trombose da veia porta.	Onfalite neonatal (emergência infecciosa bacteriana).
Atraso na queda do cordão umbilical (> 3 a 4 semanas) associado a infecções bacterianas necróticas recorrentes de pele e mucosas sem formação de pus e leucocitose neutrofílica extrema.	Deficiência de Adesão Leucocitária tipo 1 (LAD-1).
Aplasia cúbis congênita: Defeito congênito focal bem circunscrito de ausência de pele e anexos, em soco, no vértex do couro cabeludo, deixando exposta a fáscia ou periósteo.	Aplasia cutânea congênita (associada à trissomia do 13 ou síndrome de Adams-Oliver).
Icterícia de início precoce nas primeiras 24 horas de vida com ascensão rápida de bilirrubina indireta (> 0,5 mg/dL/h) e reticulocitose intensa em RN de mãe Rh negativo ou O positivo.	Doença Hemolítica Perinatal por incompatibilidade Rh ou ABO.
Icterícia prolongada por bilirrubina indireta em RN em aleitamento materno exclusivo que persiste além da 2ª-3ª semana com ganho de peso excelente e exames hepáticos normais.	Icterícia do leite materno (inibição transitória da glicuroniltransferase por metabólitos do leite).
Taquipneia precoce logo após parto cesárea eletivo sem trabalho de parto em RN a termo, com gemência expiratória leve e melhora clínica espontânea em 48 a 72 horas.	Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN) / Pulmão úmido.
Desconforto respiratório grave imediato com tiragem intensa, expiração prolongada, cianose e tórax em barril em RN a termo ou pós-termo banhado em mecônio espesso.	Síndrome de Aspiração Meconial (SAM).
Taquipneia progressiva, gemência expiratória audível, batimento de asa de nariz e tiragem intercostal com padrão reticulogranular difuso e broncograma aéreo ao RX em prematuro.	Síndrome do Desconforto Respiratório / Doença da Membrana Hialina (deficiência de surfactante).
Letargia, vômitos, sucção débil, hipoglicemia e acidose em recém-nascido saudável após início de fórmula infantil ou leite materno, com desenvolvimento de catarata precoce em 'gota de óleo'.	Galactosemia clássica (deficiência de galactose-1-fosfato uridiltransferase - GALT).

4. GENÉTICA CLÍNICA, CROMOSSOMOPATIAS E SÍNDROMES DISMÓRFICAS (79 achados clínicos)

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Fendas palpebrais oblíquas para cima, prega epicântica, ponte nasal baixa, prega palmar única transversa (simiesca), clinodactilia do 5º dedo, hipotonia e manchas de Brushfield na íris.	Síndrome de Down (Trissomia do cromossomo 21).
Occipital proeminente, micrognatia severa, orelhas de implantação baixa malformadas, punhos cerrados com dedos sobrepostos (2º sobre o 3º e 5º sobre o 4º) e pés em mata-borrão.	Síndrome de Edwards (Trissomia do cromossomo 18).
Microftalmia/anoftalmia, holoprosencefalia com fenda labiopalatina mediana, polidactilia pós-axial de mãos e pés e aplasia cutânea no couro cabeludo.	Síndrome de Patau (Trissomia do cromossomo 13).
Choro agudo e monótono indistinguível de um miado de gato (<i>cri-du-chat</i>) decorrente de hipoplasia laringea, microcefalia, hipertelorismo e retardo cognitivo grave.	Síndrome do Cri-du-Chat (deleção do braço curto do cromossomo 5 / 5p-).
Fácies em 'capacete de guerreiro grego' (ponte nasal ampla contínua com a frente), hipertelorismo acentuado, coloboma de íris e atraso grave do desenvolvimento.	Síndrome de Wolf-Hirschhorn (deleção do 4p-).
Hipotonia neonatal com dificuldade extrema de sucção, seguida na infância por hiperfagia incontrolável sem saciedade, obesidade mórbida, mãos/pés pequenos e hipogonadismo.	Síndrome de Prader-Willi (perda da expressão de genes paternos em 15q11-q13).
Acessos frequentes e paroxísticos de riso imotivado com postura e marcha atáxica espasmódica em 'marionete', ausência total de fala e microcefalia.	Síndrome de Angelman (perda da expressão do gene maternal UBE3A em 15q11-q13).
Fácies de 'duende', estenose aórtica supravalar, hipercalcemia idiopática na infância e perfil comportamental excessivamente amigável e desinibido (hipersociabilidade).	Síndrome de Williams-Beuren (microdeleção em 7q11.23 envolvendo o gene da elastina).
Defeitos cardíacos conotruncais (Tetralogia de Fallot, tronco arterioso), anomalias de palato (insuficiência velofaríngea), hipoplasia tímica e hipocalcemia neonatal por hipoparatiroidismo.	Síndrome de DiGeorge / Síndrome Velo-Cárdio-Facial (microdeleção 22q11.2).
Macroglossia acentuada, onfalocele ou hérnia umbilical grande, hemi-hiperplasia corporal assimétrica, sulcos no lobo da orelha e hipoglicemia neonatal.	Síndrome de Beckwith-Wiedemann (risco aumentado de Tumor de Wílm e Hepatoblastoma).
Baixa estatura extrema desproporcional com encurtamento rizomélico severo de membros, macrocefalia com bossa frontal, depressão da raiz nasal e mãos com configuração em tridente.	Acondroplasia (mutação ativadora no gene FGFR3).
Estatura alta desproporcional, membros longos, aracnodactilia, subluxação superior do cristalino (ectopia lentis), <i>pectus excavatum</i> e dilatação aneurismática da raiz aórtica.	Síndrome de Marfan (mutação no gene da Fibrilina-1 - FBN1).
Hiperelasticidade cutânea extraordinária (pele esticável que retorna à posição), frouxidão ligamentar generalizada e cicatrizes atróficas finas em papel de cigarro.	Síndrome de Ehlers-Danlos (defeitos na síntese do colágeno).
Escleras azuladas intensas, dentinogênese imperfeita (dentes acastanhados frágeis e opalescentes) e fraturas ósseas múltiplas patológicas aos mínimos traumas com hipoacusia precoce.	Osteogênese Imperfeita (doença dos ossos de vidro - colágeno tipo I).
Baixa estatura feminina, pescoço alado (<i>pterygium colli</i>), implantação baixa dos cabelos na nuca, tórax alargado em escudo com hipertelorismo mamário, linfedema dorsal de mãos e pés e coarctação de aorta.	Síndrome de Turner (Monossomia 45,X ou mosaicismo).
Estatura alta com membros inferiores desproporcionalmente longos, ginecomastia puberal, testículos pequenos e endurecidos (< 4 mL), hipogonadismo hipergonadotrófico e azoospermia.	Síndrome de Klinefelter (cariótipo 47,XXY).
Macroorquidismo bilateral pós-puberal volumoso, face alongada com fronte e mandíbula proeminentes, orelhas grandes em abano, hiperlaxidão e comportamento autístico.	Síndrome do X Frágil (expansão do trinucleotídeo CGG no gene FMR1).
Baixa estatura desproporcional com assimetria corporal congênita (hemi-hipotrofia), face triangular pequena com queixo pontiagudo e clinodactilia do 5º quirodáctilo.	Síndrome de Russell-Silver.
Baixa estatura, pescoço alado, estenose de valva pulmonar displásica, hipertelorismo ocular com fendas antimongolóides e tórax superior carinatum e inferior excavatum (ambos os sexos).	Síndrome de Noonan (mutações na via RAS-MAPK / PTPN11).
Sobrancelhas espessas e arqueadas com confluência na linha média (sinofre), cílios longos abundantes, hirsutismo corporal, microcefalia e anomalias de redução de membros superiores.	Síndrome de Cornelia de Lange.
Polegares e háluxes alargados e angulados distalmente ('polegares em espátula'), fendas palpebrais inclinadas para baixo, nariz adunco com columela proeminente e deficiência intelectual.	Síndrome de Rubinstein-Taybi.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Associação CHARGE: Coloboma ocular, Cardiopatia congênita, Atresia de coanas, Retardo de crescimento e desenvolvimento, Hipoplasia genital e Anomalias de orelhas/surdez.	Síndrome / Associação CHARGE (mutação no gene CHD7).
Associação VACTERL: Anomalias Vertebrais, Atresia Anal, Anomalias Cardíacas, Fístula Traqueoesofágica com atresia de esôfago, Anomalias Renais e Anomalias de Membros (raio radial).	Associação VACTERL / VATER.
Fenda palatina posterior ampla, micrognatia mandibular acentuada e glossoptose posterior resultando em obstrução respiratória severa em posição supina.	Sequência de Pierre Robin.
Craniossinostose coronária precoce com hipoplasia do terço médio da face e sindactilia cutânea e óssea completa simétrica de mãos e pés em bloco único ('luva de boxe').	Síndrome de Apert (Acrocefalossindactilia tipo I - mutação FGFR2).
Craniossinostose com hipertelorismo, exoftalmia acentuada por órbitas rasas, estrabismo divergente e hipoplasia do terço médio facial em bico de papagaio sem sindactilia de membros.	Síndrome de Crouzon (Disostose craniofacial - FGFR2).
Hipoplasia malar e mandibular severa, fendas palpebrais antimongolóides, coloboma de pálpebra inferior com ausência de cílios mediais e microtia com estenose de conduto auditivo.	Síndrome de Treacher Collins (Disostose Mandibulofacial).
Agenesia bilateral total ou hipoplasia grave do rádio com preservação estrita de ambos os polegares associada a trombocitopenia com megacariócitos ausentes na medula.	Síndrome TAR (Trombocitopenia com Ausência de Rádio).
Pancitopenia progressiva associada a anomalias do raio radial (polegar ausente, hipoplásico ou bifido), manchas café-com-leite e quebras cromossômicas induzidas por DEB.	Anemia de Fanconi.
Polidactilia pós-axial em mãos e pés, obesidade troncular progressiva, retinite pigmentosa atípica com perda visual precoce, hipogonadismo e disfunção renal.	Síndrome de Bardet-Biedl.
Retinite pigmentosa, perda auditiva neurosensorial progressiva grave, cardiomiopatia dilatada na infância, obesidade e diabetes mellitus tipo 2 precoce.	Síndrome de Alström.
Tríade de McCune-Albright: Manchas café-com-leite extensas com bordas denteadas irregulares em 'costa da Califórnia' unilaterais, displasia fibrosa poliostótica e puberdade precoce periférica.	Síndrome de McCune-Albright (mutação em mosaico no gene GNAS).
Tríade WAGR: Tumor de Wilms, Aniridia congênita bilateral completa, anomalias Geniturinárias e Retardo do neurodesenvolvimento.	Síndrome WAGR (microdeleção no cromossomo 11p13 abrangendo genes PAX6 e WT1).
Aniridia congênita isolada: Ausência congênita bilateral completa ou quase completa da íris, associada a nistagmo sensorial precoce, fotofobia intensa e hipoplasia foveal.	Aniridia congênita (mutação no gene PAX6; risco de síndrome WAGR).
Manchas lentiginosas escuras mucocutâneas periorais em lábios e mucosa jugal associadas a pólipos hamartomatosos gastrointestinais múltiplos e risco de intussuscepção e neoplasias.	Síndrome de Peutz-Jeghers (mutação no gene STK11).
Hipertelorismo ocular acentuado, lentiginose múltipla em face e pescoço, estenose pulmonar, anomalias genitais, retardo de crescimento e surdez neurosensorial.	Síndrome LEOPARD / Síndrome de Noonan com múltiplos lentigos.
Múltiplas neoplasias primárias de início muito precoce (sarcomas de partes moles, osteossarcoma, câncer de mama pré-menopausa, tumores adrenocorticais e leucemias) na mesma família.	Síndrome de Li-Fraumeni (mutação germinativa autossômica dominante no gene supressor tumoral TP53).
Carcinoma de córtex adrenal em lactente ou pré-escolar manifestando-se como virilização rápida e síndrome de Cushing no Sul e Sudeste do Brasil.	Mutação fundadora brasileira p.R337H no gene TP53 (Síndrome de Li-Fraumeni variante).
Múltiplos carcinomas basocelulares precoces na infância, ceratocistos odontogênicos recidivantes da mandíbula, depressões palmo-plantares (pits) e costelas bifidas.	Síndrome de Gorlin-Goltz / Síndrome do Nevo Basocelular (mutação no gene PTCH1).
Hemangioblastomas cerebelares e retinianos múltiplos, carcinoma de células renais de células claras e feocromocitomas bilaterais.	Síndrome de Von Hippel-Lindau (VHL).
Fácies síndrômica com neuromas de mucosa labial e lingual volumosos em nódulos, compleição marfanoide e carcinoma medular de tireoide precoce agressivo.	Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2B (NEM 2B) (mutação no proto-oncogene RET).
Hiperparatireoidismo primário por adenomas múltiplos associado a tumores enteropancreáticos (gastrinoma, insulinoma) e adenomas hipofisários (Tríade dos 3 Ps).	Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 1 (NEM 1 / Síndrome de Wermer) (mutação no gene MEN1).
Carcinoma medular de tireoide, feocromocitoma unilateral ou bilateral e hiperparatireoidismo primário por hiperplasia de paratireoides.	Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2A (NEM 2A / Síndrome de Sipple) (mutação no gene RET).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Macrocefalia progressiva acentuada com múltiplos hamartomas mucocutâneos papulares, triquilemomas faciais, polipose intestinal e risco aumentado de câncer de tireoide.	Síndrome de Cowden / Síndrome de Tumor Hamartoma PTEN.
Síndrome nefrótica congênita precoce com esclerose mesangial difusa, pseudo-hermafroditismo masculino (disgenesia gonadal) e Tumor de Wilms precoce.	Síndrome de Denys-Drash (mutação no gene WT1).
Glomerulopatia com proteinúria progressiva e disgenesia gonadal completa 46,XY (reversão sexual feminina) associada a gonadoblastoma sem tumor de Wilms.	Síndrome de Frasier (mutação intrônica alternativa no gene WT1).
Manchas lentiginosas múltiplas, mixomas cutâneos e cardíacos recidivantes, schwannomas melanocíticos e hiperplasia nodular pigmentada das adrenais com Cushing.	Complexo de Carney (mutação no gene PRKAR1A).
Associação de polipose adenomatosa familiar com tumores do sistema nervoso central (meduloblastoma ou glioblastoma multiforme).	Síndrome de Turcot.
Polipose adenomatosa familiar associada a osteomas osteogênicos de mandíbula/ossos cranianos, cistos epidermóides e tumores desmóides intra-abdominais.	Síndrome de Gardner.
Síndrome de Sotos (Gigantismo Cerebral): Crescimento somático excessivo pré e pós-natal acelerado (altura e peso > P97), macrocefalia proeminente com fronte olímpica ampla, queixo pontiagudo e atraso do desenvolvimento motor.	Síndrome de Sotos (mutação no gene NSD1).
Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel: Macrossomia congênita, fâcies grosseira com fendas palpebrais largas, ponte nasal achatada, macroglossia, polidactilia pós-axial, fenda palatina e risco acentuado de tumores embrionários (Wilms e hepatoblastoma).	Síndrome de Simpson-Golabi-Behmel (herança recessiva ligada ao X no gene GPC3).
Síndrome de Proteus: Crescimento assimétrico hipertrófico desproporcional e progressivo de múltiplos tecidos (esquelético, adiposo e conjuntivo), nevos cerebriiformes plantares espessos e malformações vasculares.	Síndrome de Proteus (mutação somática pós-zigótica em mosaico no gene AKT1).
Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba: Macrocefalia acentuada, polipose hamartomatosa intestinal múltipla, lipomas subcutâneos e máculas hiperpigmentadas lentiginosas na glândula peniana.	Síndrome de Tumor Hamartoma relacionada ao PTEN.
Síndrome de Smith-Magenis: Braquicefalia com face achatada no terço médio, sobrancelhas grossas confluentes, lábio superior em tenda com queixo proeminente, comportamento severo de automutilação (arrancar unhas - onicotilomania e inserir objetos em orifícios) e ritmo circadiano invertido.	Síndrome de Smith-Magenis (deleção do cromossomo 17p11.2 envolvendo o gene RAI1).
Displasia Tanatofórica: Micromelia congênita extrema com membros curtos em sanfona, tórax estreito hipoplásico em sino com pulmões hipoplásicos, crânio em folha de trevo (crâniossinostose pan-sutural) e encurvamento de fêmur em fone de telefone.	Displasia Tanatofórica tipos I e II (mutação autossômica dominante no gene FGFR3; invariavelmente letal no período neonatal).
Hipocondroplasia: Baixa estatura desproporcional com membros curtos rizomélicos moderados, lordose lombar e macrocefalia discreta com alterações radiológicas muito mais sutis que na acondroplasia e fâcies quase normal.	Hipocondroplasia (mutação no gene FGFR3).
Disostose Cleidocraniana: Agenesia total ou hipoplasia bilateral das clavículas permitindo aproximar ambos os ombros na linha média anterior até se tocarem, atraso marcante no fechamento das fontanelas cranianas e dentes supranumerários inclusos.	Disostose Cleidocraniana (mutação no gene RUNX2).
Síndrome de Hallermann-Streiff: Microcefalia com crânio em bico de pássaro, micrognatia severa, microftalmia congênita com catarata bilateral congênita e atrofia cutânea com alopecia e hipotricose facial.	Síndrome de Hallermann-Streiff / Discefalia óculo-mandíbulo-facial.
Síndrome de Waardenburg tipo 1: Mecha frontal de cabelos brancos (poliosis), distopia canthorum (afastamento dos cantos mediais dos olhos com distância interpupilar normal), heterocromia de íris parcial ou total (olhos de cores diferentes) e surdez neurossensorial congênita.	Síndrome de Waardenburg (mutação no gene PAX3).
Síndrome de Stickler: Miopia congênita degenerativa de alto grau com descolamento precoce de retina, fenda palatina com micrognatia (Sequência de Pierre Robin) e displasia espondiloepifisária com hiper mobilidade articular.	Síndrome de Stickler (colagenopatia tipo II e XI).
Síndrome de Aarskog-Scott (Síndrome Faciogenital): Hipertelorismo ocular com fendas antimongolóides, braquidactilia com frouxidão articular de dedos e escroto em xale (pele escrotal circundando a face dorsal do pênis).	Síndrome de Aarskog-Scott (mutação no gene FGD1 ligado ao X).
Síndrome de Coffin-Lowry: Fâcies característica com fronte proeminente, fendas palpebrais inclinadas para baixo, nariz com base alargada e narinas antevertidas, mãos macias com dedos afilados em ponta de cone e episódios de cataplexia induzida por susto auditivo (quedas com atonia sem perda de consciência).	Síndrome de Coffin-Lowry (mutação no gene RPS6KA3 ligado ao X).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Síndrome de Kabuki: Fendas palpebrais longas com eversão do terço lateral da pálpebra inferior lembrando maquiagem do teatro japonês kabuki, sobrancelhas arqueadas com terço lateral ralo, ponta nasal deprimida, almofadas digitais proeminentes e déficit cognitivo.	Síndrome de Kabuki (mutações em KMT2D ou KDM6A).
Síndrome de CHARGE com estridor e paralisia facial: Coloboma ocular + cardiopatia congênita conotruncal + atresia de coanas posterior + retardo grave de crescimento + hipoplasia genital em meninos + anomalias de orelhas com agenesia de canais semicirculares.	Síndrome CHARGE (mutação no gene CHD7).
Síndrome de Holt-Oram (Síndrome Coração-Mão): Anomalias esqueléticas do raio radial unilateral ou bilateral (polegar trifalângico, polegar ausente, hipoplasia do rádio) associadas a Comunicação Interatrial (CIA ostium secundum) ou distúrbios de condução cardíaca.	Síndrome de Holt-Oram (mutação no fator de transcrição cardíaco TBX5).
Síndrome da Unha-Patela (Osteo-Onicodisplasia Hereditária): Ausência total congênita ou hipoplasia grave das patelas, unhas displásicas distróficas com sulcos longitudinais e ausência de lúnulas, chifres ilíacos posteriores simétricos assintomáticos ao RX e nefropatia proteinúrica progressiva.	Síndrome da Unha-Patela (mutação no gene LMX1B).
Doença Renal Policística Autossômica Recessiva (ARPKD): Rins bilateralmente aumentados maciçamente com múltiplos microcistos fusiformes orientados radialmente do córtex à medula ao ultrassom, associados a fibrose hepática congênita com ectasia biliar e hipertensão portal.	ARPKD / Policitose Renal Recessiva (mutação no gene PKHD1).
Deficiência de Piruvato Quinase eritrocitária (PK): Anemia hemolítica congênita crônica não esferocítica com reticulocitose intensa, esplenomegalia precoce e presença de equinócitos e hemácias espiculadas no sangue periférico com fragilidade osmótica normal.	Deficiência de Piruvato Quinase (PK) (segunda enzimopatia eritrocitária mais comum pós-G6PD).
Alfa-Talassemia com Síndrome de Hidropisia Fetal por Hemoglobina de Barts: Feto ou neonato natimorto com edema generalizado anasarcado maciço, hepatoesplenomegalia extrema, ascite e insuficiência cardíaca de alto débito por deleção de todos os 4 genes da globina alfa (--/--).	Talassemia Alfa maior / Hb de Barts (hemoglobina tetramérica gamma-4 com afinidade extrema por oxigênio que impede liberação tecidual).
Doença da Hemoglobina H (HbH): Anemia hemolítica microcítica e hipocrômica crônica moderada a grave com esplenomegalia e coloração supravital com azul de cresil brilhante revelando hemácias com precipitados múltiplos em 'bola de golfe' por deleção de 3 genes alfa (---/a).	Doença da Hemoglobina H (tetrâmeros beta-4 precipitados).
Convulsões Neonatais Dependentes de Piridoxina: Crises convulsivas neonatais intratáveis de início nas primeiras horas de vida que não respondem a nenhum anticonvulsivante habitual (fenobarbital, fenitoína, benzodiazepínicos), mas cessam de imediato e definitivamente após injeção intravenosa de Piridoxina (Vitamina B6).	Epilepsia dependente de piridoxina (mutação no gene ALDH7A1 / antiquitina).
Síndrome da Artéria Mesentérica Superior (Síndrome de Wilkie): Vômitos pós-prandiais biliosos em jato repetidos, dor epigástrica em cólica que alivia na posição genupeitoral ou decúbito lateral esquerdo e emagrecimento rápido acentuado decorrente de compressão da terceira porção do duodeno entre a aorta e a AMS pós-perda rápida do coxim gorduroso.	Síndrome de Wilkie / Compressão vascular duodenal.
Síndrome da Cimitarra (Síndrome Venolobar Pulmonar): Drenagem venosa anômala parcial de veias pulmonares do pulmão direito desembocando na veia cava inferior abaixo do diafragma, com imagem radiográfica de vaso anômalo curvilíneo descendente paralelo à borda cardíaca direita lembrando uma espada turca curva (cimitarra).	Síndrome da Cimitarra (associada a hipoplasia do pulmão direito e dextroposição cardíaca).
Anomalia de Peters: Opacidade corneana central congênita circunscrita leucocórica associada a defeito do endotélio e da membrana de Descemet com aderências iridocorneanas (do colar da íris à margem do leucoma) e alto risco de glaucoma congênito secundário.	Anomalia de Peters (disgênese do segmento anterior ocular).
Anomalia de Axenfeld-Rieger: Linha de Schwalbe anteriorizada e espessada proeminente visível como anel esbranquiçado circunferencial no limbo corneano (Embriotóxon posterior) associada a estrias irianas em ponte e hipoplasia estromal da íris com corectopia (pupila ectópica) e dentes hipoplásicos cônicos microdônticos.	Síndrome de Axenfeld-Rieger (mutações nos genes PITX2 ou FOXC1).
Amaurose Congênita de Leber: Cegueira infantil precoce grave presente desde os primeiros meses com nistagmo sensorial errante, reflexos pupilares à luz quase abolidos, fundo de olho inicialmente normal e Sinal óculo-digital de Franceschetti (a criança pressiona e esfrega compulsivamente os próprios olhos com os dedos para estimular fosfenos retinianos).	Amaurose Congênita de Leber (distrofia retiniana congênita mais severa).
Resistência aos Hormônios Tireoidianos (Síndrome de Refetoff): Bócio tireoidiano palpável associado a níveis séricos elevados de T4 livre e T3 livre com níveis de TSH normais ou discretamente elevados (ausência de supressão do TSH por feedback negativo) em paciente eutireoidiano ou com taquicardia leve e TDAH.	Resistência ao hormônio tireoidiano (mutação no receptor beta do hormônio tireoidiano - THRβ).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Síndrome do Choque Tóxico Estreptocócico pós-varicela: Celulite flegmonosa rápida de extremidade com dor desproporcional, febre alta, hipotensão refratária com falência de múltiplos órgãos 3 a 7 dias após início de lesões de varicela.	Fasciíte necrosante / Choque tóxico estreptocócico por EGA secundário a lesão de varicela.
Erupção por Mycoplasma induzida de mucosas (MIRM / Síndrome de Fuchs): Estomatite erosiva e conjuntivite bilateral graves e dolorosas com crostas hemorrágicas proeminentes em lábios com lesões cutâneas ausentes ou esparsas após pneumonia atípica por <i>Mycoplasma pneumoniae</i> .	MIRM (Mycoplasma-induced rash and mucositis) (distinta da Síndrome de Stevens-Johnson por menor acometimento cutâneo e excelente prognóstico).

5. ERROS INATOS DO METABOLISMO (EIM) E DOENÇAS DE DEPÓSITO (53 achados clínicos)

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Cristais hexagonais de cistina birrefringentes na córnea à lâmpada de fenda em criança com poliúria, raquitismo hipofosfatêmico resistente e acidose tubular renal proximal.	Cistinose nefropática infantil (patognomônico; causa etiológica da Síndrome de Fanconi renal).
Mancha em 'cereja no centro da mácula' (<i>cherry-red spot</i>) bilateral à fundoscopia associada a hiperacusia patológica com sobressalto motor exacerbado ao som e regressão neurológica sem visceromegalia.	Doença de Tay-Sachs (Gangliosidose GM2 - deficiência de Hexosaminidase A).
Mancha em cereja na mácula associada a hepatoesplenomegalia maciça , neurodegeneração rápida com perda de marcos motores e células espumosas histiocitárias na medula óssea.	Doença de Niemann-Pick tipo A (deficiência de esfingomielinase ácida).
Hepatoesplenomegalia acentuada, dor óssea com crises de osteonecrose ('deformidade em frasco de Erlenmeyer'), anemia, trombocitopenia e células de Gaucher em papel amassado.	Doença de Gaucher tipo 1 (deficiência de glicocerebrosidase / beta-glicosidase).
Odor urinário, no cerúmen e no suor idêntico a açúcar mascavo queimado ou xarope de bordo , letargia profunda neonatal, movimentos de pedalar/remar e cetonúria precoce sem glicosúria.	Doença da Urina em Xarope de Bordo / Leucinose (defeito no complexo desidrogenase de cetoácidos de cadeia ramificada).
Odor característico e penetrante de 'pés suados' ou 'queijo rançoso' no suor e urina , encefalopatia neonatal com acidose de ânion gap elevado, hiperamonemia e pancitopenia.	Acidemia Isovalérica (deficiência de isovaleril-CoA desidrogenase).
Odor corporal e urinário de 'camundongo' ou 'mofo' , atraso global grave do desenvolvimento psicomotor, microcefalia pós-natal, hipopigmentação de pele/cabelos e eczema refratário.	Fenilcetonúria clássica (PKU) (deficiência de fenilalanina hidroxilase).
Odor de repolho cozido ou manteiga estragada no hálito e urina , associado a insuficiência hepática aguda precoce, raquitismo hipofosfatêmico e dosagem elevada de succinilacetona.	Tirosinemia tipo 1 (deficiência de fumarilacetoacetato hidrolase).
Odor de cervejaria ou levedura de cerveja no suor e na urina acompanhado de atraso global do neurodesenvolvimento, convulsões e crises de acidose láctica.	Síndrome de Má Absorção de Metionina / Doença do Odor de Cervejaria.
Automutilação compulsiva severa de lábios, bochechas e polpas digitais , coreoatetose, distonia muscular, hiperuricemia com nefrolitíase e arenite alaranjada nas fraldas.	Síndrome de Lesch-Nyhan (deficiência completa de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferase - HGPRT).
Hipoglicemia profunda desprovida de corpos cetônicos (hipocetótica) induzida por jejum prolongado ou virose comum, associada a letargia, hepatomegalia esteatótica e parada cardiorrespiratória.	Defeito da oxidação de ácidos graxos (especialmente deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média - MCADD).
Encefalopatia neonatal fulminante com hiperamonemia maciça (> 1.000 mcmmol/L) e alcalose respiratória de origem central por hiperventilação, sem acidose metabólica ou hipoglicemia inicial.	Distúrbio do ciclo da ureia (especialmente deficiência de Ornitina Transcarbamilase - OTC).
Acidose metabólica grave com ânion gap muito elevado (> 20), cetonúria intensa, hiperamonemia e pancitopenia no período neonatal com deterioração neurológica rápida.	Acidemias Orgânicas clássicas (Acidemia Metilmalônica ou Acidemia Propiônica).
Hipotonia profunda neonatal ('bebê de borracha'), macroglossia volumosa e cardiomiopatia hipertrófica maciça progressiva com ondas R gigantes em todas as derivações ao ECG.	Doença de Pompe / Glicogenose tipo II (deficiência de alfa-1,4-glicosidase ácida / maltase ácida).
Hepatomegalia maciça com abdome globoso, fácies arredondada de boneca , hipoglicemia de jejum com acidose láctica grave, hiperlipidemia em níveis extremos e hiperuricemia.	Doença de Von Gierke / Glicogenose tipo I (deficiência de glicose-6-fosfatase).
Dores em queimação e queimações acrais paroxísticas lancinantes em mãos e pés (acroparestesias), angioqueratomas violáceos em banhador e hipoidrose.	Doença de Fabry (deficiência de alfa-galactosidase A).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Fácies grosseira infiltrada (gargolismo), cifose tóraco-lombar em giba, opacificação corneana difusa precoce, hepatoesplenomegalia e atraso neuropsicomotor com perda auditiva.	Mucopolissacaridose tipo I / Síndrome de Hurler (deficiência de alfa-L-iduronidase).
Fácies grosseira e deformidades esqueléticas idênticas a Hurler, porém sem nenhuma opacificação corneana, com comportamento agressivo hiperativo e lesões cutâneas nodulares em 'casca de laranja'.	Mucopolissacaridose tipo II / Síndrome de Hunter (herança ligada ao X - deficiência de iduronato-2-sulfatase).
Hiperatividade motora extrema com distúrbio grave do sono, perda progressiva rápida da linguagem adquirida e demência infantil com alterações somáticas e esqueléticas muito discretas.	Mucopolissacaridose tipo III / Síndrome de Sanfilippo (acúmulo isolado de heparano sulfato).
Hipotonia grave neonatal, fronte alta, fontanelas amplas, hepatomegalia colestática, cistos corticais renais e elevação maciça de ácidos graxos de cadeia muito longa (VLCFA).	Síndrome de Zellweger / Síndrome Cérebro-Hepato-Renal (defeito na biogênese de peroxissomos).
Triáde de Alcaptonúria: Urina que escurece e se torna negra após repouso/alkalinização, pigmentação acastanhada ou preta de cartilagens e escleras (ocronose) e artrose precoce de grandes articulações.	Alcaptonúria (deficiência de ácido homogentísico oxidase).
Ectopia lentis com luxação inferior do cristalino, compleição marfanoide com aracnodactilia, osteoporose com fraturas patológicas e eventos tromboembólicos graves venosos ou arteriais.	Homocistinúria clássica (deficiência de cistationina beta-sintase).
Cabelos esparsos, hipopigmentados, frágeis, duros e quebradiços com aspecto de 'palha de aço' (pili torti à microscopia), convulsões refratárias e deterioração neurológica.	Doença de Menkes (doença dos cabelos encrespados - defeito no transporte celular de Cobre ligado ao X).
Anel de Kayser-Fleischer: Depósito de cobre em anel castanho-esverdeado na membrana de Descemet da córnea à lâmpada de fenda, associado a parkinsonismo, distonia e hepatopatia crônica.	Doença de Wilson (degeneração hepatolenticular - mutação no gene ATP7B).
Episódios recorrentes semelhantes a AVC em idade jovem (stroke-like episodes) antes dos 40 anos, cefaleia migranosa, vômitos cíclicos, convulsões e acidose láctica sérica persistente.	Síndrome MELAS (Encefalomiopatia Mitocondrial, Acidose Láctica e Episódios Tipo AVC).
Triáde da Síndrome de Kearns-Sayre: Oftalmoplegia externa progressiva crônica, degeneração pigmentar atípica da retina (retinite pigmentosa) e bloqueio de condução atrioventricular cardíaco antes dos 20 anos.	Síndrome de Kearns-Sayre (deleção no DNA mitocondrial).
Cabelos ruivos prateados ou acinzentados metálicos, albinismo oculocutâneo parcial, fotofobia, nistagmo e infecções bacterianas piogênicas graves de repetição com grânulos gigantes nos neutrófilos.	Síndrome de Chédiak-Higashi (mutação no gene LYST).
Face grosseira ('em elfo'), estenose de carótidas, voz metálica rouca e hipercalcemia transitória com nefrocalcinose.	Síndrome de Williams-Beuren.
Pálpebras com fenda antimongolóide, microcefalia, narinas antevertidas, hipospádia, sindactilia do 2º e 3º pododáctilos e níveis séricos muito reduzidos de colesterol com acúmulo de 7-desidrocolesterol.	Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (defeito na biossíntese do colesterol).
Calcificações pontilhadas radiológicas em epífises de ossos longos e patela (estrias epifisárias pontilhadas), membros curtos rizomélicos, catarata e ictiose.	Condrodisplasia Punctata Rizomélica (distúrbio da biogênese de peroxissomos).
Hipertermia maligna pós-anestésica: Rigidez muscular masseterina súbita, espasmo muscular generalizado, hipercapnia extrema e hipertermia de rápida evolução após uso de succinilcolina ou halotano.	Suscetibilidade à Hipertermia Maligna (mutação no receptor de rianodina RYR1).
Crises recorrentes de angioedema subcutâneo e de submucosa recorrente sem prurido e sem urticária, acometendo face, laringe com risco de asfixia e dor abdominal em cólica por edema de alças.	Angioedema Hereditário (deficiência quantitativa ou funcional do inibidor de C1 esterase - C1-INH).
Acidose láctica severa com ataxia episódica, paralisia de pares cranianos, insuficiência respiratória central e necrose espongiiforme simétrica dos gânglios da base e tronco à ressonância magnética.	Doença de Leigh / Encefalomiopatia Necrotizante Subaguda (distúrbio mitocondrial).
Fraqueza muscular progressiva de membros, insuficiência respiratória precoce sem cardiomiopatia e elevação moderada de CK em paciente jovem.	Doença de Pompe de início tardio.
Anemia hemolítica microangiopática com trombocitopenia sem pródromo diarreico e níveis séricos persistentemente baixos de fator H ou I do complemento.	Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica (SHUa) (desregulação da via alternativa do complemento).
Síndrome MERRF (Epilepsia Mioclônica com Fibras Vermelhas Rasgadas): Mioclonias progressivas graves, crises convulsivas generalizadas, ataxia cerebelar, perda auditiva neurosensorial precoce e biópsia muscular revelando fibras vermelhas rasgadas (ragged-red fibers) pela coloração tricrômica de Gomori.	Síndrome MERRF (mutação no DNA mitocondrial gene MTTK no tRNA da lisina).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Síndrome NARP (Neuropatia, Ataxia e Retinite Pigmentosa): Fraqueza muscular proximal associada a neuropatia sensitivo-motora axonal, ataxia sensorial e de tronco, retinite pigmentosa atípica e declínio cognitivo em jovens.	Síndrome NARP (mutação no gene mitocondrial MT-ATP6).
Acidúria Glutárica tipo 1: Crise encefalopática aguda devastadora desencadeada por febre banal com destruição dos núcleos estriados e distonia grave generalizada, com macrocefalia congênita precoce e dilatação acentuada das fissuras silvianas na ressonância magnética ('sinal dos lobos temporais em asa de morcego').	Acidúria Glutárica tipo 1 (deficiência de glutaril-CoA desidrogenase).
Doença de Canavan: Macrocefalia progressiva grave que surge aos 3 a 6 meses de vida, hipotonia com posterior espasticidade, atrofia óptica precoce e espectroscopia por ressonância magnética revelando pico gigante e isolado de N-acetilaspártato (NAA).	Doença de Canavan / Degeneração esponjosa do SNC (deficiência de aspartoacilase).
Leucodistrofia de Krabbe (Leucodistrofia de Células Globoides): Irritabilidade extrema inconsolável inexplicada no lactente jovem aos 3-6 meses, hiperacusia ao menor estímulo sonoro, febre inexplicada, espasticidade com opistótono grave e presença de histiócitos multinucleados gigantes globóides na substância branca cerebral.	Doença de Krabbe (deficiência de galactosilceramidase).
Leucodistrofia Metacromática (MLD): Deterioração insidiosa progressiva da marcha previamente adquirida com hipotonia seguida de tetraplegia espástica, perda de reflexos por neuropatia periférica desmielinizante e atrofia óptica com acúmulo de sulfatídeos.	Leucodistrofia Metacromática (deficiência de arilsulfatase A).
Adrenoleucodistrofia ligada ao X (X-ALD): Menino previamente saudável de 4 a 10 anos que inicia com declínio cognitivo rápido, déficit de atenção, perda auditiva central, perda visual cortical, paraparesia espástica e insuficiência adrenal primária (Addison) associada a níveis plasmáticos muito elevados de VLCFA (ácidos graxos de cadeia muito longa).	Adrenoleucodistrofia forma cerebral infantil ligada ao X (mutação no gene ABCD1).
Doença de Wolman: Vômitos intensos, diarreia intratável com esteatorreia maciça, hepatoesplenomegalia volumosa dura, caquexia precoce e calcificação bilateral simétrica maciça das glândulas adrenais à radiografia de abdome em lactente menor de 3 meses.	Deficiência de Lipase Ácida Lisossomal infantil / Doença de Wolman.
Citrulinemia clássica tipo 1: Encefalopatia hiperamonêmica neonatal fulminante associada a dosagem plasmática de citrulina extremamente elevada (> 1.000 a 2.000 mcmol/L) com dosagem de ácido orótico elevada na urina.	Distúrbio do ciclo da ureia / Citrulinemia tipo 1 (deficiência de argininossuccinato sintetase).
Acidúria Argininossuccínica: Hiperamonemia com cabelos secos, quebradiços, que se partem transversalmente em nós (<i>trichorrhexis nodosa</i> à microscopia) e atraso cognitivo grave.	Deficiência de argininossuccinato liase (ASL).
Glicogenose tipo III (Doença de Cori / Forbes): Hepatomegalia volumosa, hipoglicemia de jejum com cetonúria intensa (diferente da glicogenose tipo I, que tem menos cetose e mais acidose láctica), miopatia esquelética progressiva e cardiomiopatia associadas a níveis normais de lactato sérico.	Glicogenose tipo III (deficiência da enzima desramificadora de glicogênio).
Glicogenose tipo V (Doença de McArdle): Cãibras musculares dolorosas intensas desencadeadas por exercícios anaeróbicos curtos e intensos com fenômeno de 'segundo fôlego' (melhora da tolerância após repouso curto) e episódios recorrentes de miogloblinúria sem hipoglicemia.	Glicogenose tipo V (deficiência de fosforilase muscular).
Raquitismo Hipofosfatêmico Ligado ao X (Raquitismo resistente à Vitamina D): Genu varo progressivo acentuado aos 1-2 anos com atraso motor e baixa estatura grave, dentes decíduos com abscessos periapicais espontâneos e níveis séricos de fosfato muito baixos com cálcio sérico normal e fosfatúria elevada.	Raquitismo Hipofosfatêmico ligado ao X (mutação no gene PHEX com elevação patológica do FGF-23).
Raquitismo Dependente de Vitamina D tipo 1: Raquitismo grave precoce com deformidades esqueléticas acentuadas e hipocalcemia que não responde a doses fisiológicas de vitamina D, mas apresenta resposta imediata e completa ao calcitriol (1,25-(OH) ₂ -vitamina D).	Deficiência congênita da 1-alfa-hidroxilase renal (mutação no gene CYP27B1).
Raquitismo Dependente de Vitamina D tipo 2: Raquitismo esquelético severo refratário associado a alopecia totalis congênita (ausência completa de cabelos, sobrancelhas e cílios) e níveis séricos extraordinariamente elevados de calcitriol.	Resistência periférica ao calcitriol por mutação no receptor de vitamina D (VDR).
Diabetes Mellitus Neonatal transitório ou permanente: Hiperglicemia grave com desidratação e cetoacidose nas primeiras semanas de vida em recém-nascido pequeno para a idade gestacional.	Diabetes Monogênico Neonatal (mutações nos genes KCNJ11 ou ABCC8 que codificam o canal de potássio ATP-dependente da célula beta; excelente resposta à sulfonilureia oral).
Deficiência Congênita Isolada de Hormônio de Crescimento (GHD): Recém-nascido com micropênis (< 2,0 cm), hipoglicemia de jejum com crises convulsivas, icterícia colestática prolongada associados na infância a nanismo harmônico com fâcies infantilizada arredondada ('de querubim') e voz aguda.	Nanismo hipofisário por deficiência congênita de GH.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Atraso Constitucional do Crescimento e da Puberdade (ACCP): Criança ou adolescente do sexo masculino com baixa estatura harmônica, velocidade de crescimento normal para a idade óssea, história familiar idêntica no pai com estirão puberal tardio e idade óssea atrasada em relação à idade cronológica.	Variante fisiológica benigna normal do desenvolvimento estatural.

6. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, EPILEPSIAS E MALFORMAÇÕES DE SNC (60 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Tríade da Síndrome de West: Espasmos infantis axiais repetitivos em salvas (flexão súbita ou extensão), regressão ou estagnação global do neurodesenvolvimento e traçado de hipsarritmia ao EEG.	Síndrome de West / Espasmos Infantis (urgência neurológica pediátrica - tratamento com ACTH ou Vigabatrina).
Múltiplos episódios diários breves (5-15s) de parada comportamental súbita com olhar fixo , sem aura e sem estado pós-ictal, precipitáveis por hiperventilação, com descargas de ponta-onda bilateral síncrona a 3 Hz ao EEG.	Epilepsia de Ausência Típica da Infância (primeira escolha: Etossuximida ou Valproato).
Abalos mioclônicos súbitos bilaterais involuntários preferencialmente pela manhã ao despertar (com arremesso de escova ou xícara) , crises tônico-clônicas induzidas por privação de sono e poliponta-onda a 4-6 Hz.	Epilepsia Mioclônica Juvenil (Síndrome de Janz - evitar bloqueadores de canal de sódio).
Crises epilépticas focais motoras unilaterais no sono com parestesias orofaringolaringeas, salivação e parada de fala com preservação da consciência e pontas centrotemporais ao EEG.	Epilepsia Rolândica Benigna / Epilepsia com Pontas Centrotemporais.
Tríade de Lennox-Gastaut: Múltiplos tipos de crises epilépticas intratáveis (tônicas, atônicas com quedas bruscas / drop attacks e ausências atípicas), retardo cognitivo grave e EEG com ponta-onda lenta (< 2,5 Hz).	Síndrome de Lennox-Gastaut.
Crise epiléptica focal motora unilateral sucedida por paralisia flácida e fraqueza transitória do hemicorpo ou membro acometido durando de minutos a algumas horas.	Paresia ou Paralisia de Todd (marcador de foco cortical focal estrutural pós- crise).
Hipotonia muscular axial severa (em perna de rã), arreflexia tendinosa profunda universal, fasciculações finas da borda lingual e respiração paradoxal com preservação da mímica facial e inteligência normal.	Atrofia Muscular Espinhal tipo 1 (AME 1) (Doença de Werdnig-Hoffmann - deleção no gene SMN1).
Manobra de Gowers positiva (criança apoia as mãos sobre os próprios joelhos e coxas para conseguir levantar-se do chão) , marcha anserina balançante e pseudo-hipertrofia de panturrilhas aos 3-5 anos.	Distrofia Muscular de Duchenne (dosagem de Creatinoquinase sérica - CK > 10.000 U/L).
Paralisia flácida simétrica rapidamente progressiva craniocaudal descendente com ptose, midríase frouxa, sucção débil, choro inaudível e constipação intestinal pertinaz após ingestão de mel ou poeira.	Botulismo infantil (toxina de Clostridium botulinum bloqueando liberação pré-sináptica de acetilcolina).
Paralisia flácida arreflexa simétrica ascendente caudo-cranial com parestesias distais em luva/bota e dissociação proteíno-citológica no líquido (hiperproteinorraquia com celularidade normal) 1-3 semanas pós-infecção.	Síndrome de Guillain-Barré (Polirradiculoneuropatia Desmielinizante Inflamatória Aguda).
Tríade de Miller-Fisher: Oftalmoplegia externa aguda bilateral, ataxia sensitiva/cerebelar de marcha desproporcional e arreflexia miotática global com força muscular preservada.	Síndrome de Miller-Fisher (variante de Guillain-Barré; anticorpo anti-GQ1b presente em > 90%).
Opsoclonus (movimentos oculares caóticos, rápidos, multidirecionais e contínuos sem intervalo), mioclonias multifocais e ataxia cerebelar incapacitante (criança dançarina).	Síndrome de Opsoclonus-Mioclonus-Ataxia (SOMA) (síndrome paraneoplásica associada a Neuroblastoma oculto em > 50%).
Sinal do pôr do sol (setting sun sign): Desvio tônico conjugado inferior de ambos os globos oculares com exposição anormal da esclera superior por retração palpebral bilateral.	Hipertensão intracraniana descompensada no lactente / Hidrocefalia aguda.
Tríade de Cushing: Hipertensão arterial sistêmica progressiva com aumento da pressão de pulso diferencial, bradicardia acentuada e alterações do ritmo respiratório (respiração irregular ou apneias).	Hipertensão intracraniana grave com risco iminente de herniação do uncus / tonsilar.
Síndrome de Parinaud: Paralisia do olhar conjugado vertical superior, retração espasmódica palpebral (Sinal de Collier), nistagmo de convergência-retração e pupilas com dissociação luz-perto.	Lesão expansiva compressiva do teto mesencefálico / Tumor da região pineal (germinoma, pinealoma).
Crises epilépticas gelásticas: Episódios paroxísticos estereotipados de riso imotivado incontrolável sem componente emocional subjetivo de alegria, associados a puberdade precoce isissexual.	Hamartoma Hipotalâmico.
Fraqueza muscular flutuante e fadigabilidade fácil com predomínio na musculatura ocular (ptose palpebral e diplopia) e bulbar com piora acentuada ao final do dia e melhora rápida ao teste do gelo.	Miastenia Gravis autoimune juvenil (anticorpos anti-AChR ou anti-MuSK).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Fraqueza muscular proximal e distal simétrica crônica, atrofia distal de pernas em garrafa de champagne invertida, pés cavos com dedos em garra e marcha escarvante.	Doença de Charcot-Marie-Tooth (Neuropatia hereditária motora e sensitiva).
Movimentos estereotipados repetitivos contínuos de torcer ou lavar as mãos na linha média , associados a desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, regressão da fala e da marcha em menina.	Síndrome de Rett (mutação no gene MECP2 ligado ao X).
Ataxia cerebelar de marcha progressiva de início precoce antes dos 20 anos, arreflexia profunda nos quatro membros, perda da sensibilidade proprioceptiva e vibratória com pés cavos e cardiomiopatia hipertrófica.	Ataxia de Friedreich (expansão do trinucleotídeo GAA no gene da Frataxina).
Início súbito de marcha atáxica cambaleante de base alargada, dismetria e tremor de intenção em criança de 2 a 5 anos previamente sadia, 1 a 3 semanas após quadro de varicela ou virose.	Cerebelite aguda pós-infecciosa / Ataxia cerebelar aguda (diagnóstico de exclusão).
Rigidez de nuca com flexão involuntária reflexa dos joelhos e quadris à flexão passiva do pescoço (Sinal de Brudzinski) e resistência com dor à extensão do joelho com quadril a 90° (Sinal de Kernig).	Síndrome meníngea / Meningite bacteriana ou viral.
Fontanela anterior ampla e tensa, protusa, sem pulsação, associada a diástase de suturas cranianas, macrocrania progressiva rápida e irritabilidade inconsolável.	Hipertensão intracraniana no lactente.
Afasia motora adquirida súbita ou gradual associada a crises convulsivas e agnosia auditiva verbal (a criança ouve, mas não compreende a linguagem falada) com estado de mal epiléptico no sono ao EEG.	Síndrome de Landau-Kleffner (Afasia epiléptica adquirida).
Hemiparesia espástica infantil associada a marcha ceifante / helicópode (membro superior fletido, aduzido e pronado com membro inferior espástico em extensão) após insulto hipóxico-isquêmico perinatal.	Paralisia Cerebral espástica unilateral (hemiparética).
Paralisia espástica simétrica com envolvimento predominantemente de ambos os membros inferiores, postura em tesoura e marcha em tesoura na ponta dos pés em ex-prematureo com leucomalácia periventricular.	Paralisia Cerebral diplégica espástica (Doença de Little).
Postura de torcicolo paroxístico associada a contorções distônicas de tronco e pescoço e hiperextensão do dorso que ocorrem preferencialmente durante ou logo após as mamadas.	Síndrome de Sandifer (manifestação neurocomportamental reflexa de Refluxo Gastroesofágico grave / Esofagite).
Amiotonia congênita com contraturas articulares congênitas múltiplas fixas bilaterais simétricas nos quatro membros (artrogripose múltipla congênita) ao nascimento.	Artrogripose Múltipla Congênita / Amioplastia congênita.
Episódios paroxísticos breves de perda de consciência precedidos por choro vigoroso que cessa em expiração com cianose perioral intensa (espasmo do choro cianótico).	Crise de Apneia Emocional / Espasmo do Soluço tipo cianótico (condição benigna).
Perda de consciência súbita com palidez cadavérica rápida, flacidez e choro mínimo após dor súbita inesperada ou susto leve (espasmo do choro pálido).	Síncope reflexa vaso-vagal / Espasmo do choro pálido (hiper-reatividade parassimpática).
Déficit acentuado de atenção, hiperatividade motora desorganizada e impulsividade com prejuízo em pelo menos dois ambientes (escolar e domiciliar) com início antes dos 12 anos.	Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
Déficits persistentes na comunicação e interação social recíproca, acompanhados de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses fixos ou hipersensibilidade sensorial.	Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Múltiplos tiques motores involuntários rápidos (piscar, contrair face, encolher ombros) e pelo menos um tique vocal (fungar, pigarrear, coprolalia) durando mais de 1 ano com flutuação.	Síndrome de Tourette.
Cefaleia unilateral pulsátil de moderada a forte intensidade em pré-escolar/escolar associada a náuseas, vômitos, fotofobia e fonofobia com alívio marcante após o sono.	Enxaqueca pediátrica sem aura.
Episódios recorrentes e paroxísticos de torcicolo involuntário com inclinação lateral da cabeça acompanhados de vômitos, palidez e ataxia em lactente que cedem em poucas horas/dias.	Torcicolo Paroxístico Benigno da Infância (equivalente enxaquecoso).
Episódios recorrentes estereotipados de vômitos intensos e intratáveis (vários episódios por hora) com início em horário fixo da madrugada e resolução espontânea completa.	Síndrome dos Vômitos Cíclicos da Infância (variante enxaquecosa).
Dor em aperto bilateral contínua de intensidade leve a moderada em capacete sem náuseas e sem piora com atividade física habitual ao final do dia em escolar.	Cefaleia tensional episódica pediátrica.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Sinal do Dente Molar (Molar Tooth Sign) à ressonância magnética cerebral, associado a episódios de hiperpneia episódica alternada com apneia neonatal, hipotonia e ataxia de marcha.	Síndrome de Joubert (ciliopatia com hipoplasia do verme cerebelar e pedúnculos cerebelares superiores espessados e horizontalizados).
Agenesia ou hipoplasia grave do verme cerebelar, dilatação cística volumosa do 4º ventrículo ocupando a fossa posterior e elevação do tentório e do tórculo.	Malformação de Dandy-Walker.
Herniação das tonsilas cerebelares através do forame magno (> 5 mm) manifestando-se na adolescência como cefaleia suboccipital desencadeada por tosse/esforço e siringomielia cervical.	Malformação de Chiari tipo I.
Herniação inferior do verme cerebelar, tronco encefálico e 4º ventrículo através do forame magno invariavelmente associada a Mielomeningocele lombossacra e estridor por paralisia de cordas vocais.	Malformação de Chiari tipo II.
Aspecto de cérebro liso com ausência quase completa de giros e sulcos corticais (agiria / paquigiria), microcefalia grave, crises epiléticas intratáveis e hipotonia inicial.	Lisencefalia tipo 1 / Síndrome de Miller-Dieker (deleção em 17p13.3 abrangendo gene LIS1).
Fenda congênita de espessura total do parênquima cerebral preenchida por líquido estendendo-se do córtex cerebral até o ventrículo lateral, revestida por substância cinzenta displásica.	Esquizencefalia (de lábios abertos ou lábios fechados).
Sinal do Morcego ou Asas de Andorinha aos cornos frontais com afastamento dos ventrículos laterais e elevação do 3º ventrículo em neuroimagem de lactente hipotônico.	Agenesia completa do Corpo Caloso.
Ventrículo cerebral único primitivo com fusão dos tálamos e ausência da foixe inter-hemisférica associado a probóscide, ciclopia ou fenda mediana de lábio e palato.	Holoprosencefalia alobar.
Síndrome de Dravet (Epilepsia Mioclônica Grave da Infância): Crises convulsivas febris prolongadas hemiclônicas unilaterais alternando de lado antes de 1 ano de vida, desencadeadas por febre baixa ou banhos mornos, evoluindo para crises mioclônicas, estado de mal epilético refratário e regressão cognitiva.	Síndrome de Dravet (mutação de novo no canal de sódio SCN1A; contraindicados bloqueadores de sódio como carbamazepina, fenitoína e lamotrigina).
Síndrome de Panayiotopoulos (Epilepsia Occipital Benigna Precoce da Infância): Crises autonômicas raras e prolongadas com vômitos ictais recorrentes incoercíveis, palidez, midríase, desvio ocular conjugado persistente e parada comportamental durante o sono em pré-escolar de 3 a 6 anos.	Epilepsia Autonômica de Panayiotopoulos (prognóstico excelente com remissão completa).
Síndrome de Ohtahara (Encefalopatia Epilética Infantil Precoce): Espasmos tônicos neonatais intratáveis de início nas primeiras semanas de vida associados a padrão de surto-supressão contínuo no sono e na vigília ao EEG e déficit neurológico profundo.	Síndrome de Ohtahara (causas estruturais corticais graves ou mutações nos genes ARX, STXBP1, KCNQ2).
Síndrome de Doose (Epilepsia Mioclônico-Atônica): Múltiplas quedas súbitas traumáticas diárias (drop attacks) por perda do tônus muscular precedida por abalo mioclônico breve em criança de 2 a 5 anos com EEG mostrando poliponta-onda de 2 a 3 Hz.	Epilepsia com Crises Mioclônico-Atônicas / Síndrome de Doose (alta resposta à dieta cetogênica).
Distrofia Miotônica de Steinert congênita: Hipotonia neonatal severa com diplegia facial característica (boca aberta em tenda / triangular de peixe), insuficiência respiratória ao nascimento e fraqueza muscular grave em conceito de mãe com miotonia de preensão (dificuldade em soltar a mão após aperto).	Distrofia Miotônica tipo 1 congênita (expansão maciça do trinucleotídeo CTG no gene DMPK).
Miotonia congênita de Thomsen e Becker: Hipertrofia muscular generalizada ('aspecto hercúleo / de fisiculturista') com rigidez muscular após repouso e atraso no relaxamento voluntário muscular que melhora com o aquecimento motor contínuo.	Canalopatia de cloro muscular / Miotonia congênita (mutação no gene CLCN1).
Distrofia Muscular de Emery-Dreifuss: Tríade clássica: 1) contraturas articulares precoces de cotovelos em flexão e tendões de Aquiles antes de fraqueza evidente; 2) fraqueza muscular lentamente progressiva escápulo-úmero-peroneal; 3) cardiomiopatia com distúrbios graves de condução atrioventricular e morte súbita.	Distrofia Muscular de Emery-Dreifuss (mutação na emerina ligada ao X ou lamina A/C).
Neuromielite Óptica Pediátrica (NMOSD): Episódios graves e bilaterais simultâneos de neurite óptica com perda visual profunda associados a mielite transversa longitudinalmente extensa (> 3 corpos vertebrais na RNM) com anticorpos anti-Aquaporina-4 (anti-AQP4) ou anti-MOG positivos.	Espectro da Neuromielite Óptica (NMOSD) / Doença associada ao anti-MOG (MOGAD).
Encefalite Anti-Receptor NMDA: Menina ou adolescente que desenvolve pródromo viral seguido por psicose aguda bizarra, alucinações, perda de memória, mutismo, discinesias orofaciais involuntárias rítmicas de mastigação e lambedura, instabilidade autonômica e hipoventilação central.	Encefalite autoimune anti-NMDAR (associada a teratoma ovariano em até 30-50% das adolescentes).
Coreia de Sydenham pós-estreptocócica: 'Sinal da pega da leiteira' (a criança não consegue manter a força de preensão sustentada na mão do examinador, alternando aperto e relaxamento) associado a 'sinal do camaleão' (incapacidade de manter a língua protusa sem retrai-la involuntariamente).	Coreia menor de Sydenham / Febre Reumática.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Distonia responsiva a Dopa (Síndrome de Segawa): Distonia focal de membros inferiores com marcha na ponta dos pés em equinóvario de início na infância (4 a 8 anos), com piora diurna progressiva acentuada à tarde/noite, melhora expressiva após repouso noturno e resposta dramática sustentada a microdoses de levodopa.	Síndrome de Segawa (deficiência de GTP ciclo-hidrolase 1 - GCH1).
Doença de Moyamoya infantil: Episódios recorrentes de acidentes vasculares encefálicos isquêmicos transitórios (AITs) ou AVCs isquêmicos precipitados por hiperventilação, choro vigoroso ou ingestão de alimentos quentes, com angiografia cerebral revelando rede vascular telangiectásica colateral tênue na base do crânio com aspecto de 'fumaça de cigarro soprando no ar'.	Doença ou Síndrome de Moyamoya (estenose estenosante progressiva bilateral dos ramos terminais da carótida interna).
Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM): Encefalopatia aguda com alteração do nível de consciência, déficits neurológicos multifocais focais, perda visual e ataxia 1 a 3 semanas após virose ou vacinação, com ressonância magnética revelando lesões desmielinizantes hiperintensas em T2/FLAIR grandes, mal delimitadas e bilaterais assimétricas na substância branca profunda e núcleos da base.	Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM) (anticorpos anti-MOG frequentemente positivos na infância; excelente resposta a pulsoterapia com metilprednisolona).
Atrofia Muscular Espinhal tipo 2 (AME 2 - forma intermediária de Dubowitz): Lactente que adquire a capacidade de sentar sem apoio aos 6 a 8 meses, mas nunca adquire a marcha autônoma independente, associada a fraqueza muscular proximal simétrica, arreflexia profunda e tremor postural fino característico das mãos (minipolimioclonia).	AME tipo 2 (deleção homozigótica do éxon 7 do gene SMN1 com 3 cópias do gene SMN2).
Atrofia Muscular Espinhal tipo 3 (AME 3 - forma juvenil de Kugelberg-Welander): Criança que adquire marcha independente normal e desenvolve após os 18 meses a adolescência fraqueza muscular proximal lentamente progressiva de cinturas escapular e pélvica com marcha anserina simulando distrofia muscular de Becker com CK sérica normal ou discretamente elevada.	AME tipo 3.

7. GASTROENTEROLOGIA, HEPATOLOGIA E CIRURGIA PEDIÁTRICA (42 achados clínicos)

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Vômitos pós-prandiais não biliosos em jato progressivos e vigorosos , lactente constantemente voraz e faminto, desidratação grave com alcalose metabólica hipoclorêmica/hipocalêmica e oliva pilórica palpável em CSD.	Estenose Hipertrófica do Píloro (lactentes de 2 a 8 semanas de vida).
Vômitos biliosos verdes escuros de início abrupto nas primeiras semanas de vida em RN previamente hígido , com distensão e sinais precoces de choque séptico/hipovolêmico.	Má rotação intestinal complicada com volvo de intestino médio (emergência cirúrgica de catástrofe vascular).
Crises paroxísticas de choro inconsolável com flexão das pernas sobre o abdome intercaladas por períodos de letargia profunda , massa palpável em salsicha no hipocôndrio direito e fezes em geleia de framboesa .	Invaginação Intestinal / Intussuscepção aguda (3 a 24 meses de vida).
Falha ou atraso na eliminação do mecônio além das primeiras 48 horas de vida , distensão abdominal progressiva, vômitos biliosos e evacuação explosiva com gases após toque retal descompressivo .	Doença de Hirschsprung (Megacólon congênito aganglionar).
Distensão abdominal súbita, vômitos biliosos, hematoquezia, acidose metabólica grave refratária e pneumatose intestinal na radiografia abdominal em recém-nascido prematuro alimentado.	Enterocolite Necrosante (ECN).
Íleo meconial: Obstrução intestinal neonatal distal com mecônio viscoso e espesso aderido à parede do íleo terminal, causando microcólon de desuso ao enema opaco.	Fibrose Cística (apresentação neonatal clássica em 15-20% dos casos).
Dor periumbilical difusa migratória para a fossa ilíaca direita (ponto de McBurney) após 6 a 12 horas, associada a anorexia, náuseas, vômitos e febre baixa, com dor à descompressão súbita (Sinal de Blumberg).	Apendicite aguda (causa cirúrgica mais comum de abdome agudo na infância).
Dor à rotação interna passiva do quadril direito flexionado (Sinal do Obturador) e dor à hiperextensão passiva do membro inferior direito em decúbito lateral esquerdo (Sinal do Psoas) .	Apendicite aguda em posição atípica (obturador: apêndice pélvico; psoas: apêndice retrocecal).
Dor em fossa ilíaca direita desencadeada pela palpação profunda sustentada da fossa ilíaca esquerda com deslocamento de gases cólicos (Sinal de Rovsing positivo) .	Apendicite aguda.
Interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação sustentada do ponto cístico em hipocôndrio direito (Sinal de Murphy positivo) .	Colecistite aguda calculosa ou alitiásica.
Dor testicular aguda e severa unilateral de início súbito, testículo retraído elevado e horizontalizado (Sinal de Gouverneur) com abolição completa do reflexo cremastérico .	Torção de cordão espermático / Torção testicular (janela de isquemia crítica < 6 horas).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Nódulo azulado palpável e visível através da transparência da pele no polo superior do testículo (Sinal do Ponto Azul / Blue Dot Sign) com reflexo cremastérico preservado.	Torção de apêndice testicular (hidátide de Morgagni).
Tumefação ou massa firme dolorosa na região inguinal ou escroto irredutível à manobra de táxis, acompanhada de dor intensa, choro inconsolável e vômitos.	Hérnia inguinal encarcerada / estrangulada.
Massa escrotal indolor translúcida à iluminação com lanterna clínica direta no escroto escuro (Transiluminação positiva) que não varia de volume com o esforço.	Hidrocele congênita não comunicante (diferencial de hérnia inguinal).
Dor abdominal súbita intensa paroxística em menina pré-púbere acompanhada de massa pélvica palpável dolorosa e história de episódios autolimitados semelhantes prévios.	Torção de ovário / anexo.
Diarreia crônica osmótica, fezes volumosas esteatorreicas, distensão abdominal proeminente, hipotrofia muscular acentuada glútea e de membros e atraso ponderoestatural pós-introdução do glúten.	Doença Celíaca clássica (enteropatia sensível ao glúten).
Sangramento retal indolor vivo e maciço em lactente previamente hígido de 1 a 2 anos, sem sinais de peritonite ou obstrução mecânica.	Divertículo de Meckel (com mucosa gástrica ectópica ulcerada detectável por cintilografia).
Dor abdominal em fossa ilíaca direita simulando perfeitamente apendicite aguda em pré-escolar/escolar no curso ou logo após infecção de vias aéreas superiores com apêndice normal ao ultrassom.	Linfadenite mesentérica aguda.
Prurido anal intratável e excoriações com dor ao evacuar e eliminação de fezes com raias de sangue vivo e margem anal com eritema perianal vermelho brilhante bem delimitado.	Doença estreptocócica perianal (Streptococcus pyogenes).
Fístulas perianais complexas recorrentes, fissuras anais profundas atípicas e abscessos perirretais em criança associados a dor abdominal crônica e perda ponderal.	Doença de Crohn (Doença Inflamatória Intestinal pediátrica).
Presença de sangue vivo em estrias e muco nas fezes de lactente jovem em aleitamento materno ou fórmula, com bom estado geral, ativo e curva de ganho de peso inteiramente normal.	Proctocolite induzida por proteína alimentar / Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).
Disfagia mecânica progressiva com impactação de alimentos sólidos, vômitos crônicos, dor retroesternal em criança atópica com anéis traquealizados concêntricos à endoscopia.	Esofagite Eosinofílica (EoE).
Icterícia colestática flutuante, dor abdominal em hipocôndrio direito e massa cística palpável em abdome superior em menina (Tríade clássica do Cisto de Colédoco).	Cisto de Colédoco / Dilatação congênita das vias biliares (risco de colangite e colangiocarcinoma).
Colangite esclerosante com colite ulcerativa associada a elevação acentuada de gama-GT e fosfatase alcalina com aspecto de contas de rosário à colangiografia.	Colangite Esclerosante Primária (CEP) juvenil.
Insuficiência hepática aguda fulminante na infância com coagulopatia grave refratária (RNI > 2,0), encefalopatia hepática e hiperamonemia após uso de paracetamol ou virose.	Insuficiência Hepática Aguda Pediátrica (indicação de transplante hepático de urgência).
Dor abdominal em cólica periumbilical diária sem perda ponderal, sem sangue nas fezes, sem febre, com crescimento estatural rigorosamente normal e exame físico inocente.	Dor Abdominal Funcional da Infância / Síndrome do Intestino Irritável pediátrica.
Constipação intestinal crônica com retenção fecal voluntária (postura de contenção com pernas cruzadas) e escape fecal involuntário com fezes amolecidas nas roupas íntimas (Encoprese).	Constipação Intestinal Funcional com Incontinência Fecal por Retenção.
Enteropatia perdedora de proteínas com edema periférico bipalpebral e em membros inferiores, hipoalbuminemia grave e dosagem fecal de alfa-1-antitripsina muito elevada.	Enteropatia Perdedora de Proteínas / Linfangiectasia intestinal primária.
Dor epigástrica aguda em barra que se irradia para o dorso associada a vômitos incoercíveis, flexão antálgica do tronco e elevação de amilase e lipase > 3x o limite superior.	Pancreatite Aguda Pediátrica (causas mais comuns: trauma abdominal fechado por guidão de bicicleta, infecções virais, fármacos ou cálculos biliares).
Edema angioneurótico súbito unilateral da face com crepitação subcutânea à palpação após espirro forçado ou assoar o nariz pós-trauma orbitário.	Fratura em blow-out do assoalho orbitário com enfisema subcutâneo.
Otorreia sanguinolenta ou líquido translúcido pelo meato acústico externo, paralisia facial periférica ipsilateral e equimose retroauricular (Sinal de Battle).	Fratura de base do crânio (rochedo temporal).
Equimose periorbitária bilateral simétrica em óculos ('olhos de guaxinim' / sinal do panda) após trauma cranioencefálico fechado.	Fratura de base do crânio (fossa craniana anterior).
Sinal do duplo halo (halo claro e translúcido ao redor de mancha hemorrágica em gaze ou lençol) e presença de beta-2-transferina no fluido nasal.	Rinorreia líquórica / Fístula líquórica pós-traumática.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Dor torácica pleurítica aguda súbita, dispneia intensa, desvio traqueal contralateral à lesão, hipotensão arterial e ausência de murmúrio vesicular unilateral hipertimpânico.	Pneumotórax Hipertensivo (toracocentese descompressiva imediata no 2º EIC na linha hemiclavicular ou 4º/5º EIC na linha axilar média).
Ingestão cáustica com sialorreia, estridor, disfagia, queimação retroesternal e recusa de saliva em criança pré-escolar (contraindicação absoluta a lavagem gástrica ou emese induzida).	Esofagite cáustica aguda por ingestão de soda cáustica ou ácidos fortes.
Ingestão de bateria em botão / bateria de lítio alojada no esôfago (imagem radiográfica com duplo halo ou anel concêntrico na radiografia em AP).	Corpo estranho esofágico cáustico (remoção endoscópica de emergência < 2 horas para evitar fístula aortoesofágica).
Icterícia colestática neonatal associada a acolia fecal, déficit de alfa-1-antitripsina sérica e presença de glóbulos PAS-positivos resistentes à diastase nos hepatócitos.	Deficiência de Alfa-1-Antitripsina fenótipo PiZZ (principal causa genética de transplante hepático pediátrico).
Colestase intra-hepática neonatal grave com prurido intratável precoce mutilante, icterícia e níveis de Gama-GT sérica rigorosamente normais ou baixos.	Colestase Intra-hepática Familiar Progressiva tipo 1 ou 2 (PFIC 1 / Doença de Byler ou PFIC 2).
Colestase intra-hepática progressiva associada a prurido, esteatorreia e níveis de Gama-GT sérica acentuadamente elevados com cálculos biliares precoces.	Colestase Intra-hepática Familiar Progressiva tipo 3 (PFIC 3) (defeito no transportador MDR3 / ABCB4).
Dilatação cística congênita sacular e fusiforme não obstrutiva dos ductos biliares intra-hepáticos associada a ectasia tubular renal (rins esponja medulares).	Doença de Caroli / Síndrome de Caroli (risco elevado de colangite bacteriana e colangiocarcinoma).
Esplenomegalia maciça isolada com hiperesplenismo (pancitopenia) e circulação colateral periumbilical em criança com antecedente de cateterismo umbilical neonatal.	Hipertensão Portal Pré-Hepática por Trombose de Veia Porta (cavernoma de veia porta).
Hepatomegalia dolorosa aguda, ascite refratária de rápida evolução e falência hepática decorrente de trombose ou oclusão das veias supra-hepáticas.	Síndrome de Budd-Chiari.

8. CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA, CARDIOPATIAS CONGÊNTAS E ARRITMIAS (36 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Sopro contínuo em maquinaria (Sopro de Gibson) de maior intensidade no foco pulmonar e região infraclavicular esquerda, associado a pulsos arteriais periféricos em martelo d'água (célere e amplo) e PA divergente.	Persistência do Canal Arterial (PCA).
Pulsos femorais filiformes, débeis ou impalpáveis em membros inferiores em nítido contraste com pulsos radiais amplos e cheios nos membros superiores, com gradiente de PAS > 20 mmHg entre braço e perna.	Coarctação da Aorta.
Crise de cianose intensa aguda com hiperpneia e agitação extrema precipitada por choro ou evacuação, que cede imediatamente quando a criança assume a postura genupeitoral ou de cócoras (squatting).	Crise hipoxêmica na Tetralogia de Fallot.
Sopro sistólico de ejeção em foco pulmonar acompanhado de desdobramento amplo e fixo da segunda bulha cardíaca (B2) que não sofre variação durante as fases da respiração.	Comunicação Interatrial (CIA).
Sopro holossistólico / pansistólico em barra de alta frequência no bordo esternal inferior esquerdo com frêmito tátil palpável, sudorese profusa durante as mamadas e baixo ganho de peso.	Comunicação Interventricular (CIV).
Cianose central precoce e isolada nas primeiras horas de vida sem desconforto respiratório inicial relevante (cianose feliz) que não apresenta aumento de saturação ao teste de hiperóxia (FiO2 100%).	Transposição das Grandes Artérias (TGA) (circulação em paralelo dependente de mistura interatrial).
Taquicardia regular extrema e paroxística de frequência mantida > 220 bpm no lactente ou > 180 bpm na criança maior, com início e término súbitos, sem variabilidade batimento a batimento e QRS estreito.	Taquicardia Supraventricular Paroxística (TSVP) (reentrada nodal ou via acessória oculta/WPW).
Tríade eletrocardiográfica de Wolff-Parkinson-White: Intervalo PR curto (< 0,12s), presença de onda delta (empastamento inicial do QRS) e alargamento da duração do QRS.	Síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW).
B1 hiperfonética com estalido de abertura e sopro diastólico em ruflar no ápice cardíaco com reforço pré-sistólico após surto prévio de Febre Reumática.	Estenose Mitral reumática crônica.
Sopro holossistólico de alta frequência em foco mitral que se irradia para a linha axilar anterior esquerda associado a terceira bulha (B3) protodiastólica.	Insuficiência Mitral reumática aguda.
Ritmo de galope ventricular com B3 e B4, taquicardia desproporcional à temperatura corporal, cardiomegalia rápida e hepatomegalia dolorosa reflexa após pródromo viral febril.	Miocardite viral aguda (Enterovírus, Coxsackie B, Adenovírus).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Atrito pericárdico superficial audível em vaivém em bordo esternal esquerdo que se intensifica com a inclinação do tórax para a frente , dor torácica pleurítica que alivia ao sentar.	Pericardite aguda.
Triáde de Beck: Hipotensão arterial sistêmica com diminuição da pressão de pulso, abafamento nítido das bulhas cardíacas e turgência jugular patológica bilateral.	Tamponamento Cardíaco agudo (emergência para pericardiocentese).
Queda patológica da pressão arterial sistólica superior a 10 mmHg durante a inspiração espontânea (Pulso paradoxal) associada a taquicardia e estase jugular.	Tamponamento Cardíaco / Crise de asma aguda grave com hiperinsuflação.
Sopro sistólico vibratório ou musical suave (grau I-II/VI) de frequência média melhor audível entre a borda esternal esquerda média e o ápice, que diminui em intensidade na posição de pé.	Sopro inocente de Still (ruído acústico benigno do fluxo da via de saída do VE).
Zumbido contínuo musical suave infraclavicular e cervical que se intensifica com a rotação da cabeça e desaparece completamente à compressão manual da veia jugular interna ipsilateral.	Hum venoso cervical / Zumbido venoso (sopro funcional contínuo fisiológico benigno).
Intervalo QT corrigido pelo método de Bazett (QTc) prolongado > 460 ms em meninas ou > 450 ms em meninos associado a síncope ao esforço físico, susto acústico ou estresse.	Síndrome do QT Longo Congênito (Síndrome de Romano-Ward / Jervell e Lange-Nielsen).
Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT) congênito no feto ou recém-nascido com bradicardia sinusal sustentada < 55-60 bpm intraútero em mãe com lúpus ou anticorpos anti-Ro/SSA e anti-La/SSB positivos.	Lúpus Neonatal (lesão autoimune fibrótica irreversível do nó atrioventricular fetal).
Sopro contínuo em maquinaria que aumenta na sístole em região torácica posterior ou interescapulovertebral associado a frêmito e fístula arteriovenosa.	Malformação Arteriovenosa Pulmonar congênita / Síndrome de Rendu-Osler-Weber.
Sopro sistólico áspero de ejeção em foco aórtico com irradiação para as artérias carótidas, pulso parvus et tardus e frêmito na fúrcula esternal.	Estenose Aórtica congênita valvar ou subvalvar.
Síncope cardíaca súbita durante esforço físico extenuante em adolescente atleta previamente assintomático com sopro sistólico que aumenta com a manobra de Valsalva.	Cardiomiopatia Hipertrófica congênita / Obstrução da via de saída do VE.
Elevação súbita do segmento ST com aspecto em sela de cavalo ou côncavo com bloqueio incompleto do ramo direito em derivações V1-V2 (Padrão de Brugada) associado a morte súbita noturna.	Síndrome de Brugada.
Dor torácica súbita lancinante com irradiação interescapular associada a assimetria pressórica > 20 mmHg entre membros superiores em paciente com Síndrome de Marfan ou Turner.	Dissecção Aguda de Aorta torácica.
Febre prolongada inexplicada, sopro cardíaco regurgitante novo, petéquias subungueais em estilhaço, nódulos dolorosos de Osler nas polpas digitais e manchas retinianas de Roth.	Endocardite Infecçiosa subaguda / aguda (critérios modificados de Duke).
Origem anômala da artéria coronária esquerda a partir do tronco da artéria pulmonar (Síndrome de ALCAPA / Bland-White-Garland) manifestando-se no 1º-2º mês com infarto agudo do miocárdio, choro durante as mamadas e insuficiência cardíaca grave.	Síndrome de ALCAPA (urgência para reimplante cirúrgico da artéria coronária na aorta).
Estridor inspiratório e expiratório crônico em lactente associado a engasgos frequentes e disfagia que piora com sólidos (disfagia lusória) decorrente de compressão circunferencial da traqueia e esôfago.	Duplo Arco Aórtico / Anel Vascular congênito.
Imagem radiográfica de coração em boneco de neve ou figura em oito por dilatação da veia cava superior e tronco inominado em lactente com cianose e hiperfluxo pulmonar.	Drenagem Anômala Total de Veias Pulmonares (DATVP) supracardíaca.
Cianose extrema com hipofluxo pulmonar ao nascimento, sopro sistólico regurgitante suave e onda de pulso venoso com onda 'a' gigante associada a hipertrofia de átrio esquerdo e sobrecarga de VE ao ECG.	Atresia Tricúspide congênita.
Cardiomegalia maciça com imagem em balão / coração em moringa que ocupa quase todo o tórax ao RX, cianose, sopro holossistólico regurgitante de regurgitação tricúspide gigante e bloqueio de ramo direito com pré-excitação.	Anomalia de Ebstein grave da valva tricúspide (atrialização do ventrículo direito).
Síndrome da Hipoplasia do Ventrículo Esquerdo (SHVE): Colapso hemodinâmico súbito e choque cardiogênico com cianose cinzenta pálida, pulsos periféricos universalmente abolidos e acidose láctica grave no 3º a 7º dia de vida com o fechamento fisiológico do canal arterial.	Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo (cardiopatia canal-dependente de circulação sistêmica; emergência para infusão contínua de Prostaglandina E1 / Alprostadil IV).
Tronco Arterioso Comum (Truncus Arteriosus): Tronco arterial único que se origina da base do coração e supre as circulações sistêmica, coronariana e pulmonar, associado a sopro holossistólico, pulsos amplos divergentes, cianose leve e insuficiência cardíaca congestiva precoce com taquipneia.	Truncus Arteriosus (fortemente associado à microdeleção 22q11.2 / DiGeorge).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Atresia Pulmonar com Septo Interventricular Íntegro: Cianose central profunda grave imediata pós-nascimento com hipofluxo pulmonar absoluto, dependência obrigatória de canal arterial patente e hipoplasia acentuada de ventrículo direito.	Atresia pulmonar crítica canal-dependente de fluxo pulmonar.
Defeito do Septo Atrioventricular Total (DSAV Total): Sopros sistólicos e diastólicos de hiperfluxo e regurgitação atrioventricular, hiperfonese acentuada de B2, insuficiência cardíaca de alto débito aos 2-3 meses com hipertensão pulmonar precoce e eixo elétrico desviado para o quadrante superior esquerdo (entre -30° e -90°) ao ECG.	DSAV Total congênito (cardiopatia clássica da Síndrome de Down presente em > 40%).
Coarctação crítica de aorta em choque neonatal: Queda abrupta de débito cardíaco com anúria, acidose e choque cardiogênico no 5º ao 10º dia de vida com o fechamento do canal arterial com gradiente de pressão arterial braço-coxa não avaliável pelo choque.	Coarctação de aorta crítica justaductal (salvação imediata com Prostaglandina E1 para reabrir o ductus arteriosus).
Sopro de Carey-Coombs: Ruflar mesodiastólico suave e transitório em foco mitral sem estalido de abertura que surge durante a fase aguda inflamatória da cardite reumática e desaparece com a resolução da febre reumática.	Valvulite mitral aguda da Febre Reumática (edema e espessamento inflamatório das cúspides mitrais).
Sopro da Estenose Pulmonar Periférica (Sopro de ramos pulmonares fisiológico do lactente): Sopro sistólico ejetivo precoce suave (grau I-II/VI) de baixa frequência melhor audível nas axilas e dorso bilateralmente em lactente de 1 a 3 meses.	Sopro fisiológico transitório do lactente por angulação aguda dos ramos pulmonares (desaparece espontaneamente aos 6 meses).

9. PNEUMOLOGIA, MALFORMAÇÕES BRONCOPULMONARES E OTORRINOLARINGOLOGIA (21 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Estridor inspiratório agudo, musical ou em grasnido em lactente nas primeiras semanas de vida que piora em decúbito dorsal e ao choro e melhora acentuadamente em pronação.	Laringomalácia congênita (colapso inspiratório das cartilagens aritenóides e epiglote em ômega).
Estridor bifásico (inspiratório e expiratório) ou expiratório de tom metálico e tosse em latido que não varia com o decúbito e piora com choro e agitação.	Traqueomalácia congênita ou Estenose subglótica.
Síndrome de penetração: Acesso agudo súbito e violento de tosse, engasgo, asfixia e cianose transitória em criança entre 1 e 3 anos, seguido de tosse seca e sibilos unilaterais.	Aspiração de Corpo Estranho de vias aéreas.
Sibilância expiratória unilateral persistente fixa e assimétrica, acompanhada de diminuição localizada do murmúrio vesicular e enfisema obstrutivo unilateral à radiografia de tórax expirada.	Corpo estranho brônquico com mecanismo de válvula unidirecional.
Rinorreia mucopurulenta profusa fétida unilateral estritamente restrita a uma das fossas nasais associada a respiração ruidosa em criança pré-escolar.	Corpo estranho intranasal esquecido.
Otorreia crônica unilateral fétida indolor com pólipos no conduto auditivo e visualização de massa branca nacarada escamosa na pars flaccida timpânica à otoscopia.	Colesteatoma adquirido de orelha média.
Edema eritematoso retroauricular doloroso, flutuante, com apagamento do sulco retroauricular e projeção anterior e inferior do pavilhão auricular após episódio de OMA.	Mastoidite aguda (complicação supurativa de otite média aguda).
Tríade da Síndrome de Kartagener: Situs inversus totalis (com dextrocardia), bronquiectasias cilíndricas bilaterais precoces e sinusopatia crônica com polipose nasal.	Síndrome de Kartagener / Discinesia Ciliar Primária (ausência de braços de dineína ciliar).
Doença pulmonar crônica supurativa precoce, sinusite recorrente crônica, íleo meconial, esteatorreia com síndrome de má absorção e concentração de cloreto no suor ≥ 60 mEq/L.	Fibrose Cística / Mucoviscidose (mutação no gene CFTR).
Massa nodular arredondada firme no trajeto da linha média anterior do pescoço que se move verticalmente à deglutição voluntária ou protrusão da língua.	Cisto do ducto tireoglossos.
Orifício fistuloso ou cisto localizado na borda anterior do músculo esternocleidomastoideo (terço médio/inferior) com eliminação de secreção mucosa ou infecções recorrentes.	Cisto ou fístula do 2º arco branquial.
Tumefação cística multilobulada volumosa translúcida macia no triângulo cervical posterior ou base do pescoço ao nascimento que transilumina amplamente.	Higroma cístico cervical / Linfangioma congênito.
Primeiro episódio de sibilância expiratória e estertores subcrepitantes difusos precedidos por 2-3 dias de coriza e febre em lactente menor de 2 anos no outono/inverno.	Bronquiolite Viral Aguda (Vírus Sincicial Respiratório - VSR).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Tiragem subcostal acentuada, retração de fúrcula esternal, batimento de asa nasal e gemência expiratória audível a distância sem estetoscópio.	Insuficiência respiratória aguda grave (esforço inspiratório e mecanismo expiratório de autopEEP).
Massa pulmonar cística congênita com múltiplos cistos radiotransparentes de paredes finas comunicantes com a árvore traqueobrônquica causando desconforto neonatal.	Malformação Congênita das Vias Aéreas Pulmonares (CPAM / antiga MAVP).
Massa pulmonar parenquimatosa cística sólida sem comunicação com a árvore brônquica que recebe vascularização arterial sistêmica anômala direta da aorta.	Sequestro Pulmonar broncopulmonar (intralobar ou extralobar).
Hiperinsuflação maciça progressiva de um único lobo pulmonar (mais comum: lobo superior esquerdo) com compressão do parênquima adjacente e desvio do mediastino.	Enfisema Lobar Congênito (hiperinsuflação lobar infantil).
Lesão cística congênita unilocular mediastinal de paredes finas contendo muco e epitélio respiratório ciliado próxima à bifurcação da traqueia.	Cisto Broncogênico congênito.
Hipoplasia pulmonar grave com pneumotórax espontâneo bilateral no RN decorrente de oligoidrânio acentuado prolongado por agenesia renal bilateral.	Sequência de Potter clássica.
Dependência contínua de oxigênio suplementar aos 28 dias de vida ou às 36 semanas de idade pós-menstrual em prematuro com alterações císticas na radiografia.	Displasia Broncopulmonar (DBP) / Doença Pulmonar Crônica da Prematuridade.
Hemorragia alveolar difusa recorrente manifestando-se como tosse com hemoptise, anemia ferropriva refratária persistente e infiltrados pulmonares micronodulares bilaterais.	Hemossiderose Pulmonar Idiopática.

10. NEFROLOGIA, UROLOGIA E DISTÚRBIOS TUBULARES (36 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Tríade Nefrítica clássica: Hematúria glomerular macroscópica (urina cor de refrigerante de cola / chá mate escuro), hipertensão arterial sistêmica aguda e edema matinal periorbitário.	Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica (GNPE) (1-3 semanas pós-faringite ou 3-6 semanas pós-piodermite).
Edema anasarcado progressivo com proteinúria maciça nefrótica (> 50 mg/kg/dia ou relação P/C urinária > 2,0), hipoalbuminemia grave (< 2,5 g/dL) e hipercolesterolemia em pré-escolar.	Síndrome Nefrótica por Lesão Renal Mínima (DLM - responsável por > 85% dos casos em crianças de 1 a 6 anos).
Tríade clássica da Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU): Anemia hemolítica microangiopática com esquizócitos abundantes, trombocitopenia de consumo e injúria renal aguda oligúrica pós-diarreia sanguinolenta.	SHU típica / D+ (infecção por <i>Escherichia coli</i> produtora de Shiga-toxina - STEC O157:H7).
Episódios recorrentes de hematúria macroscópica glomerular sincrônica dentro de 24-48 horas de infecções do trato respiratório superior (hematúria sinfaríngea) com complemento C3 normal.	Nefropatia por IgA / Doença de Berger.
Hematúria glomerular microscópica ou macroscópica persistente associada a perda auditiva neurosensorial bilateral progressiva e lenticone anterior ocular com insuficiência renal na adolescência.	Síndrome de Alport (mutação no colágeno tipo IV ligado ao X).
Jato urinário fraco, entrecortado, em gotas, com esforço miccional intenso em recém-nascido do sexo masculino, associado a bexigoma palpável tenso em abdome inferior e hidronefrose bilateral.	Valva de Uretra Posterior (VUP) (principal causa obstrutiva congênita de uropatia grave no menino).
Poliúria, polidipsia, constipação crônica, vômitos de repetição e atraso grave do crescimento com alcalose metabólica hipocalêmica e hipoclorêmica com PA normal e hipercalcúria.	Síndrome de Bartter (mutação nos transportadores da alça de Henle imitando uso de furosemida).
Alcalose metabólica hipocalêmica com hipomagnesemia severa e hipocalciúria em criança maior ou adolescente, mimetizando o uso crônico de diuréticos tiazídicos.	Síndrome de Gitelman (mutação no cotransportador Na-Cl do túbulo contorcido distal).
Glicosúria com glicemia normal, aminoacidúria generalizada, fosfatúria com hipofosfatemia, acidose tubular renal tipo II (proximal) e raquitismo.	Síndrome de Fanconi renal (investigar cistinose, tirosinemia ou galactosemia).
Nefrite intersticial aguda com tríade clássica: Febre, exantema máculo-papular eritematoso e eosinofilia com eosinofília após início de antibióticos beta-lactâmicos ou AINEs.	Nefrite Intersticial Aguda por Hipersensibilidade (NIA).
Abertura ectópica do meato uretral na face ventral da glândula, corpo peniano ou períneo, associada a curvatura ventral do pênis (<i>chordee</i>) e capuchão prepucial dorsal incompleto.	Hipospádia (contra-indicação formal à circuncisão neonatal para preservação de enxerto).
Testículo não palpável na bolsa escrotal ao nascimento que não é mobilizado até o fundo escrotal por manobras suaves em ambiente aquecido.	Criptorquidia / Testículo retido (indicação de orquidopexia idealmente entre 6 e 18 meses).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Hipertensão arterial severa paroxística associada à tríade clássica de cefaleia pulsátil, sudorese profusa e palpitações taquicárdicas em adolescente.	Feocromocitoma / Paraganglioma pediátrico (dosagem de metanefrinas urinárias e plasmáticas fracionadas elevadas).
Hematuria glomerular macroscópica indolor após esforço físico intenso em paciente jovem com rim esquerdo comprimido entre a artéria mesentérica superior e a aorta.	Síndrome de Quebra-Nozes (Nutcracker Syndrome).
Dor lombar em cólica aguda intensa com irradiação para o flanco e genitália ipsilateral associada a hematuria e vômitos em adolescente.	Cólica Nefrética / Nefrolitíase obstrutiva.
Oligúria com urina de coloração castanho-escura acastanhada ('chá escuro / cerveja preta') pós-exercício extenuante ou trauma por esmagamento com CK sérica maciçamente elevada (> 20.000 U/L).	Rabdomiólise com Mioglobínúria (risco de injúria renal aguda por precipitação tubular).
Fraqueza muscular flácida ascendente, ondas T apiculadas e simétricas ('em tenda'), alargamento do complexo QRS e achatamento da onda P ao ECG.	Hipercalcemia grave ($K^+ > 6,5 - 7,0 \text{ mEq/L}$) (emergência: Gluconato de Cálcio IV imediato).
Fraqueza muscular generalizada com câibras, íleo paralítico abdominal, hiporreflexia e ECG mostrando depressão de ST, achatamento de onda T e onda U proeminente.	Hipocalcemia grave ($K^+ < 2,5 \text{ mEq/L}$).
Síndrome nefrótica congênita maciça instalada intraútero ou nas primeiras semanas de vida com placenta gigante edemaciada, proteinúria extrema e mutação na nefrina.	Síndrome Nefrótica Congênita do Tipo Finlandês (mutação no gene NPHS1).
Proteinúria de baixo peso molecular (beta-2-microglobulina), hipercalcúria grave, nefrocalcinose medular bilateral precoce, nefrolitíase e insuficiência renal progressiva em meninos.	Doença de Dent (mutação no canal de cloro CLCN5 ligada ao X).
Tríade Oculo-Cérebro-Renal de Lowe: Catarata congênita bilateral densa com glaucoma, hipotonia neonatal grave com retardo mental e tubulopatia de Fanconi com acidose tubular renal.	Síndrome de Lowe (mutação no gene OCRL1 ligado ao X).
Cálculos urinários radiopacos recidivantes na infância com eliminação de cristais hexagonais planos característicos na urina à microscopia e teste de cianeto-nitroprussiato positivo.	Cistinúria hereditária clássica (defeito no transporte dibásico renal de cistina, ornitina, lisina e arginina - COLA).
Poliúria acentuada, polidipsia intensa, febre recorrente inexplicada no lactente, atraso no desenvolvimento com sódio sérico elevado (> 150-160 mEq/L) e osmolaridade urinária persistentemente baixa refratária ao DDAVP.	Diabetes Insipidus Nefrogênico congênito ligado ao X (mutação no receptor AVPR2 da vasopressina).
Acidose tubular renal distal (tipo I) associada a hipocalcemia, nefrocalcinose medular bilateral grave e perda auditiva neurosensorial bilateral de início precoce.	Acidose Tubular Renal Distal com Surdez Neurosensorial (mutação nas subunidades da bomba H^+ -ATPase).
Trombose de Veia Renal Neonatal: Tríade clássica no recém-nascido (especialmente filho de mãe diabética): massa palpável súbita no flanco, hematuria macroscópica e trombocitopenia de consumo rápida associada a hipertensão arterial.	Trombose aguda da veia renal neonatal.
Necrose de Papila Renal em Falciforme: Hematuria macroscópica súbita e indolor com cólica nefrética por eliminação de fragmentos teciduais papilares necróticos na urina em paciente com anemia falciforme ou traço falcêmico.	Necrose papilar renal isquêmica.
Hiperoxalúria Primária tipo 1: Nefrolitíase bilateral de repetição por cálculos de oxalato de cálcio monohidratado desde o 1º ano de vida associada a nefrocalcinose medular extensa e insuficiência renal terminal precoce com depósitos de oxalato no miocárdio e ossos.	Hiperoxalúria Primária tipo 1 (deficiência da enzima hepática alanina-glioxilato aminotransferase - AGXT).
Cistite Hemorrágica Aguda Viral: Disúria súbita de início agudo, polaciúria, urgência miccional e hematuria macroscópica profusa com coágulos em pré-escolar do sexo masculino com cultura de urina negativa.	Cistite hemorrágica por Adenovírus (sorotipos 11 e 21) (condição autolimitada em 3 a 5 dias).
Ureterocele com Duplicidade Pieloureteral: Massa cística intravesical translúcida de colo dilatado associada a polo superior renal displásico não funcionante e infecções do trato urinário febris de repetição.	Duplicidade pieloureteral completa com ureterocele obstrutiva ectópica.
Síndrome de Bernard-Soulier: Diátese hemorrágica mucocutânea grave desde o nascimento com trombocitopenia moderada, plaquetas gigantes ao esfregaço (VPM > 14-16 fL) e falha de aglutinação plaquetária induzida por ristocetina que não se corrige com plasma normal.	Síndrome de Bernard-Soulier (defeito no complexo glicoproteico plaquetário GPIb-IX-V).
Trombastenia de Glanzmann: Sangramento mucocutâneo volumoso grave com tempo de sangramento muito prolongado, contagem de plaquetas estritamente normal, morfologia plaquetária normal e ausência total de agregação plaquetária a ADP, colágeno e epinefrina com aglutinação à ristocetina preservada.	Trombastenia de Glanzmann (ausência ou disfunção do complexo de integrina alfa-IIb/beta-3 / GPIIb-IIIa).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Deficiência Congênita de Fator XIII (Fator Estabilizador da Fibrina): Sangramento umbilical profuso persistente tardio que surge dias após o desprendimento do coto umbilical, hemorragia intracraniana espontânea e má cicatrização tecidual com formação de queloides exuberantes e coagulograma habitual (TP, TTPa, TT e fibrinogênio) inteiramente normal.	Deficiência congênita de Fator XIII (solubilidade do coágulo de fibrina em ureia a 5M ou ácido monocloroacético).
Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) infantil: Hemólise intravascular crônica com urina escura acastanhada matinal ('urina cor de vinho do porto'), trombooses venosas em locais atípicos (veia porta, veias supra-hepáticas) e citometria de fluxo com ausência de proteínas ancoradas por GPI (CD55 e CD59).	Hemoglobinúria Paroxística Noturna (mutação somática no gene PIGA).
Artrite séptica por <i>Kingella kingae</i>: Artrite monoarticular subaguda oligossintomática do joelho ou tornozelo em criança de 6 a 36 meses com febre baixa ou ausente, leucograma e PCR discretamente elevados e líquido sinovial com coloração de Gram negativa.	Artrite por <i>Kingella kingae</i> (principal patógeno articular em menores de 4 anos; diagnóstico por PCR específico).
Osteomielite por <i>Pseudomonas</i> pós-ferimento perfurante: Dor óssea persistente no pé, calor local e destruição cortical da cabeça de metatarso semanas após ferimento perfuro-cortante plantar através da sola de borracha do calçado esportivo / tênis.	Osteomielite ou osteocondrite por <i>Pseudomonas aeruginosa</i>.
Osteomielite aguda em portador de Doença Falciforme: Dor óssea em ossos longos acompanhada de febre alta, bacteremia e hemocultura revelando bacilos Gram-negativos encapsulados.	Osteomielite por <i>Salmonella</i> não tifoide (patógeno característico associado à asplenia funcional e infartos intestinais falcêmicos).

11. HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA PEDIÁTRICA E SÍNDROMES NEOPLÁSICAS (24 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Dactilite falcêmica (Síndrome Mão-Pé): Edema bilateral tenso, quente e intensamente doloroso no dorso das mãos e/ou pés em lactente falciforme entre 6 meses e 2 anos de idade.	Doença Falciforme (Anemia Falciforme SS) (primeira manifestação vaso-oclusiva típica pós-queda da Hb fetal).
Esplenomegalia dolorosa de rápido crescimento com choque hipovolêmico, palidez intensa aguda e queda abrupta de mais de 2 g/dL nos níveis de hemoglobina em lactente falciforme.	Crise de Sequestro Esplênico agudo (emergência hematológica com alto risco de óbito).
Infiltrado pulmonar novo na radiografia de tórax associado a febre, dor torácica, tosse, taquipneia e hipoxemia em paciente portador de doença falciforme.	Síndrome Torácica Aguda (STA) (principal causa de óbito na doença falciforme).
Queda abrupta e isolada da contagem de reticulócitos (< 1%) com parada da eritropoiese e queda acentuada da hemoglobina após infecção viral por Parvovírus B19 em paciente com anemia hemolítica prévia.	Crise Aplásica Transitória.
Anemia hemolítica crônica regenerativa, esplenomegalia, icterícia flutuante e presença de esferócitos hiperconrados microcíticos sem halo central no esfregaço com Coombs direto negativo.	Esferocitose Hereditária (teste de fragilidade osmótica aumentado - defeito de anquirina/espectrina).
Episódios agudos de icterícia súbita, palidez, urina escura (cor de coca-cola) e hemólise intravascular aguda desencadeados por uso de sulfas, primaquina, dapsona ou ingestão de favas.	Deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD) (presença de corpúsculos de Heinz).
Instalação abrupta de petéquias, púrpuras e equimoses disseminadas em criança hígida 1-3 semanas pós-virose, afebril, sem visceromegalias e plaquetopenia isolada com Hb e glóbulos brancos normais.	Púrpura Trombocitopênica Imunológica (PTI) aguda da infância.
Hemartrose espontânea dolorosa ou pós-trauma mínimo com limitação articular grave (joelho, tornozelo, cotovelo) e hematomas musculares profundos em menino com alargamento isolado do TTPa.	Hemofilia A (deficiência de Fator VIII) ou Hemofilia B (deficiência de Fator IX).
Dor óssea metafisária intensa contínua que acorda a criança à noite ou recusa de marcha, palidez progressiva, febre inexplicada, petéquias e hepatoesplenomegalia/adenomegalia generalizada.	Leucemia Linfoide Aguda (LLA) (neoplasia maligna mais frequente da infância).
Linfonodo supraclavicular ou escalênico palpável, pétreo, indolor, aderido a planos profundos, maior que 2 cm e persistente além de 4 semanas.	Neoplasia maligna (Linfoma de Hodgkin ou Não-Hodgkin, metástase de tumor sólido) até prova em contrário.
Massa volumosa retroperitoneal/abdominal que ultrapassa a linha média anatômica, consistência endurecida, febre, perda ponderal, hipertensão e proptose com equimose periorbitária (olhos de guaxinim).	Neuroblastoma metastático (estágio M - metástase periocular no osso orbitário).
Massa abdominal palpável lisa, firme, bem delimitada, assintomática, que raramente cruza a linha média, descoberta acidentalmente pelos pais durante o banho em pré-escolar.	Tumor de Wilms / Nefroblastoma.
Tumor mandibular ou maxilar de crescimento explosivo de rápida duplicação celular associado a dor local e perda dentária em criança em região equatorial.	Linfoma de Burkitt endêmico (translocação t(8;14) envolvendo oncogene c-MYC associado ao vírus EBV).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Lesões osteolíticas em soco na calota craniana ('crânio em mapa geográfico'), proptose ocular, diabetes insipidus central e dermatite eczematosa seborreica em couro cabeludo.	Histiocitose de Células de Langerhans (Tríade clássica de Hand-Schüller-Christian).
Dor óssea localizada profunda que piora à noite com aumento de volume local, calor e imagem radiográfica em padrão de raio de sol e triângulo de Codman em metáfise de fêmur distal ou tíbia proximal.	Osteossarcoma.
Dor óssea diafisária associada a febre, leucocitose, VHS elevado simulando osteomielite, com imagem radiográfica de aposição periosteal em casca de cebola.	Sarcoma de Ewing (translocação t(11;22)).
Síndrome de Blackfan-Diamond (Eritroblastopenia Congênita Pura): Anemia macrocítica congênita grave e progressiva nos primeiros meses de vida com contagem de reticulócitos quase zerada e celularidade mieloide e megacariocítica normais na medula, associada a polegares trifalângicos e microcefalia.	Anemia de Blackfan-Diamond (ribossomopatia por mutações nos genes de proteínas ribossômicas como RPS19).
Síndrome de Shwachman-Diamond: Neutropenia crônica ou cíclica grave, insuficiência pancreática exócrina com esteatorreia e má absorção com teste do suor normal (diferente da fibrose cística) e displasia metafisária esquelética.	Síndrome de Shwachman-Diamond (mutação no gene SBDS).
Disceratose Congênita: Tríade mucocutânea clássica: 1) pigmentação reticulada rendilhada acastanhada em pescoço e tórax; 2) distrofia e atrofia ungueal com estrias longitudinais; 3) leucoplasia oral de mucosas com alto risco de aplasia medular e malignidade.	Disceratose Congênita (doença dos telômeros por mutações nos genes DKC1 ou TERC).
Trombocitopenia Amegacariocítica Congênita (CAMT): Trombocitopenia grave isolada com sangramento mucocutâneo volumoso presente ao nascimento com megacariócitos ausentes na medula óssea que evolui para pancitopenia total e aplasia nos primeiros anos de vida sem anomalias esqueléticas de membros.	CAMT congênita (mutação no receptor de trombopoietina MPL).
Talassemia Major (Anemia de Cooley): Anemia microcítica e hipocrômica grave e dependente de transfusão a partir dos 6 meses de vida, hepatoesplenomegalia volumosa e alterações ósseas craniofaciais em 'fácies em esquilo / fácies talassêmica' com aspecto de 'cabelos em ponta' ao RX de crânio por expansão medular.	Beta-Talassemia Major homozigótica.
Púrpura Fulminante Neonatal: Lesões purpúricas e equimóticas extensas de rápida progressão que evoluem para necrose tecidual hemorrágica negra em extremidades e períneo com coagulação intravascular disseminada fulminante no recém-nascido.	Deficiência Congênita Homozigótica Grave de Proteína C ou Proteína S.
Doença de von Willebrand tipo 3: Sangramentos mucocutâneos espontâneos graves recorrentes (epistaxes maciças, gengivorragias, menorragias volumosas) associados a hemartroses graves e hematomas musculares mimetizando hemofilia por níveis praticamente indetectáveis de Fator VIII e Fator de von Willebrand.	Doença de von Willebrand tipo 3 (forma recessiva grave).
Linfoma de Hodgkin em adolescente: Linfadenopatia cervical ou supraclavicular indolor móvel de consistência elástica ('em borracha de apagar'), massa mediastinal anterior volumosa e sintomas B (febre inexplicada vespertina contínua, sudorese noturna profusa e perda de > 10% do peso).	Linfoma de Hodgkin (células gigantes de Reed-Sternberg em 'olhos de coruja' à biópsia).

12. ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, METABOLOGIA E DISTÚRBIOS DO CRESCIMENTO (24 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Icterícia neonatal prolongada por bilirrubina indireta, fontanela posterior ampla (> 0,5 cm), macroglossia, hérnia umbilical, hipotonia e choro rouco.	Hipotireoidismo congênito clássico (triagem pelo teste do pezinho - risco de cretinismo).
Poliúria acentuada com enurese secundária, polidipsia intensa, polifagia e perda ponderal rápida inexplicada em criança previamente hígida.	Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) (destruição autoimune de células beta pancreáticas).
Respiração de Kussmaul (hiperpnéia profunda e rápida), desidratação grave, vômitos, dor abdominal em cólica simulando abdome agudo cirúrgico, hálito cetônico e letargia.	Cetoacidose Diabética (CAD).
Hiperpigmentação cutânea difusa acentuada (em dobras, cicatrizes e aréolas), hipotensão arterial crônica, astenia, perda ponderal, hiponatremia e hipercalemia.	Doença de Addison / Insuficiência Adrenal primária crônica.
Desenvolvimento de caracteres sexuais secundários (telarca ou pubarca) antes dos 8 anos em meninas ou aumento do volume testicular (> 4 mL) antes dos 9 anos em meninos com avanço de idade óssea.	Puberdade Precoce (investigar etiologia central dependente de GnRH vs periférica).
Virilização precoce com pubarca rápida em menino com testículos infantis (< 4 mL) ou virilização com clitoromegalia em menina sem aumento de mama e com idade óssea muito avançada.	Puberdade precoce periférica por Hiperplasia Adrenal Congênita não clássica ou tumor adrenal.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Genu varo progressivo acentuado, rosário raquítico palpável nas articulações costoverbrais, sulco de Harrison e alargamento em taça metafisária dos punhos e tornozelos.	Raquitismo carencial por deficiência de Vitamina D.
Tetania neuromuscular, espasmo carpopedal espontâneo ou induzido por insuflação do manguito pressórico (Sinal de Trousseau) e contração da musculatura facial à percussão do nervo facial (Sinal de Chvostek).	Hipocalcemia sintomática / Hipoparatiroidismo.
Baixa estatura desproporcional com encurtamento do 4º e 5º metacarpos e metatarsos, face arredondada, obesidade e calcificações subcutâneas com resistência periférica ao PTH.	Pseudo-hipoparatiroidismo / Osteodistrofia Hereditária de Albright.
Obesidade central progressiva rápida, fâcies em lua cheia pletórica, giba dorsal (giba de búfalo), estrias violáceas largas (> 1 cm) e desaceleração do crescimento estatural.	Síndrome de Cushing pediátrica.
Taquicardia sinusal em repouso, bócio difuso tireoidiano palpável com sopro audível, proptose ocular (exoftalmia), tremores finos de extremidades e perda de peso com apetite voraz.	Doença de Graves juvenil / Hipertireoidismo.
Poliúria hipotônica maciça (> 4 mL/kg/h) com densidade urinária muito baixa (< 1005) e osmolaridade urinária < 300 mOsm/kg associada a polidipsia intensa com preferência por água gelada.	Diabetes Insipidus central ou nefrogênico.
Baixa estatura extrema acentuada (desvio-padrão < -3 a -4), fronte olímpica proeminente, raiz nasal afundada, hipoglicemia e níveis séricos muito elevados de GH com níveis indetectáveis de IGF-1.	Síndrome de Laron / Insensibilidade congênita ao hormônio de crescimento (defeito no receptor de GH).
Bócio tireoidiano difuso endurecido e indolor em adolescente associado a elevação de TSH e títulos séricos muito altos de anticorpos anti-TPO (tireoperoxidase) e antitireoglobulina.	Tireoidite de Hashimoto / Tireoidite Linfocítica Crônica juvenil.
Tríade da Síndrome Poliglandular Autoimune tipo 1 (APECED): Candidíase mucocutânea crônica desde a infância, hipoparatiroidismo primário precoce e insuficiência adrenal primária (Doença de Addison).	Síndrome Poliglandular Autoimune tipo 1 (APECED) (mutação no gene AIRE).
Fraturas patológicas ósseas múltiplas com osso excessivamente denso e espesso, modelamento em osso dentro de osso ao RX, pancitopenia por obliteração medular e perda visual/auditiva por estenose de forames.	Osteopetrose infantil maligna (doença de Albers-Schönberg / ossos de mármore por disfunção osteoclástica).
Progressiva ossificação heterotópica dolorosa pós-trauma mínimo com transformação gradual e irreversível de fâscias, tendões e músculos esqueléticos em placas ósseas sólidas associada a hálux valgo congênito curto microdactílico.	Fibrodysplasia Ossificante Progressiva (FOP) (mutação no gene ACVR1).
Pseudoparalisia de membros inferiores por dor óssea extrema ao menor toque, postura em pernas de rã, hemorragias subperiosteas volumosas, gengivite hemorrágica e rosário escorbútico com anel de Wimberger radiológico.	Escorbuto infantil (deficiência grave de Vitamina C / ácido ascórbico).
Tríade clássica da Pelagra dos 3 'Ds': Dermatite fotossensível bem demarcada em colar no pescoço (Colar de Casal) e dorso das mãos, Diarreia crônica com má absorção e Demência / encefalopatia.	Pelagra / Deficiência de Niacina (Vitamina B3).
Insuficiência cardíaca de alto débito com cardiomegalia, taquicardia extrema, edema e congestão pulmonar rápida em lactente alimentado exclusivamente com leite materno de mãe desnutrida.	Beribéri úmido infantil (deficiência aguda grave de Tiamina / Vitamina B1).
Queilite angular (estomatite angular com fissuras nos cantos da boca), glossite com língua vermelho-magenta despapilada e dermatite seborreica nasogeniana.	Arriboflavinose / Deficiência de Vitamina B2 (Riboflavina).
Anemia megaloblástica grave acompanhada de neutrófilos hipersegmentados, hiperpigmentação dos nós dos dedos (juntas das mãos), apatia e hipotonia com regressão motora em filho de mãe vegetariana estrita.	Deficiência congênita/infantil de Vitamina B12 (Cobalamina).
Edema mole com cacifo de início em membros inferiores e face, apatia e indiferença extrema, hepatomegalia esteatótica volumosa e lesões cutâneas descamativas em tinta de esmalte rachada.	Kwashiorkor / Desnutrição proteico-calórica edematosa.
Emagrecimento extremo com perda quase total do panículo adiposo e da massa muscular, fâcies senil ou simiesca, pele enrugada redundante e ausência de edema em lactente faminto.	Marasmo / Desnutrição calórica grave.

13. REUMATOLOGIA, VASCULITES E IMUNODEFICIÊNCIAS PRIMÁRIAS (18 achados clínicos)

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Pápulas de Gottron: Pápulas e placas eritemato-violáceas descamativas sobre a superfície extensora das articulações interfalangianas e metacarpofalangianas das mãos.	Dermatomiosite Juvenil (DMJ) (achado patognomônico).
Eritema heliotrópico: Coloração eritematosa ou violácea sobre as pálpebras superiores e área periorbitária associada a edema palpebral matinal e fraqueza muscular proximal simétrica.	Dermatomiosite Juvenil (DMJ).
Púrpura palpável não trombocitopênica distribuída simetricamente em membros inferiores e nádegas, artrite/artralgia transitória, dor abdominal em cólica e hematúria microscópica.	Vasculite por IgA / Púrpura de Henoch-Schönlein.
Febre diária intermitente cotidiana em agulhas (≥ 2 semanas) acompanhada de exantema macular róseo-salmão evanescente que coincide com o pico térmico, artrite crônica e ferritina muito alta.	Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) Sistêmica.
Artrite crônica persistente por mais de 6 semanas acometendo até 4 articulações (oligoarticular) em meninas com FAN positivo e risco de uveíte anterior crônica insidiosa assintomática.	AIJ Subtipo Oligoarticular (exame rotineiro com lâmpada de fenda obrigatório).
Eritema malar em asa de borboleta cobrindo dorso nasal e bochechas poupando os sulcos nasogenianos, fotossensibilidade intensa, úlceras orais indolores recorrentes e nefrite.	Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil (LESJ).
Fenômeno de Raynaud trifásico (palidez isquêmica, cianose e rubor reativo) associado a esclerodactilia distal, microstomia labial com sulcos radiados periorais e telangiectasias.	Esclerose Sistêmica Juvenil.
Eczema atópico precoce grave e refratário, infecções bacterianas estafilocócicas sinopulmonares e cutâneas de repetição com abscessos frios e níveis séricos de IgE > 2.000 UI/mL.	Síndrome de Hiper-IgE / Síndrome de Job (mutação no gene STAT3).
Linfopenia absoluta grave e persistente (< 1.500 linfócitos/mm³) em lactente jovem com diarreia crônica, monilíase oral refratária e ausência de sombra tímica ao RX de tórax.	Imunodeficiência Combinada Grave (SCID) (emergência pediátrica imunológica).
Ausência total de tecido amigdaliano e adenoide com infecções bacterianas graves por encapsulados após 6 meses de vida com dosagem de IgG, IgA e IgM praticamente indetectáveis.	Agamaglobulinemia ligada ao X / Doença de Bruton (mutação no gene BTK).
Episódios periódicos e previsíveis de febre alta a cada 3-4 semanas com duração de 3-5 dias, acompanhados de estomatite aftosa dolorosa, faringite não estreptocócica e adenite cervical.	Síndrome PFAPA (Febre Periódica, Aftas, Faringite e Adenite).
Úlceras orais dolorosas aftoides recorrentes múltiplas (pelo menos 3 vezes ao ano) associadas a úlceras genitais dolorosas em escroto ou vulva e teste de patergia positivo.	Doença de Behçet juvenil.
Instalação abrupta (minutos a poucas horas) de lesões urticariformes e/ou angioedema associada a colapso respiratório (estridor/sibilância) ou choque circulatório pós-alérgeno.	Anafilaxia (administração imediata de Adrenalina intramuscular).
Poliarterite Nodosa Juvenil (PAN Juvenil): Nódulos subcutâneos inflamatórios dolorosos ao longo do trajeto de artérias de médio calibre, livedo reticular persistente de tronco e membros, dor testicular e isquemia digital com microaneurismas viscerais à arteriografia sem glomerulonefrite.	Poliarterite Nodosa sistêmica da infância.
Arterite de Takayasu na infância (Doença sem pulsos): Criança ou adolescente feminina com claudicação de membros superiores, ausência ou assimetria acentuada de pulsos radiais, sopros vasculares sobre artérias carótidas, subclávias e aorta abdominal com hipertensão renovascular grave.	Arterite de Takayasu juvenil (pan-arterite granulomatosa de grandes vasos).
Granulomatose com Poliangiite Pediátrica (antiga Granulomatose de Wegener): Tríade clínica clássica: 1) sinusopatia necrotizante crônica refratária com perfuração do septo nasal e deformidade em nariz em sela; 2) nódulos pulmonares múltiplos cavitados com hemoptise; 3) glomerulonefrite rapidamente progressiva com anticorpos c-ANCA / anti-PR3 positivos.	Granulomatose com Poliangiite (GPA).
Lúpus Eritematoso Cutâneo Subagudo Neonatal: Lesões eritematosas anulares ou policíclicas fotossensíveis com escamas finas em face ('em máscara de guaxinim') e tronco, associadas a trombocitopenia e bloqueio cardíaco congênito em conceptos de mães com anticorpos anti-Ro/SSA positivos.	Lúpus Eritematoso Neonatal cutâneo (lesões cutâneas envolvem até os 6 meses com o clareamento dos anticorpos maternos).
Síndrome de Ativação Macrofágica (SAM / HLH reumatológica): Febre contínua em agulhas que se torna contínua e sem remissão, queda paradoxal do VHS com aumento explosivo de ferritina (> 5.000 a 10.000 ng/mL), pancitopenia, coagulopatia grave com hipofibrinogenemia, triglicerídeos elevados e hemofagocitose medular em paciente com AIJ sistêmica.	Síndrome de Ativação Macrofágica / Linfo-histiocitose Hemofagocítica secundária (emergência com altíssima letalidade).

14. ORTOPEDIA PEDIÁTRICA, TRAUMATOLOGIA E SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO (29 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Manobra de Ortolani positiva: Sensação tátil e audível de ressalto ('clique') de redução da cabeça femoral para o interior do acetábulo durante a abdução suave do quadril flexionado a 90°.	Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ) (quadril luxado que se reduz à manobra).
Manobra de Barlow positiva: Sensação tátil de descolamento ou subluxação posterior da cabeça femoral para fora do acetábulo durante adução e leve pressão axial posterior.	Displasia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ) (quadril instável luxável).
Sinal de Galeazzi: Desnível de altura dos joelhos com quadris e joelhos flexionados a 90° com a criança em decúbito dorsal plano, associado a assimetria persistente de pregas da coxa e limitação da abdução.	DDQ unilateral com encurtamento relativo aparente do segmento femoral.
Incapacidade aguda de apoiar o membro inferior, febre alta tóxica, recusa de marcha e dor intensa à mínima mobilização passiva articular com quadril em flexão, abdução e rotação externa.	Artrite Séptica do quadril (emergência cirúrgica ortopédica para artrotomia e drenagem imediata).
Claudicação ou recusa de marcha aguda com dor leve no quadril ou coxa, afebril ou febril baixo, bom estado geral , 1 a 2 semanas após virose comum com resolução espontânea em 7 a 10 dias.	Sinovite Transitória do Quadril (diagnóstico de exclusão; critérios de Kocher negativos).
Dor óssea metafisária aguda pontual à palpação digital precisa ('dor à ponta de um dedo'), calor local, febre e recusa de apoio com mobilidade articular passiva inicialmente livre.	Osteomielite Aguda Hematogênica (<i>Staphylococcus aureus</i>).
Dor mecânica referida na face anterior do joelho ou coxa, claudicação e membro posicionado espontaneamente em rotação externa obrigatória com perda total da rotação interna em adolescente com sobrepeso.	Epifisiólise da Cabeça Femoral / Epifisiolistese proximal do fêmur (carga zero imediata).
Claudicação insidiosa, progressiva e pouco dolorosa em menino de 4 a 8 anos , com atrofia da musculatura quadripital, limitação da abdução e da rotação interna do quadril e marcha em Trendelenburg.	Doença de Legg-Calvé-Perthes (osteonecrose avascular idiopática da cabeça femoral).
Dor óssea persistente de forte intensidade com piora nitidamente noturna, sem relação com trauma, que apresenta alívio dramático em minutos após pequenas doses de AAS ou AINES.	Osteoma Osteoide (imagem tomográfica típica com <i>nidus</i> radioluciente cercado por halo esclerótico).
Queda da pelve contralateral ao membro apoiado durante a fase de apoio monopodal da marcha (Sinal e Marcha de Trendelenburg).	Insuficiência mecânica ou fraqueza do músculo glúteo médio (DDQ não corrigida, sequela de Perthes).
Dor localizada e aumento de volume sobre a tuberosidade anterior da tíbia exacerbadas por corridas, saltos, agachamento ou extensão do joelho contrarresistência em adolescente atleta.	Doença de Osgood-Schlatter (apofisite de tração da tuberosidade tibial anterior).
Dor localizada na face posterior e inferior do calcânhar com dor à compressão mediolateral do calcâneo (Sinal do Squeeze positivo) em criança em fase de crescimento rápido.	Doença de Sever (apofisite do calcâneo por tração do tendão de Aquiles).
Braço fletido e pronado rente ao tronco com recusa total de movimentação ativa ('pseudoparalisia antálgica') imediatamente após puxão súbito pelo punho com o braço estendido (sem edema ou deformidade).	Pronação Dolorosa / Subluxação da cabeça do rádio (resolução imediata por supinação e flexão).
Pé torto congênito com equinismo, varismo do retropé, cavo e adução do antepé (C-A-V-E) que é rígido e não se corrige passivamente até a posição anatômica neutra.	Pé Equinovaro Congênito estrutural (tratamento pelo método de Ponseti).
Genu varo acentuado e progressivo unilateral ou assimétrico com angulação abrupta medial da metáfise tibial proximal e bico ósseo metafisário medial ao RX.	Doença de Blount / Tíbia vara congênita (osteocondrose da placa de crescimento tibial medial).
Rigidez matinal articular prolongada (> 30-60 minutos) com claudicação inicial que melhora com a movimentação associada a tumefação articular por mais de 6 semanas consecutivas.	Artrite Idiopática Juvenil (AIJ).
Fratura óssea incompleta com deformidade angular e curvatura visível do osso longo com ruptura da cortical no lado convexo de tensão e cortical intacta no lado côncavo.	Fratura em galho verde (fratura pediátrica por elasticidade óssea).
Abaulamento circunscrito circunferencial com enrugamento ou dobramento da cortical óssea metafisária sem linha de fratura franca visível após queda sobre a mão espalmada.	Fratura em toro / Fratura em fivela (<i>buckle fracture</i>).
Fratura da diáfise da ulna proximal associada a luxação anterior da cabeça do rádio no cotovelo.	Fratura-luxação de Monteggia.
Fratura do terço distal do rádio com luxação e instabilidade da articulação radioulnar distal.	Fratura-luxação de Galeazzi.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Classificação de Salter-Harris das fraturas fisárias pediátricas: Tipo I (separação fisária pura); Tipo II (fise + metáfise / sinal de Thurston-Holland); Tipo III (fise + epífise articular); Tipo IV (epífise, fise e metáfise); Tipo V (compressão/esmagamento fisário).	Fraturas da placa de crescimento fisária (Salter-Harris).
Polegar mantido fixo em flexão da articulação interfalangiana com nódulo palpável indolor na base da polia A1 (Nódulo de Notta) que salta ou trava à extensão passiva.	Polegar em gatilho congênito / Tenossinovite estenosante congênita.
Pé plano rígido doloroso em adolescente com espasmo reflexo dos músculos fibulares e perda completa da mobilidade subtalar que não forma arco plantar nas pontas dos pés.	Coalizão tarsal congênita (barra óssea ou cartilaginosa talocalcânea ou calcaneonavicular).
Deformidade congênita rígida com retropé em equino fixo e antepé em dorsiflexão extrema sobre o dorso do talo com a planta convexa em mata-borrão ao nascimento.	Pé talo vertical congênito.
Ausência congênita unilateral total do músculo peitoral maior (porção esternocostal) associada a braquisindactilia ipsilateral dos dedos da mão e hipoplasia mamária/mamilo.	Síndrome de Poland.
Elevação congênita permanente da escápula com hipoplasia e rotação medial associada à presença de osso omovertebral unindo a escápula à coluna cervical.	Deformidade de Sprengel.
Tríade de Klippel-Feil: Pescoço curto visível, linha de implantação posterior dos cabelos baixa e limitação acentuada da amplitude de movimentos cervicais por fusão congênita de vértebras cervicais.	Síndrome de Klippel-Feil.
Paralisia congênita facial bilateral simétrica (fácies inexpressiva com máscara congelada) associada a estrabismo convergente por paralisia bilateral do VI par ao nascimento.	Síndrome de Moebius.
Assimetria facial congênita com hipoplasia malar unilateral, microtia com apêndices pré-auriculares bilaterais e cistos dermóides epibulbares oculares.	Espectro Óculo-Aurículo-Vertebral / Síndrome de Goldenhar.

15. DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA, FACOMATOSES E GENODERMATOSES (36 achados clínicos)

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Mancha vascular plana em 'vinho do Porto' unilateral estritamente delimitada no território da 1ª divisão do nervo trigêmeo (V1), glaucoma ipsilateral e crises convulsivas.	Síndrome de Sturge-Weber (Angiomatose Encefalotrigeminal).
Máculas hipomelanóticas lanceoladas em 'folha de freixo' (visíveis à luz de Wood), angiofibromas faciais centofaciais (adenoma sebáceo) e rabdomioma cardíaco.	Esclerose Tuberosa (Complexo de Bourneville - mutações nos genes TSC1 ou TSC2).
≥ 6 manchas café-com-leite (> 0,5 cm em pré-púberes ou > 1,5 cm em pós-púberes), efélides em axilas ou virilhas (Sinal de Crowe) e nódulos de Lisch na íris.	Neurofibromatose tipo 1 (NF-1) (Doença de von Recklinghausen).
Schwannomas vestibulares bilaterais do VIII par craniano causando perda auditiva e zumbido, meningiomas e catarata juvenil subcapsular posterior.	Neurofibromatose tipo 2 (NF-2).
Erupção cutânea com evolução clássica em 4 fases ao longo das linhas de Blaschko: 1) vesículas inflamatórias lineares no RN; 2) lesões verrucosas hiperqueratóticas; 3) hiperpigmentação marmórea em espirais; 4) máculas atróficas hipopigmentadas.	Incontinência Pigmentar / Síndrome de Bloch-Sulzberger (ligada ao X dominante letal no sexo masculino).
Descolamento epidérmico de pele aparentemente íntegra sob leve pressão friccional tangencial (Sinal de Nikolsky positivo) com eritema perioral com crostas radiadas em lactente febril sem lesões de mucosas.	Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica (SSSS / Ritter) (toxina esfoliativa A e B).
Descolamento bolhoso extenso de epiderme com necrose de espessura total e acometimento grave e hemorrágico de pelo menos duas mucosas (oral, conjuntival, anogenital) pós-fármaco com Nikolsky positivo.	Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) / Necrólise Epidérmica Tóxica (NET).
Dermatite vesicobolhosa, crostosa e erosiva crônica estritamente periorifical (peribucal, anogenital) e acral (mãos e pés), acompanhada de alopecia difusa e diarreia pós-desmame.	Acrodermatite Enteropática (defeito hereditário na absorção intestinal de Zinco).
Formação espontânea ou pós-trauma mecânico mínimo de bolhas de conteúdo seroso ou hemorrágico na pele e mucosas desde o nascimento com descolamento à simples fricção.	Epidermólise Bolhosa congênita (simples, junctional ou distrófica).
Pápulas eritematosas pruriginosas lineares serpiginosas salientes com progressão diária de alguns milímetros ('túneis móveis') em áreas de contato com areia.	Larva Migrans Cutânea (bicho-geográfico / <i>Ancylostoma braziliense</i>).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Prurido noturno intenso intratável, túneis serpiginosos e pápulas em espaços interdigitais de mãos, punhos e axilas e pápulo-pústulas palmoplantares no lactente.	Escabiose / Sarna humana (<i>Sarcoptes scabiei</i> var. <i>hominis</i>).
Placas alopécicas perfeitamente arredondadas ou ovais lisas sem descamação com visualização de pelos curtos afilados em ponto de exclamação nas bordas de expansão.	Alopecia Areata.
Lesão anular eritematosa única ou múltipla com bordas ativas descamativas elevadas e centro com clareamento relativo com prurido em área glabra.	Tinea corporis / Tinha do corpo (dermatofitose fúngica superficial).
Placa descamativa ovalada única inicial maior ('medalhão-mãe') sucedida após 1 a 2 semanas por exantema em pequenas lesões ovais dispostas ao longo das linhas de clivagem do dorso ('árvore de natal').	Pitíriase Rósea de Gibert.
Recém-nascido envolto ao nascimento por membrana espessa brilhante e rígida com aspecto de colódio ('bebê colódio') com ectrópio palpebral e eclábio.	Ictiose lamelar congênita / Eritrodermia ictiosiforme congênita.
Recém-nascido com carapaça córnea maciça de placas hiperqueratóticas duras poligonais em armadura separadas por fissuras eritematosas profundas, ectrópio e microcefalia aparente.	Ictiose Arlequim (mutação no gene ABCA12 - forma mais severa de genodermatose ictiosiforme).
Tríade da Síndrome de Netherton: Eritrodermia ictiosiforme congênita descamativa, tricurxe invaginata (cabelos em bambu à microscopia) e manifestações atópicas graves com IgE elevada.	Síndrome de Netherton (mutação no gene SPINK5).
Placas hiperqueratóticas aveludadas verrucosas hiperpigmentadas acastanhadas simétricas nas dobras cervicais, axilares e inguinais em criança com obesidade.	Acantose Nigricante (marcador cutâneo clássico de resistência insulínica grave).
Múltiplos pequenos comedões abertos e fechados associados a pápulas inflamatórias eritematosas e pústulas no dorso nasal e bochechas de lactente nas primeiras semanas.	Acne neonatal / Pustulose cefálica neonatal benigna (colonização por <i>Malassezia</i>).
Mancha vascular purpúrica violácea de crescimento rápido explosivo acompanhada de trombocitopenia profunda de consumo e coagulopatia grave.	Fenômeno de Kasabach-Merritt (associado a angioma em tufo ou hemangioendotelioma caposiforme).
Hipertrofia assimétrica esquelética e de tecidos moles de um membro associada a manchas vasculares em vinho do porto e varizes venosas atípicas congênitas.	Síndrome de Klippel-Trenaunay.
Crescimento tecidual desproporcional assimétrico e desordenado de membros, macrodactilia, nevos conjuntivos cerebriformes em plantas dos pés e tumores vasculares hamartomatosos.	Síndrome de Proteus (mutação em mosaico no gene AKT1).
Encondromas múltiplos cartilaginosos intraósseos em mãos e pés associados a hemangiomas cavernosos de tecidos moles e flebólitos calcificados.	Síndrome de Maffucci.
Placa alopécica amarelada ou alaranjada discretamente elevada, lisa ou verrucosa presente desde o nascimento no couro cabeludo que se torna verrucosa na puberdade.	Nevo sebáceo de Jadassohn (risco de transformação neoplásica tardia).
Nódulos cutâneos eritemato-acastanhados na infância que desenvolvem urticária local imediata com eritema e edema após fricção mecânica (Sinal de Darier positivo).	Mastocitose cutânea / Urticária Pigmentosa.
Pápulas poligonais violáceas pruriginosas brilhantes com estrias finas esbranquiçadas superficiais (Estrias de Wickham) em punhos, tornozelos e mucosa oral.	Líquen Plano infantil.
Síndrome de McCune-Albright cutânea: Manchas café-com-leite extensas unilaterais com bordas denteadas e serrilhadas muito irregulares comparadas à 'costa recortada da Califórnia' que respeitam estritamente a linha média sagital.	Síndrome de McCune-Albright (mutação somática pós-zigótica no gene GNAS).
Hipomelanose de Ito (Incontinência Pigmentar Acromiante): Máculas hipomelanóticas em espirais, bandas e faixas curvilíneas ao longo das linhas embrionárias de Blaschko presentes ao nascimento ou primeiros meses, associadas a convulsões e retardo motor.	Hipomelanose de Ito (mosaicismo cromossômico somático cutâneo-neural).
Nevos sebáceos múltiplos associados a crises convulsivas intratáveis, retardo mental grave e coloboma ocular (Síndrome de Schimmelpenning-Feuerstein):	Síndrome do Nevo Sebáceo Linear.
Acrodermatite enteropática adquirida transitória: Erupção eczematosa descamativa e erosiva periorifical e acral idêntica à forma genética que surge em prematuro extremo recebendo nutrição parenteral total sem reposição de oligoelementos.	Deficiência iatrogênica aguda de Zinco (resolução dramática pós-suplementação de zinco elementar).
Ictiose ligada ao cromossomo X: Escamas cutâneas grandes, espessas, poligonais, de coloração castanho-escura ou negra ('aspecto de pele suja') no pescoço, tronco e superfícies extensoras poupando palmas e plantas, com história de parto distóxico por retenção placentária.	Deficiência de Esteril-Sulfatase ligada ao X (STS).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Síndrome de Papillon-Lefèvre: Hiperkeratose palmoplantar difusa com placas eritematosas descamativas que se estendem aos dorsos das mãos e pés ('em luva e meia') associada a periodontite agressiva grave e precoce com perda completa de todos os dentes deciduos e permanentes.	Síndrome de Papillon-Lefèvre (mutação na cathepsina C - CTSC).
Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (tipo Hallopeau-Siemens): Bolhas hemorrágicas generalizadas que cicatrizam com fibrose destrutiva grave resultando em fusão completa dos quirodáctilos em 'mão em casulo / mão em luva' (pseudosindactília), estenose esofágica e microstomia.	Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (mutação no colágeno tipo VII - COL7A1).
Pênfigo Neonatal Transitório: Erupção bolhosa flácida superficial estéril com Sinal de Nikolsky positivo no recém-nascido filho de mãe portadora de Pênfigo Vulgar.	Passagem transplacentária passiva de autoanticorpos IgG maternos anti-desmogleína 3 (autolimitado com o clareamento dos anticorpos maternos em semanas).
Granuloma anular infantil: Pápulas ou placas anulares firmes dérmicas da cor da pele ou eritematosas com bordas elevadas em rosário e centro plano não descamativo no dorso de mãos e pés.	Granuloma Anular clássico localizado (condição benigna inflamatória autolimitada).
Eritema nodoso pediátrico: Nódulos subcutâneos inflamatórios eritematosos, quentes, brilhantes, extremamente dolorosos à palpação, localizados preferencialmente na face anterior das tíbias bilateralmente.	Paniculite septal inflamatória reativa (investigar infecção estreptocócica recente, tuberculose, doença inflamatória intestinal ou sarcoidose).

16. OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA E VIAS LACRIMAIS (19 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Leucocoria: Reflexo pupilar esbranquiçado à oftalmoscopia direta ou ausência do reflexo vermelho normal retiniano (Teste do Olhinho alterado).	Retinoblastoma até prova em contrário (diagnósticos diferenciais: catarata congênita, retinopatia da prematuridade, doença de Coats, toxocaríase ocular).
Tríade do Glaucoma Congênito: Epífora (lacrimejamento excessivo sem secreção purulenta), fotofobia intensa com blefaroespasmos e aumento patológico do diâmetro corneano (> 12 mm / buftalmia / 'olho de boi').	Glaucoma Congênito Primário (emergência para cirurgia antes de perda visual definitiva).
Epífora contínua unilateral ou bilateral com refluxo mucopurulento crônico ao saco lacrimal à compressão do canto medial do olho em lactente nos primeiros meses de vida.	Obstrução congênita do ducto nasolacrimal (persistência da válvula de Hasner).
Edema e eritema palpebral unilateral associados a dor intensa à mobilização ocular, proptose ocular e oftalmoplegia (limitação da motilidade extrínseca) com febre.	Celulite Orbitária pós-septal (diferencial crítico de celulite pré-septal, que não tem dor à movimentação, proptose ou oftalmoplegia).
Tríade de Horner pediátrica: Ptose palpebral unilateral parcial, miose pupilar com anisocoria que piora no escuro, anidrose facial ipsilateral e heterocromia de íris se lesão congênita.	Síndrome de Horner (investigar Neuroblastoma paravertebral/torácico ou trauma de parto).
Estrabismo convergente novo e súbito acompanhado de diplopia horizontal que piora com o olhar para o lado da lesão por paralisia do músculo reto lateral (VI par).	Paralisia do VI par craniano por Hipertensão Intracraniana / Falso sinal localizatório.
Midríase unilateral paralítica fixa associada a ptose palpebral e olho desviado para baixo e para fora (estrabismo divergente com ação intacta do IV e VI pares).	Paralisia do III par craniano / Compressão de III par por herniação uncal.
Perda visual súbita unilateral dolorosa que piora com a mobilização ocular, defeito pupilar aferente relativo (Pupila de Marcus Gunn) e edema de papila.	Neurite Óptica aguda / Doença desmielinizante (EM ou MOGAD).
Depósitos de manchas esbranquiçadas ceratinizadas espumosas triangulares na conjuntiva bulbar exposta (Manchas de Bitot) associadas a hemeralopia (cegueira noturna) e xerose corneana.	Hipovitaminose A / Xeroftalmia.
Doença de Coats infantil: Leucocoria unilateral com telangiectasias retinianas aneurismáticas tortuosas em 'lâmpada elétrica', exsudação sub-retiniana lipídica volumosa amarelada maciça e descolamento exsudativo de retina em meninos de 4 a 8 anos.	Doença de Coats (vasculopatia retiniana idiopática congênita; principal diagnóstico diferencial benigno do retinoblastoma).
Persistência Hiperplásica do Vítreo Primitivo (PHVP / Vasculatura Fetal Persistente): Leucocoria congênita unilateral associada a microftalmia leve, câmara anterior rasa e visualização de massa retrolenticular fibrovascular com processos ciliares alongados tracionados centralmente.	Persistência da Vasculatura Fetal congênita.
Retinopatia da Prematuridade (ROP) estágio 3 plus: Proliferação fibrovascular extrarretiniana na junção entre a retina vascularizada e avascular acompanhada de dilatação arteriolar e tortuosidade venosa marcantes no polo posterior ('doença plus').	Retinopatia da prematuridade grave com indicação de laserterapia ou anti-VEGF.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Toxocaríase ocular (Granuloma ocular de Toxocara): Leucocoria com granuloma sub-retiniano esbranquiçado arredondado periférico ou macular com bandas vítreas de tração tracionando a papila óptica em criança pré-escolar com contato com filhotes de cães.	Toxocaríase ocular por <i>Toxocara canis</i>.
Dacriocistocele congênita (Mucocelo do saco lacrimal): Tumeção cística azulada tensa e indolor localizada logo abaixo do tendão cantal medial no canto interno do olho presente logo após o nascimento, com obstrução nasal ipsilateral.	Obstrução congênita concomitante superior e inferior do ducto nasolacrimal.
Síndrome de Brown congênita: Incapacidade de elevação do olho em adução com elevação normal do globo ocular em abdução decorrente de anormalidade estrutural da bainha do tendão do músculo oblíquo superior.	Síndrome da bainha do tendão oblíquo superior de Brown.
Fenômeno de Marcus Gunn (Piscamento Mandibular de Marcus Gunn): Ptose palpebral congênita unilateral na qual a pálpebra caída se eleva ritmicamente em retração súbita quando a criança abre a boca, suga ou movimenta a mandíbula lateralmente.	Sincinesia anômala congênita entre o nervo trigêmeo motor (V par) e o ramo oculomotor do levantador da pálpebra (III par).
Pupila Tônica de Adie infantil: Midríase unilateral com reação fotomotora à luz quase ausente e constrição lenta e tônica sustentada à visão de perto (dissociação luz-perto) com hipersensibilidade de denervação à pilocarpina diluída a 0,1%.	Pupila tônica de Adie.
Neurorretinite de Leber pós-doença da arranhadura do gato: Perda visual unilateral súbita com edema da cabeça do nervo óptico e surgimento subsequente de estrela macular clássica formada por exsudatos lipídicos na camada de Henle.	Neurorretinite por <i>Bartonella henselae</i>.
Coloboma coriorretiniano e de papila: Falha congênita de fechamento da fissura embrionária óptica manifestando-se como área esbranquiçada escavada de fundo escleral desnudo no setor nasal inferior da retina.	Coloboma congênito (marcador das síndromes CHARGE, Kabuki e trissomia 13).

17. EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS, TOXICOLOGIA E ACIDENTES POR PEÇONHENTOS (24 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Dor local lancinante imediata, sudorese profusa, sialorreia intensa, vômitos incoercíveis, taquicardia seguida de bradicardia e edema agudo de pulmão em criança picada por escorpião amarelo.	Escorpionismo grave (<i>Tityus serrulatus</i> - indicação de Soro Antiescorpiônico IV).
Dor local que se intensifica após várias horas, edema endurecido com placa marmórea (áreas pálidas de isquemia intercaladas por livedo) e bolha hemorrágica que evolui para escara necrótica.	Loxoscelismo cutâneo / Picada de Aranha-marrom (<i>Loxosceles</i>).
Loxoscelismo cutâneo-visceral: Placa marmórea necrótica associada a hemólise intravascular aguda grave, icterícia rubínica, hemoglobínúria ('urina cor de coca-cola') e insuficiência renal aguda.	Loxoscelismo víscero-hemolítico (forma sistêmica grave).
Dor local intensa, edema inflamatório rápido, equimoses, sangramento no local da picada ou gengivorragia com incoagulabilidade sanguínea após picada de serpente.	Acidente Botrópico / Picada de Jararaca (<i>Bothrops</i> - veneno proteolítico, coagulante e hemorrágico).
Dor local mínima ou ausente, fâscies miastênica de Rosenfeld (ptose palpebral bilateral, oftalmoplegia, diplopia), mialgia generalizada com urina escura acastanhada por rabdomiólise.	Acidente Crotálico / Picada de Cascavel (<i>Crotalus durissus</i> - neurotóxico e miotóxico).
Fâscies miastênica precoce com ptose palpebral, diplopia, disfagia intensa, paralisia de musculatura respiratória e parada respiratória por bloqueio pré-sináptico de placa.	Acidente Elapídico / Picada de Coral Verdadeira (<i>Micrurus</i>).
Dor local extrema imediata com sensação de agulhadas elétricas, sudorese no membro picado, priapismo doloroso sustentado, tremores e edema pulmonar após contato com aranha em bananeira.	Foneutrismo / Picada de Aranha-armadeira (<i>Phoneutria</i>).
Dor em queimação imediata violenta e eritema com desenho linear exato que reproduz a lagarta ('queimadura por taturana') com sangramento espontâneo difuso pós-contato.	Lononismo / Acidente por lagarta <i>Lonomia</i> (coagulopatia de consumo maciça e risco de hemorragia intracraniana).
Intoxicação por Paracetamol em 4 fases: 1) náuseas/vômitos nas primeiras 24h; 2) falsa melhora (24-48h) com elevação de transaminases; 3) pico de necrose hepática (72-96h) com icterícia e coagulopatia; 4) recuperação ou óbito.	Intoxicação Aguda por Paracetamol (antídoto: N-Acetilcisteína - NAC idealmente < 8 horas).
Vômitos precoces esverdeados/sanguinolentos, dor abdominal intensa, diarreia e hemorragia digestiva, sucedidos por choque e posterior estenose pilórica cicatricial tardia pós-ingestão de suplemento de ferro.	Intoxicação Aguda por Sulfato Ferroso (antídoto: Desferroxamina).

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Sonolência profunda, ataxia, fala arrastada, hipotonia e miose com preservação relativa dos sinais vitais após ingestão acidental de calmante em ambiente domiciliar.	Intoxicação por Benzodiazepínicos (antídoto específico: Flumazenil).
Alargamento do complexo QRS (> 100-120 ms), taquicardia ventricular, onda R proeminente em aVR e prolongamento de QTc associados a convulsões e coma pós-ingestão medicamentosa.	Intoxicação por Antidepressivos Tricíclicos (tratamento: Bicarbonato de Sódio IV).
Triângulo de Avaliação Pediátrica (TEP) - Aparência / Estado Geral alterado: Olhar vago sem fixação, choro fraco ou gemência, inconsolabilidade extrema, tônus muscular flácido ou hipotônico e falta de interação com os pais.	Disfunção primária de Sistema Nervoso Central (hipóxia cerebral grave, hipoglicemia, sepse grave, choque descompensado ou hipertensão intracraniana).
Triângulo de Avaliação Pediátrica (TEP) - Respiração alterada isolada com aparência e circulação normais: Taquipneia, tiragem intercostal/subcostal, batimento de asa nasal e ruídos respiratórios anormais (estridor ou sibilos).	Desconforto respiratório compensado (manutenção da oxigenação cerebral sem falência sistêmica instalada).
Triângulo de Avaliação Pediátrica (TEP) - Circulação alterada com palidez cutânea, pele marmórea/acinzentada e cianose central com respiração normal e aparência alterada:	Choque descompensado / Falência circulatória sistêmica.
Triângulo de Avaliação Pediátrica (TEP) - Os 3 lados alterados simultaneamente (Aparência anormal + Esforço respiratório grave ou bradipneia + Circulação colapsada):	Insuficiência Cardiorrespiratória Iminente / Parada Cardiorrespiratória iminente (indicação imediata de via aérea avançada, ventilação com pressão positiva e suporte circulatório).
Choque Séptico 'Frio' Pediátrico (mais comum na infância): Extremidades frias e mosqueadas, tempo de enchimento capilar > 3 segundos, pulsos periféricos débeis e filiformes com pressão de pulso convergente (PAD próxima da PAS).	Choque com baixo débito cardíaco e alta resistência vascular sistêmica (vasoativo de escolha: Epinefrina / Adrenalina em infusão contínua).
Choque Séptico 'Quente' Pediátrico: Extremidades quentes e hiperemiadas, tempo de enchimento capilar em 'flash' (< 1 segundo), pulsos periféricos amplos e saltatórios com pressão de pulso divergente (PAD baixa) e taquicardia extrema.	Choque com alto débito cardíaco e vasoplegia com baixa resistência vascular sistêmica (vasoativo de escolha: Norepinefrina / Noradrenalina contínua).
Parada Cardiorrespiratória em Pediatria com ritmos não chocáveis (Atividade Elétrica Sem Pulso - AESP e Assistolia): Criança sem pulso central (braquial no lactente ou carotídeo/femoral na criança) com ritmo organizado lento ou linha reta ao monitor.	Ritmos de PCR mais frequentes na infância (> 85-90% dos casos) decorrentes de hipóxia prolongada e acidose grave (administração imediata de Adrenalina 0,01 mg/kg a cada 3-5 minutos e RCP de alta qualidade 15:2 com 2 socorristas).
Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular sem pulso (TVSP) em criança: Ritmo caótico desorganizado sem complexos QRS identificáveis ou taquicardia de QRS largo monomórfica rápida sem pulso central palpável.	Ritmos chocáveis em pediatria (10-15%) (desfibrilação elétrica imediata: 1º choque com 2 J/kg; 2º choque com 4 J/kg; choques subsequentes com ≥ 4 J/kg até máximo de 10 J/kg).
Desidratação Hipernatrêmica grave (Na+ > 150-160 mEq/L): Sede insaciável desesperada, irritabilidade alternada com letargia, pele pastosa com turgor gomoso falso (perda da elasticidade clássica com sensação de massa de pão) e alto risco de trombose de seios venosos cerebrais e hemorragia subdural.	Desidratação Hipernatrêmica (correção hidroeletrólítica obrigatoriamente lenta em 48 horas com queda máxima de sódio de 0,5 mEq/L/hora para evitar edema cerebral iatrogênico fatal).
Desidratação Hiponatrêmica grave (Na+ < 125-130 mEq/L): Sinais de choque hipovolêmico desproporcionais às perdas hídricas gastrointestinais, extremidades frias, rebaixamento rápido do sensorio e crises convulsivas generalizadas de difícil controle refratárias a anticonvulsivantes.	Hiponatremia sintomática com edema cerebral agudo (tratamento emergencial: Cloreto de Sódio a 3% na dose de 2 a 5 mL/kg IV em 10-15 minutos).
Síndrome de Secreção Inapropriada de Hormônio Antidiurético (SIADH): Hiponatremia hiposmolar euvolêmica (sem edema e sem hipotensão arterial) associada a osmolaridade urinária inapropriadamente elevada (> 100 mOsm/kg) e sódio urinário elevado (> 20-40 mEq/L) em criança com neuroinfecção ou pneumonia.	SIADH pediátrica (tratamento de base: restrição hídrica rigorosa).
Síndrome Perdedora de Sal Cerebral (CSWS): Hiponatremia hipovolêmica grave com desidratação clínica franca, perda urinária maciça de sódio e água (poliúria) e pressão venosa central muito baixa em criança pós-trauma craniano ou cirurgia de tumor cerebral.	Síndrome Perdedora de Sal de origem central (diferencial crucial de SIADH: o tratamento é reposição volêmica vigorosa com sal e soro salino isotônico, e NUNCA restrição hídrica).

18. TRIAGEM DE VIOLÊNCIA FÍSICA E TRAUMA NÃO ACIDENTAL (MAUS-TRATOS) (23 achados clínicos)	
ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Fraturas metafisárias clássicas em 'canto de fratura' (corner fracture) ou em 'alça de balde', fraturas de arcos costais posteriores ou fraturas em diferentes estágios de consolidação em lactente não deambulador.	Trauma Físico Abusivo / Maus-tratos infantis (altamente sugestivo de violência mecânica de torção/tração).
Tríade do Trauma Craniano Abusivo: Hemorragias retinianas extensas multilaminares periféricas bilaterais, hematoma subdural inter-hemisférico ou de convexidade e encefalopatia grave inexplicada desproporcional à história.	Trauma Craniano Abusivo / Síndrome do Bebê Sacudido.
Equimoses em áreas anatômicas protegidas (regra TEN-4 FACES: tronco, orelhas, pescoço em < 4 anos ou qualquer hematoma em lactente < 4 meses) ou que decalcam a forma de objetos (fivelas, fios).	Lesão intencional por violência física infantil.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Queimadura térmica uniforme em 'luva' ou 'meia' com borda superior nítida perfeitamente transversal sem marcas de respingo e com preservação de pregas de flexão.	Queimadura intencional por imersão forçada em água esquentada.
Triade toxidrômica opioide: Miose pupilar puntiforme bilateral, depressão respiratória grave com bradipneia/apneia e coma / rebaixamento do nível de consciência.	Síndrome Opioide (antídoto específico imediato: Naloxona).
Midríase acentuada bilateral, pele e mucosas secas e quentes, rubor facial ('vermelho como beterraba'), hipertermia, retenção urinária aguda com bexigoma e delírio agitado.	Síndrome Anticolinérgica (atropina, escopolamina, anti-histamínicos H1 clássicos, antidepressivos tricíclicos).
Salivação copiosa (sialorreia), lacrimejamento, broncorreia abundante com roncocalcos e estertores difusos ('pulmão afogado'), miose, diarreia aquosa e fasciculações musculares.	Síndrome Colinérgica (intoxicação por organofosforados ou carbamatos / 'chumbinho'; antídoto: Atropina).
Clônus espontâneo ou induzido, hiperreflexia patológica difusa (predomínio em MMII), rigidez muscular, hipertermia maligna, diaforese profusa e tremor em uso de pró-serotoninérgicos.	Síndrome Serotoninérgica.
Hiperventilação profunda rápida (taquipneia tipo Kussmaul), febre, zumbidos nos ouvidos (tinnitus), vômitos e distúrbio misto com alcalose respiratória precoce e acidose de ânion gap elevado.	Intoxicação aguda por Salicilatos (Ácido Acetilsalicílico - AAS).
Cianose central intensa refratária a O₂ a 100% com saturação de pulso em torno de 85% e sangue venoso/arterial de coloração castanho-escura em 'chocolate' que não se torna vermelho ao ar.	Metemoglobinemia adquirida (induzida por dapsona, sulfas, anestésicos tópicos; antídoto: Azul de Metileno).
Taquicardia extrema com pulso filiforme, hipotensão arterial súbita, tempo de enchimento capilar > 3 segundos, oligúria e extremidades frias e mosqueadas pós-politrauma ou desidratação.	Choque hipovolêmico descompensado (ressuscitação volêmica imediata com cristalóide a 20 mL/kg).
Febre ou hipotermia associada a pulsos periféricos amplos, taquicardia, pele quente e tempo de enchimento capilar hiperdinâmico (< 1 segundo / flash) seguido de hipotensão e letargia.	Choque Séptico distributivo precoce ('choque quente').
Quadro súbito de estridor laringeo inspiratório após brincadeira com peças pequenas em pré-escolar que evolui para afonia total e sinal universal de asfixia (levar as mãos ao pescoço).	Obstrução Completa de Via Aérea por Corpo Estranho (manobra de desobstrução imediata: manobra de Heimlich ou golpes dorsais/compressões torácicas no lactente).
Queimaduras por ponta de cigarro: Lesões ulceradas perfeitamente circulares, escavadas em soco, medindo de 8 a 10 mm de diâmetro, com profundidade homogênea de espessura total e crostas escuras, frequentemente múltiplas e agrupadas em palmas, plantas ou genitália.	Queimadura intencional abusiva por contato térmico direto.
Hematoma intramural de duodeno pós-trauma contuso: Vômitos biliosos incoercíveis de início 24 a 48 horas após trauma contuso no epigástrico (ex.: golpe com o punho fechado ou guidão) com radiografia/TC mostrando obstrução mecânica duodenal e massa em aspecto de 'mola espiral' (<i>coiled spring sign</i>).	Trauma abdominal contuso com hematoma duodenal (investigar agressão física abusiva em menores de 4 anos).
Laceração isolada do freio labial superior ou inferior em lactente não deambulador (< 9 meses): Sangramento oral agudo com laceração evidente da fixação do freio labial à gengiva sem dentes erupcionados.	Trauma orofacial não acidental por alimentação forçada violenta com mamadeira ou colher.
Intoxicação por Monóxido de Carbono (CO): Cefaleia pulsátil, tontura, náuseas, confusão mental, acidose metabólica e coloração vermelho-cereja característica brilhante da pele e mucosas (achado clássico post-mortem ou em intoxicação gravíssima) após exposição a aquecedores ou incêndio em ambiente fechado.	Intoxicação Aguda por Monóxido de Carbono (níveis séricos de Carboxihemoglobina - COHb elevados; tratamento imediato: Oxigênio normobárico a 100% ou oxigenoterapia hiperbárica).
Intoxicação Aguda por Cianeto: Acidose láctica extrema refratária com hiato aniônico maciço, colapso circulatório imediato, coma, convulsões, sangue venoso de coloração vermelho vivo arterializado e odor penetrante de amêndoas amargas no ar expirado.	Intoxicação Aguda por Cianeto pós-inalação de fumaça de queima de plásticos/espumas (antídoto de primeira linha: Hidroxocobalamina intravenosa).
Intoxicação por Cáusticos - Ácidos vs. Álcalis: Álcalis (soda cáustica, desentupidores) causam necrose de liquefação profunda transmural com alto risco de perfuração imediata esofágica; Ácidos causam necrose de coagulação com escara protetora superficial e lesão predominantemente gástrica.	Ingestão cáustica esofagogastrica aguda (contraindicação estrita a agentes neutralizantes, êmese e lavagem gástrica).
Ingestão de ímãs múltiplos de alta potência (neodímio): Criança que engoliu duas ou mais peças magnéticas pequenas que se atraem através das paredes de alças intestinais adjacentes levando a isquemia transmural por pressão, necrose e fístula enteroentérica ou perfuração com peritonite aguda.	Corpo estranho magnético múltiplo gastrointestinal (indicação de intervenção cirúrgica / endoscópica urgente).
Afogamento pediátrico com reflexo de mergulho mamífero ativado: Lactente ou criança submersa em água gelada (< 5°C) que apresenta apneia reflexa imediata, bradicardia intensa, vasoconstrição periférica extrema com preservação do fluxo cerebral e coronariano, permitindo sobrevida neurológica intacta após ressuscitação prolongada.	Reflexo de imersão mamífero protetor no quase-afogamento em água fria.

ACHADO CLÍNICO PATOGNOMÔNICO / ALTAMENTE DISCRIMINATIVO	DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS, DIFERENCIAIS E FISIOPATOLOGIA
Síndrome do Bebê Sacudido com avulsão meníngea inter-hemisférica: Hematoma subdural laminar ao longo da foice cerebral inter-hemisférica sem trauma ósseo craniano externo visível associado a hemorragias retinianas extensas.	Trauma Craniano Abusivo por mecanismo acelerativo-desacelerativo rotacional puro .
Fraturas metafisárias em alça de balde (Bucket handle fracture) aos raios X: Pequeno fragmento ósseo curvo em meia-lua destacado da borda cortical da metáfise após forças vigorosas de torção e tração axial de membros.	Fratura metafisária clássica (CML) de alta especificidade para trauma abusivo infantil .